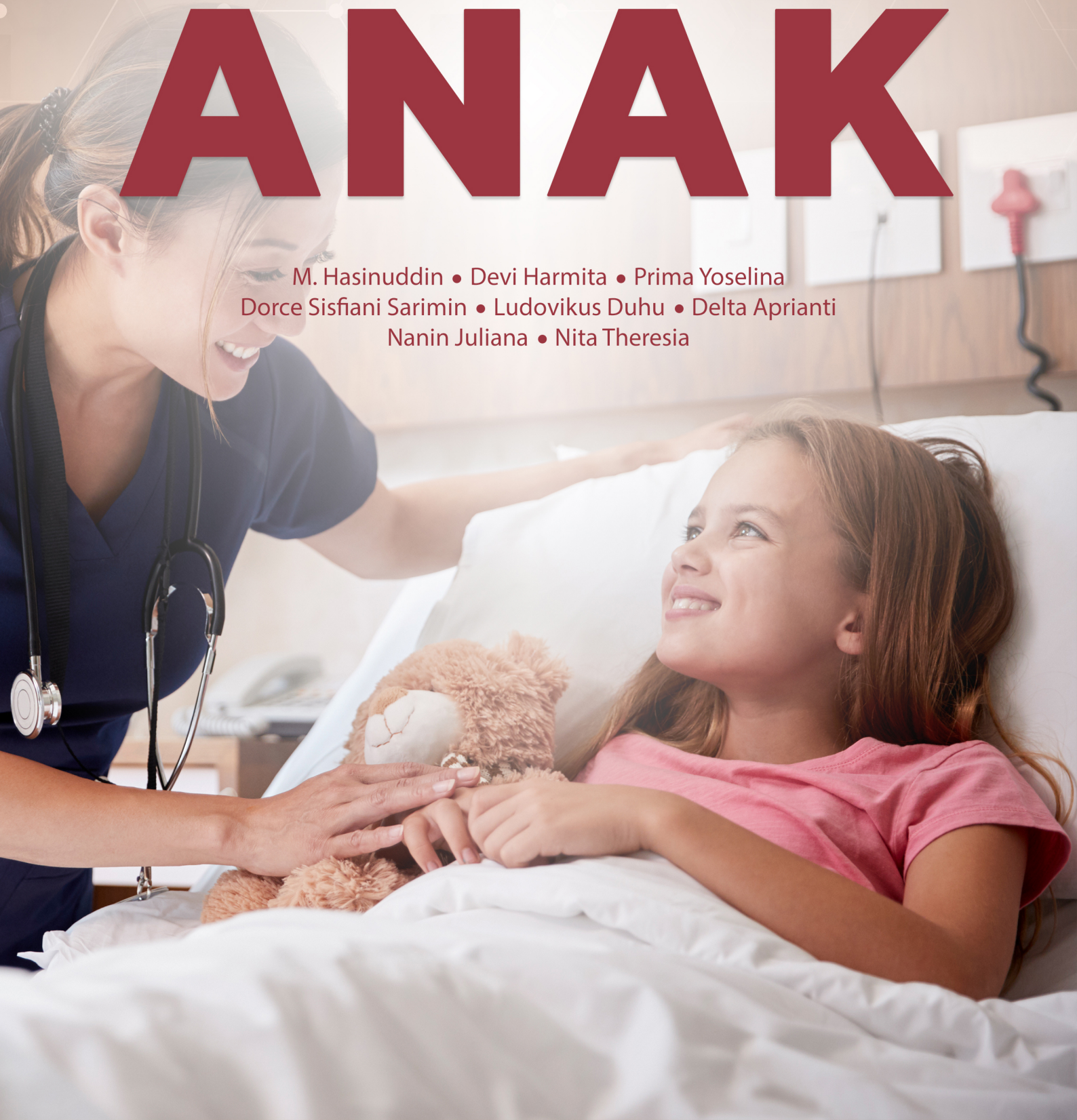


Buku Ajar
**KEPERAWATAN
ANAK**

M. Hasinuddin • Devi Harmita • Prima Yoselina
Dorce Sisfiani Sarimin • Ludovikus Duhu • Delta Aprianti
Nanin Juliana • Nita Theresia



BUKU AJAR KEPERAWATAN ANAK

Penulis:

Prof. Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep.
Devi Harmita, S.Tr., Ners., M.Kep.
Ns. Prima Yoselina, S.Kep., M.Kep.
Dorce Sisfiani Sarimin, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An.
Ns. Ludovikus Duhu, M.Kep.
Ns. Delta Aprianti, S.Kep., M.Kep.
Nanin Juliana, S.Kep., Ns., M.K.M.
Ns. Nita Theresia, S.Kep., M.Kes.

BUKU AJAR KEPERAWATAN ANAK

Penulis: Prof. Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep.
Devi Harmita, S.Tr., Ners., M.Kep.
Ns. Prima Yoselina, S.Kep., M.Kep.
Dorce Sisfiani Sarimin, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An.
Ns. Ludovikus Duhu, M.Kep.
Ns. Delta Aprianti, S.Kep., M.Kep.
Nanin Juliana, S.Kep., Ns., M.K.M.
Ns. Nita Theresia, S.Kep., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7294-23-4

Cetakan Pertama: Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku Ajar Keperawatan Anak ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memberikan panduan lengkap dan sistematis bagi mahasiswa keperawatan serta praktisi keperawatan anak dalam memahami berbagai aspek penting yang terkait dengan perawatan anak. Mulai dari filosofi dasar hingga berbagai prosedur keperawatan terkini, buku ini dirancang secara komprehensif agar pembaca mampu mengaplikasikan ilmu keperawatan secara efektif dan humanis dalam praktik klinis sehari-hari.

Buku ini terdiri dari delapan bab yang mencakup berbagai topik esensial dalam keperawatan anak, seperti filosofi, prinsip dasar, hingga tren dan isu terkini yang dihadapi dalam praktik keperawatan anak. Materi penting seperti Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), asuhan keperawatan berdasarkan Neonatus Essensial, gangguan eliminasi patologis, prosedur screening tumbuh kembang, serta asuhan khusus bagi anak dengan gangguan sistem persyarafan dan muskuloskeletal turut dijelaskan secara detail. Tidak ketinggalan pula pembahasan tentang konsep keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus, yang dilengkapi dengan pendekatan kolaboratif multidisiplin.

Harapan kami, buku ini mampu menjadi sumber referensi utama yang tidak hanya memperkaya wawasan teori tetapi juga menguatkan keterampilan klinis pembaca. Kami menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Tuhan, sehingga kami sangat terbuka atas segala masukan konstruktif demi perbaikan buku ini di masa mendatang. Semoga kehadiran buku ini memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan keperawatan anak di Indonesia.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PERAN PERAWAT ANAK.....	1
A. Filosofi Keperawatan Anak	4
B. Prinsip Keperawatan Anak	9
C. Ruang Lingkup Praktik Keperawatan Anak.....	9
D. Peran Perawat anak dalam Keperawatan Anak.....	10
E. Latihan Soal !.....	11
F. Rangkuman Materi	14
G. Glosarium.....	15
H. Daftar Pustaka.....	15
BAB 2 TREND DAN ISSUE KEPERAWATAN ANAK	17
A. Isu-Isu Kontemporer Dalam Keperawatan Anak	20
B. Peran Perawat dalam Mengatasi Masalah Kesehatan Anak	21
C. Tantangan dan Peluang dalam Keperawatan Anak	23
D. Perkembangan Kebijakan dan Regulasi dalam Keperawatan Anak.....	24
E. Inovasi dan Teknologi dalam Keperawatan Anak.....	25
F. Kolaborasi Interprofesional dalam Keperawatan Anak.....	26
G. Tren dalam Praktik Keperawatan Anak.....	28
H. Riset dan Inovasi dalam Keperawatan Anak	30
I. Penutup	32
J. Latihan	32
K. Glosarium.....	33
L. Daftar Pustaka.....	33
BAB 3 MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT DI TATANAN PELAYANAN KESEHATAN	35
A. Definisi MTBS	37
B. Strategi dan Penerapan MTBS	37
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan MTBS	38
D. Langkah-Langkah Dalam Melakukan MTBS.....	39

E. Penilaian, Klasifikasi, Tindakan/ Pengobatan Manajemen Terpadu Balita Sakit	39
F. Latihan Soal	55
G. Rangkuman Materi	59
H. Glosarium.....	60
I. Daftar Pustaka.....	61

BAB 4 PROSEDUR PELAKSANAAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA BAYI BERDASARKAN NEONATUS ESSENSIAL..... 63

A. Neonatus Essensial	65
B. Prosedur Asuhan Keperawatan Berdasarkan Neonatus Esensial	67
C. Prinsip Prinsip Pencegahan Infeksi Pada Bayi Baru Lahir.....	74
D. Komunikasi Efektif dengan Ibu dan Keluarga.....	76
E. Pendokumentasian Asuhan Keperawatan.....	79
F. Latihan Soal	82
G. Rangkuman Materi	83
H. Glosarium.....	84
I. Daftar Pustaka.....	85

BAB 5 KONSEP ASUHAN KEPERAWATAN PADA BAYI DAN ANAK DENGAN GANGGUAN KEBUTUHAN ELIMINASI PATOLOGIS DARI SISTEM PENCERNAAN DAN KEMIH/KELAINAN KONGENITAL/PERIOPERATIF CARE.. 87

A. Konsep Dasar Gangguan Eliminasi pada Bayi dan Anak.....	89
B. Pengkajian Keperawatan pada Gangguan Eliminasi.....	90
C. Diagnosa Keperawatan	91
D. Perencanaan dan Intervensi Keperawatan.....	93
E. Evaluasi Asuhan Keperawatan.....	95
F. Asuhan Perioperatif pada Bayi dan Anak	97
G. Latihan Soal	100
H. Rangkuman Materi	102
I. Glosarium.....	103
J. Daftar Pustaka.....	105

BAB 6 PROSEDUR SCREENING TUMBUH KEMBANG PADA ANAK..... 107

A. Konsep Dasar Screening Tumbuh Kembang Anak.....	109
B. Instrumen atau Alat Ukur yang Digunakan	110
C. Langkah-langkah Prosedur Screening Tumbuh Kembang.....	113
D. Interpretasi Hasil dan Rekomendasi Tindak Lanjut	115

E. Latihan Soal	117
F. Rangkuman Materi	120
G. Glosarium.....	120
H. Daftar Pustaka.....	123

BAB 7 KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN GANGGUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN AKTIVITAS PATOLOGIS DARI SISTEM PERSYARAFAN DAN MUSKULOSKELETAL.....125

A. Anatomi dan Fisiologi Dasar Sistem Persyarafan dan Muskuloskeletal.....	127
B. Patofisiologi dan Manifestasi Klinis Gangguan Sistem Persyarafan dan Muskuloskeletal pada Anak	128
C. Pengkajian Keperawatan	130
D. Diagnosis Keperawatan.....	132
E. Perencanaan dan Implementasi Intervensi Keperawatan	135
F. Latihan Soal	137
G. Rangkuman Materi	139
H. Glosarium.....	140
I. Daftar Pustaka.....	142

BAB 8 KONSEP ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS145

A. Definisi dan Karakteristik Anak dengan Kebutuhan Khusus.....	147
B. Jenis-jenis Kebutuhan Khusus pada Anak.....	148
C. Pengkajian Keperawatan pada Anak dengan Kebutuhan Khusus.....	150
D. Diagnosis Keperawatan.....	152
E. Perencanaan dan Implementasi Intervensi Keperawatan	154
F. Evaluasi Keperawatan	156
G. Kolaborasi Multidisiplin	157
H. Latihan Soal	159
I. Rangkuman Materi	162
J. Glosarium.....	163
K. Daftar Pustaka.....	165

PROFIL PENULIS167

BAB 1

PERAN PERAWAT ANAK

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

1. Mampu memberikan asuhan keperawatan anak yang profesional, holistik, dan berbasis bukti dengan memperhatikan aspek perkembangan, kebutuhan anak, dan keterlibatan keluarga.
2. Mampu berperan sebagai pendidik, kolaborator, advokat, dan peneliti dalam praktik keperawatan anak.
3. Mampu menginternalisasi nilai-nilai empati, kasih sayang, dan etika dalam praktik keperawatan pediatrik yang berorientasi pada kesejahteraan anak dan keluarganya.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Menjelaskan filosofi dan prinsip keperawatan anak yang berorientasi pada Family-Centered Care dan Atraumatic Care.
2. Menganalisis perbedaan mendasar antara perawatan anak dan dewasa dalam konteks fisiologis, psikologis, dan sosial.
3. Mendeskripsikan peran, tanggung jawab, dan ruang lingkup praktik perawat anak dalam memberikan asuhan keperawatan komprehensif.
4. Menjelaskan pendekatan holistik dalam keperawatan anak meliputi aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual.
5. Menerapkan prinsip etika dan manajemen kasus dalam pelayanan keperawatan anak berbasis evidence-based practice.

Sub-CPMK

Untuk CPMK 1: Menjelaskan filosofi dan prinsip keperawatan anak

- Menguraikan filosofi dasar keperawatan anak dan hubungannya dengan paradigma keperawatan.
- Menjelaskan prinsip Family-Centered Care dan Atraumatic Care dalam konteks pelayanan pediatrik.

Untuk CPMK 2: Menganalisis perbedaan perawatan anak dan dewasa

- Mengidentifikasi karakteristik tumbuh kembang anak berdasarkan tahapan usia.
- Menjelaskan respon anak terhadap sakit dan hospitalisasi berdasarkan usia perkembangan.

- Menganalisis pendekatan keperawatan yang sesuai dengan perbedaan fisiologis dan psikologis anak.

Untuk CPMK 3: Mendeskripsikan peran dan ruang lingkup praktik perawat anak

- Menjelaskan lima peran utama perawat anak: edukator, konselor, kolaborator, pengambil keputusan etik, dan peneliti.
- Mendeskripsikan ruang lingkup praktik keperawatan anak sesuai dengan batasan usia dan kebutuhan dasar (asuh, asih, asah).

Untuk CPMK 4: Menjelaskan pendekatan holistik dalam keperawatan anak

- Menguraikan keterkaitan antara aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual dalam pelayanan keperawatan anak.
- Menjelaskan pentingnya dukungan keluarga dalam pemulihan dan kesejahteraan anak.

Untuk CPMK 5: Menerapkan prinsip etika dan manajemen kasus

- Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengambilan keputusan etis dalam keperawatan anak.
- Mendeskripsikan tahapan manajemen kasus dalam pelayanan anak secara menyeluruh.
- Mengintegrasikan prinsip keperawatan berbasis bukti untuk peningkatan kualitas asuhan keperawatan anak.

Pendahuluan/Prolog

Perawat anak memegang peran penting dalam menjaga, merawat, dan mendukung kesehatan serta kesejahteraan anak sejak lahir hingga masa remaja. Di tengah kompleksitas perkembangan anak yang melibatkan aspek fisik, psikologis, sosial, dan emosional, perawat anak dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif serta kepekaan dalam menghadapi berbagai kondisi kesehatan anak. Peran perawat anak dalam dunia kesehatan tidak hanya terbatas pada pemberian tindakan medis, tetapi juga mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Perawat anak menjadi garda terdepan dalam memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal, mengidentifikasi potensi masalah kesehatan sejak dini, serta memberikan dukungan emosional bagi anak dan keluarganya. Tantangan yang dihadapi perawat anak semakin kompleks seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan perubahan dinamika sosial yang memengaruhi pola asuh dan kebutuhan kesehatan anak.

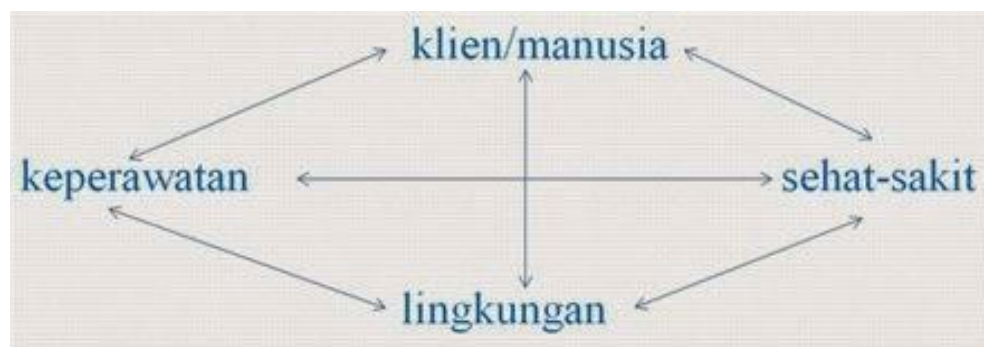
Dalam konteks pertumbuhan dan perkembangan anak, perawat memiliki tanggung jawab untuk memantau berbagai aspek perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Pengetahuan tentang indikator perkembangan normal dan kemampuan untuk mendeteksi deviasi secara dini menjadi kunci dalam mencegah terjadinya gangguan

tumbuh kembang. Selain itu, perawat anak juga harus mampu memberikan edukasi kepada orang tua dan pengasuh tentang pentingnya stimulasi dini, nutrisi yang adekuat, serta lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Perawat anak harus mampu memberikan perawatan yang tidak hanya fokus pada penyembuhan penyakit, tetapi juga memperhatikan kualitas hidup anak secara keseluruhan. Hal ini termasuk dukungan psikologis untuk membantu anak menghadapi proses pengobatan, serta pendampingan bagi keluarga dalam mengelola kondisi kesehatan anak dengan bijak.

Bab ini akan membahas mengenai keterampilan perawat anak dalam menjalankan tugasnya secara profesional dengan hasil yang optimal. Bab ini juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap perkembangan psikologis anak sebagai bagian integral dari upaya perawatan yang holistik. Harapannya, bab ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi para mahasiswa perawat, perawat, pendidik, dan tenaga kesehatan lainnya dalam meningkatkan kualitas layanan keperawatan anak. Dengan pendekatan yang berbasis ilmu pengetahuan dan empati, perawat anak diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan anak, yang pada akhirnya turut mendukung terwujudnya generasi masa depan yang sehat dan berkualitas. Gambaran pembahasan pada bab ini yaitu konsep dasar keperawatan pada anak dan peran perawat anak. Pada Bab ini juga akan di jelaskan pembeda pasien anak dengan dewasa, sehingga bisa di maknai secara harfiah terkait pembeda peran perawat saat memberikan asuhan keperawatan anak dan dewasa. Selanjutnya, pada Bab ini juga dilengkapi dengan latihan soal sebagai indikator pemahaman pembaca terkait materi yang akan di sampaikan.

A. Filosofi Keperawatan Anak

Filosofi dalam keperawatan anak mencerminkan pandangan atau keyakinan yang dipegang oleh perawat saat memberikan pelayanan kepada anak. Keperawatan anak sejalan dengan definisi keperawatan sebagai proses diagnosis dan penanganan respons manusia terhadap masalah kesehatan aktual atau potensial (Wong, 2008). Tujuan utamanya adalah mencapai tingkat kesehatan optimal bagi anak sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan keluarga. Keberhasilan layanan kesehatan anak bertumpu pada filosofi yang menekankan *Family Centered Care* (FCC), pengelolaan kasus dan *Atraumatic Care*. Dalam praktik keperawatan anak, perawat harus menyadari adanya prinsip-prinsip khusus yang berbeda dibandingkan dengan keperawatan dewasa, karena anak bukanlah versi kecil dari orang dewasa, melainkan individu dengan keunikan tersendiri. Paradigma keperawatan anak menjadi dasar pemikiran dalam penerapan ilmu keperawatan anak. Dasar pemikiran ini mencakup empat komponen utama, yaitu manusia yang dalam konteks ini adalah anak, keperawatan, konsep sehat-sakit, dan lingkungan (Damanik & Sitorus, 2020).



Gambar 1.1: Paradigma Keperawatan Anak

Sumber : (Damanik & Sitorus, 2020)

1. Manusia (Anak)

Dalam keperawatan anak, individu yang menjadi klien adalah anak-anak berusia kurang dari 18 tahun yang sedang berada dalam fase tumbuh kembang dengan kebutuhan khusus yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Masa anak terdiri dari beberapa tahap perkembangan, mulai dari bayi (0-1 tahun), toddler (1-2,5 tahun), pra-sekolah (2,5-5 tahun), usia sekolah (5-11 tahun), hingga remaja (11-18 tahun). Setiap anak mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda, dipengaruhi oleh latar belakang individu masing-masing. Pertumbuhan fisik anak tidak seragam, begitu juga

perkembangan kognitif yang bisa berlangsung cepat atau lambat. Konsep diri mulai terbentuk sejak bayi, meskipun belum sempurna, dan berkembang seiring bertambahnya usia. Pola koping anak juga sudah muncul sejak dini, misalnya saat bayi menangis untuk mengungkapkan rasa lapar atau ketidaknyamanan. Perilaku sosial anak mulai terlihat sejak bayi, seperti kemampuan merespons interaksi dengan orang lain, dan akan terus berkembang sesuai dengan lingkungan serta usia.

Dalam merespons penyakit, emosi anak bervariasi tergantung pada usia dan tahap perkembangan. Misalnya, bayi yang terpisah dari orang tua cenderung menunjukkan reaksi seperti menangis, berteriak, atau menarik diri. Pemberian pelayanan keperawatan anak harus memperhitungkan perbedaan mendasar antara anak dan dewasa, baik dari segi struktur fisik, fungsi tubuh, kemampuan berpikir, hingga mekanisme koping. Anak masih dalam proses kematangan fisik dan psikologis, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa yang sudah memiliki kematangan fisiologis dan mekanisme koping yang lebih stabil.

2. Sehat-sakit

Rentang sehat-sakit adalah suatu batasan yang menggambarkan kondisi kesehatan anak, mulai dari sejahtera, sehat optimal, sehat, sakit, sakit kronis, hingga meninggal (Krisna Triyono & K. Herdiyanto, 2018). Rentang ini bersifat dinamis dan menjadi alat ukur dalam menilai status kesehatan anak. Selama berada dalam rentang ini, anak memerlukan bantuan perawat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kondisi sehat, perawat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan anak hingga mencapai kesejahteraan fisik, sosial, dan spiritual. Sebaliknya, saat anak berada dalam kondisi kritis atau meninggal, perawat memberikan dukungan kepada keluarga. Secara umum, sehat diartikan sebagai keadaan sempurna secara fisik, mental, dan sosial, tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan (Juwinta, 2021). Ciri-ciri sehat meliputi kemampuan merefleksikan perhatian individu sebagai manusia, memandang kesehatan dalam konteks lingkungan internal dan eksternal, serta menjalani hidup yang kreatif dan produktif (Suryanti, 2021).

3. Lingkungan

lingkungan mencakup faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perubahan status kesehatan anak. Lingkungan internal meliputi kondisi bawaan seperti kelainan genetik atau penyakit kongenital yang dapat menyebabkan anak lebih rentan terhadap gangguan kesehatan di kemudian hari (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013). Sementara itu, lingkungan eksternal mencakup aspek-aspek seperti status gizi, peran orang tua, interaksi dengan

saudara, teman sebaya, dan masyarakat sekitar. Lingkungan yang kurang mendukung, tidak aman, minim kasih sayang, atau penuh tekanan dapat menghambat kesejahteraan anak dan meningkatkan risiko terjadinya penyakit (Nelson Tanjung et al., 2023).

4. Keperawatan

Pelayanan keperawatan anak bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal dengan melibatkan keluarga sebagai bagian integral dalam proses asuhan. Keterlibatan keluarga ini mencakup dukungan emosional, pendidikan kesehatan, serta fasilitasi rujukan ke tenaga medis yang diperlukan. Sebagai sistem terbuka, keluarga memiliki peran krusial dalam keberhasilan asuhan keperawatan karena mampu menyediakan lingkungan yang efektif untuk perawatan anak. Selain itu, keluarga berperan penting dalam perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, menjaga kelangsungan hidup, keselamatan, dan kesejahteraan anak. Interaksi yang terjalin antara keluarga dan anak ini diharapkan dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk masa depan anak yang lebih baik (Yolanda et al., 2024).

Perawat anak bertanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif kepada anak dan keluarganya. Perannya mencakup pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang, manajemen hospitalisasi, serta pengkajian keperawatan yang dimulai sejak awal hingga tahap lanjutan perawatan (Damanik & Sitorus, 2020). Perawat berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, khususnya dokter, dalam penegakan diagnosis medis anak, dengan menekankan komunikasi efektif untuk memastikan perawatan yang aman dan optimal. Pengkajian dilakukan secara sistematis dan holistik, melibatkan anak dan orang tua sebagai bagian dari penerapan filosofi *Family-Centered Care (FCC)* dan *Atraumatic Care* (Tampubolon, 2021).

Hubungan terapeutik antara perawat, anak, dan keluarga menjadi dasar penting dalam asuhan keperawatan yang berkualitas. Komunikasi efektif antara perawat dan keluarga diharapkan mempercepat proses pemulihan anak. Perawat juga membantu keluarga dalam membuat keputusan terkait tindakan medis atau informasi penting demi kepentingan anak. Pendekatan ini memastikan keluarga memahami layanan kesehatan yang tersedia, baik medis maupun nonmedis, sesuai standar operasional prosedur, dengan melibatkan kerja sama keluarga (Henry et al., 2024).

Sebagai perawat pediatrik, sikap peduli, kasih sayang, dan empati menjadi hal utama yang harus ditunjukkan. Kepedulian ini diwujudkan melalui penerapan konsep perawatan atraumatik dan pengembangan hubungan terapeutik dengan klien serta keluarga. Keluarga sering kali merasa takut, cemas, dan gelisah ketika

anak harus dirawat di rumah sakit, sehingga dukungan perawat sangat diperlukan untuk membantu mereka melalui situasi tersebut (Wulanningrum, 2021).

1. Perawatan Berfokus pada Keluarga

Upaya capaian tujuan dari pencegahan dan pengobatan anak yang dirawat di rumah sakit, yaitu berfokus pada keterlibatan keluarga mengambil peran berkolaborasi bersama tim kesehatan untuk memenuhi kebutuhan anak saat di rawat di rumah sakit. Peran keluarga memengaruhi proses pelayanan asuhan keperawatan yang diberikan. Konsep asuhan keperawatan yang berpusat pada keluarga terkait peningkatan upaya keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit (anak). Peran perawat dalam prosesnya yaitu memfasilitasi orang tua memiliki keterampilan dasar merawat anak sakit, dalam prosesnya orang tua belajar keterampilan merawat anak sesuai kapasitasnya dengan bimbingan perawat.

Keberhasilan hubungan yang baik antar anak dan orang tua, menjadi tolak ukur capaian pemberian asuhan keperawatan anak selama hospitalisasi. Relasi yang terjalin baik membentuk coping anak tetap merasa aman dan nyaman selama menjalani masa hospitalisasi. Perawat sebagai pemberi layanan asuhan keperawatan harus mempertimbangkan kemampuan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki keluarga. Aspek ini meliputi fasilitas yang dimiliki keluarga untuk merawat anak, tingkat pengetahuan, kondisi ekonomi, serta peran atau bentuk keluarga itu sendiri.

2. *Atraumatic Care*

Atraumatic care adalah pendekatan perawatan yang bertujuan mencegah trauma pada anak dan keluarganya. Fokus perawatan ini adalah menghindari pengalaman traumatis, yang menjadi bagian penting dalam keperawatan anak dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan mereka. Pengalaman hospitalisasi yang tidak menyenangkan menimbulkan trauma pada anak berupa rasa tidak aman atau cemas, nyeri, marah dan lainnya. Dampak psikologis seperti contoh perasaan tidak menyenangkan, apabila tidak mendapatkan intervensi yang tepat tentunya dapat menghambat perkembangan anak. Konsep perawatan *atraumatic care* bisa tercapai selama proses pemberian asuhan keperawatan dengan memperhatikan beberapa prinsip berikut ini :

- a. Hindari perpisahan antara anak dan orang tua, hal ini krusial dalam faktor capaian pengobatan yang telah ditentukan. Jika anak mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, ketakutan, kekurangan kasih sayang tentunya proses pengobatan akan terhambat.
- b. Tingkatkan kemampuan orang tua dalam mengontrol perawatan, hal ini bertujuan mendukung kemandirian anak dalam menjalani kehidupan.

Dengan bimbingan tersebut, anak diharapkan lebih berhati-hati dan waspada dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, pendidikan yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan kemampuan orang tua dalam mengawasi perawatan anak menjadi bagian penting dari proses ini.

- c. Mengurangi dan mencegah cedera (*injury*) dan nyeri, respon terhadap penyakit akan berbeda berdasarkan capaian tugas perkembangan anak. Respon emosional anak terhadap penyakit bervariasi sesuai dengan usia dan tahap perkembangan. Pada masa bayi, anak cenderung menangis, berteriak, menarik diri, atau diam sebagai reaksi terhadap perpisahan dengan orang tua atau rasa nyeri, sering kali disertai penolakan untuk bergerak. Balita merespons situasi yang tidak menyenangkan dengan menangis sambil mencari ibunya, berhenti berbicara, atau kehilangan keterampilan baru. Perubahan rutinitas dapat memicu reaksi seperti protes atau agresi. Anak prasekolah menunjukkan respons emosional seperti regresi (hilangnya kontrol terhadap kebiasaan tertentu), proyeksi, agresi, atau penarikan diri saat menghadapi perpisahan, lingkungan asing, atau perubahan *body image*. Mereka juga bisa menjadi lebih peka dan pasif, misalnya menolak makan. Anak usia sekolah biasanya merespons dengan protes, bosan, kesepian, frustrasi, atau menarik diri, disertai perilaku seperti merengek, mengertakkan gigi, atau mencari informasi. Pada remaja, kehilangan identitas, cedera tubuh, atau perpisahan dari kelompok sebaya dapat memicu reaksi seperti tidak kooperatif, agresi, depresi, atau kesepian.
- d. Modifikasi lingkungan fisik, memberikan suasana lingkungan yang ceria, menyenangkan sehingga terbentuk rasa nyaman anak saat menjalani proses pengobatan selama hospitalisasi.

3. Manajemen Kasus

Pengelolaan kasus secara komprehensif merupakan bagian utama dalam pemberian asuhan keperawatan yang menyeluruh, mencakup pengkajian, penentuan diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk kasus akut maupun kronis. Pendekatan ini mencakup persiapan fisik, penciptaan lingkungan yang nyaman bagi anak dan orang tua, serta penerapan prinsip pencegahan dan peningkatan kesehatan sebagai tanggung jawab perawat. Kemampuan perawat dalam mengelola kasus dengan baik berdampak signifikan pada proses penyembuhan anak, yang memiliki kebutuhan spesifik dan beragam. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada keluarga selama masa perawatan di rumah sakit memungkinkan mereka berperan aktif dan mendukung keberhasilan program perawatan secara menyeluruh.

B. Prinsip Keperawatan Anak

Asuhan keperawatan anak memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perawatan orang dewasa karena harus disesuaikan dengan usia, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Perawatan yang tidak optimal dapat berdampak negatif secara fisiologis dan psikologis. Oleh karena itu, perawat perlu memahami prinsip-prinsip berikut (Arif, 2022):

- 1. Anak sebagai individu yang unik,** Anak bukan miniatur orang dewasa, tetapi individu dengan pola pertumbuhan dan perkembangan yang khas menuju kematangan.
- 2. Anak memiliki kebutuhan sesuai tahapan perkembangan,** Anak memiliki kebutuhan fisiologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang berbeda, seperti kebutuhan nutrisi, cairan, aktivitas, eliminasi, tidur, serta dukungan psikososial dan spiritual yang sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya.
- 3. Keperawatan anak berorientasi pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan,** Perawatan anak difokuskan pada pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian, mengingat peran anak sebagai generasi penerus.
- 4. Berorientasi pada kesejahteraan anak,** Perawat bertanggung jawab secara menyeluruh dalam memberikan asuhan, dengan mengutamakan kepentingan anak dan melibatkan keluarga dalam proses perawatan
- 5. Keperawatan anak bersifat holistik,** Praktik keperawatan melibatkan kontrak dengan anak dan keluarga untuk mencegah, mengkaji, mengintervensi, dan meningkatkan kesejahteraan anak dengan memperhatikan aspek moral (etik) dan hukum (legal).

C. Ruang Lingkup Praktik Keperawatan Anak

Lingkup praktik mencakup hak dan wewenang dalam memberikan asuhan keperawatan yang didasarkan pada kemampuan, tingkat pendidikan, serta batasan profesi yang dimiliki. Praktik keperawatan itu sendiri merupakan tindakan mandiri dalam perawatan profesional yang dilakukan secara kolaboratif dengan klien dan tenaga kesehatan untuk memberikan asuhan keperawatan. Lingkup praktik keperawatan anak meliputi batasan pemberian asuhan kepada klien anak dengan rentang usia 28 hari hingga 18 tahun atau bayi baru lahir hingga 12 tahun (Gartinah, dkk 1999). Dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak, tindakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dasar anak untuk mendukung tumbuh kembangnya, seperti kebutuhan asuh, asih, dan asah

1. Kebutuhan Asuh

Kebutuhan dasar adalah kebutuhan fisik yang harus dipenuhi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Kebutuhan ini mencakup asupan gizi atau nutrisi, tindakan keperawatan untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit, perawatan serta pengobatan saat sakit, tempat tinggal atau perlindungan yang layak, kebersihan pribadi dan sanitasi lingkungan yang sehat, pakaian, kesehatan fisik, serta rekreasi. Semua kebutuhan ini harus terpenuhi dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak.

2. Kebutuhan Asih

Kebutuhan ini berfokus pada pemberian kasih sayang kepada anak atau mendukung kesehatan psikologisnya. Perkembangan psikologis anak sangat memengaruhi kehidupan mereka, termasuk perasaan kasih sayang dan hubungan dengan orang tua maupun orang di sekitarnya, yang berdampak positif pada perkembangan psikososial. Pemenuhan kebutuhan ini membantu memperkuat ikatan kasih sayang yang erat (bonding) dan membangun rasa percaya yang kuat (basic trust).

D. Peran Perawat anak dalam Keperawatan Anak

1. Sebagai Edukator

Perawat memiliki peran sebagai pendidik, baik secara langsung melalui penyuluhan atau pendidikan kesehatan kepada orang tua maupun secara tidak langsung dengan membantu orang tua atau anak memahami pengobatan dan perawatan yang diperlukan. Pendidikan kesehatan yang dibutuhkan oleh orang tua meliputi pemahaman dasar tentang penyakit anak, perawatan selama anak dirawat di rumah sakit, dan persiapan perawatan lanjutan saat kembali ke rumah. Melalui pendidikan kesehatan, perawat dapat memengaruhi tiga aspek utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap keluarga, khususnya dalam merawat anak yang sedang sakit.

2. Sebagai Konselor

Anak dan keluarganya pada suatu waktu mungkin memerlukan dukungan psikologis berupa dorongan mental. Dalam perannya sebagai konselor, perawat dapat memberikan konseling keperawatan sesuai kebutuhan anak dan keluarganya. Hal ini menjadi pembeda antara layanan konseling dan pendidikan kesehatan. Dengan mendengarkan keluhan, memberikan sentuhan, serta hadir secara fisik, perawat dapat berdiskusi dan bertukar pikiran dengan orang tua mengenai masalah yang dihadapi anak dan keluarganya, serta membantu mencari alternatif solusi.

3. Sebagai Koordinator atau kolaborator

Melalui pendekatan interdisipliner, perawat berperan dalam melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan anggota tim kesehatan lainnya untuk memastikan pemberian asuhan yang holistik dan menyeluruh. Perawat memiliki posisi strategis sebagai koordinator pelayanan kesehatan karena berada di sisi pasien selama 24 jam. Keluarga merupakan mitra penting bagi perawat, sehingga kerja sama dengan keluarga perlu terjalin dengan baik, tidak hanya ketika perawat memerlukan informasi, tetapi juga sepanjang seluruh proses perawatan anak dengan melibatkan keluarga secara aktif.

4. Sebagai Pembuatan Keputusan Etik

Perawat memiliki tanggung jawab untuk berperan sebagai pengambil keputusan etis dengan berlandaskan nilai-nilai yang diyakini, menekankan hak pasien atas otonomi, mencegah tindakan yang merugikan, dan memastikan manfaat asuhan keperawatan dalam meningkatkan kesejahteraan pasien. Selain itu, perawat juga perlu berkontribusi dalam merancang kebijakan pelayanan kesehatan. Suara perawat harus diperhitungkan oleh para pembuat kebijakan, dan mereka harus aktif dalam inisiatif yang mendukung peningkatan kesejahteraan anak. Sebagai pihak yang paling memahami pelayanan keperawatan anak, perawat perlu meyakinkan para pembuat kebijakan bahwa rencana pelayanan keperawatan yang diusulkan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas kesehatan anak.

5. Sebagai Peneliti

Sebagai peneliti, perawat anak perlu terlibat secara aktif dalam mengidentifikasi isu-isu keperawatan anak yang memerlukan penelitian, melaksanakan penelitian langsung, serta memanfaatkan hasil penelitian di bidang kesehatan dan keperawatan anak untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Kemampuan berpikir kritis menjadi hal penting dalam menganalisis fenomena yang terjadi dalam praktik keperawatan anak sehari-hari, meninjau penelitian sebelumnya, dan menggunakan literatur untuk memvalidasi permasalahan yang ditemukan. Pada tingkat keahlian tertentu, perawat juga diharapkan mampu melakukan penelitian yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan keperawatan anak.

E. Latihan Soal !

1. Prinsip keperawatan anak adalah , *kecuali ...*
 - A. anak bukan miniature orang dewasa
 - B. anak adalah individu yang unik dan mempunyai kebutuhan khusus sesuai tahap perkembangan
 - C. Merupakan disiplin ilmu kesehatan yang berfokus pada kesejahteraan anak
 - D. Memberikan perawatan

- E. Mencakup kontrak dengan anak dan keluarga
- 2. Perawat memberikan layanan konsultasi pada orang tua maka peran perawat adalah sebagai
 - A. Pendidik
 - B. Konselor
 - C. Penyuluh
 - D. Pendukung
 - E. Pengevaluasi
- 3. Perawat harus melakukan kajian-kajian keperawatan anak, yang dapat dikembangkan untuk perkembangan teknologi keperawatan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan anak adalah peran perawat sebagai...
 - A. Advokat keluarga
 - B. Pendidik
 - C. Kolaborasi
 - D. Konseling
 - E. Peneliti
- 4. Upaya perawat dalam memberikan waktu untuk berkonsultasi terhadap masalah yang dialami oleh klien dan keluarga. Dengan memberikan kemandirian keluarga dalam mengatasi masalah kesehatannya adalah peran perawat sebagai
 - A. Advokat keluarga
 - B. Pencegahan penyakit
 - C. Kolaborasi
 - D. Konseling
 - E. Pendidik
- 5. Seorang ibu ingin melaksanakan tindakan keperawatan kompres hangat serta melakukan pengukuran suhu pada anak sendiri dan anak memilih ibunya untuk melakukan tindakan tersebut, maka termasuk dalam prinsip....
 - A. Mendorong anak dan keluarga untuk menemukan kelebihan dan kekuatan yang dimiliki
 - B. Berkolaborasi dengan anak dan keluarga dalam penyusunan dan pengembangan program perawatan anak
 - C. Menjamin pelayanan yang diperoleh anak dan keluarga sesuai dengan kebutuhan
 - D. Mengenali dan memperkuat kelebihan yang ada pada anak dan keluarga
 - E. Menghormati setiap anak dan keluarganya
- 6. Perubahan orientasi pelayanan keperawatan anak mencakup aspek berikut ini yaitu
 - A. Anak dapat dipandang sebagai miniatur orang dewasa

- B. Perawat dipandang sebagai sumber informasi yang efektif bagi anak
 - C. Kerja sama orang tua dan perawat tidak selalu dibutuhkan
 - D. Orang tua didorong berpartisipasi aktif dalam perawatan
 - E. Perawatan anak sepenuhnya hak perawat
7. Peran utama perawat anak dalam asuhan keperawatan adalah...
- A. Memberikan obat sesuai resep dokter
 - B. Membantu dokter dalam prosedur medis
 - C. Memberikan perawatan holistik yang berfokus pada kebutuhan anak dan keluarga
 - D. Mengajarkan orang tua cara menggendong bayi
 - E. Mengatur jadwal makan anak di rumah sakit
8. Peran perawat dalam edukasi kesehatan kepada keluarga anak sakit bertujuan untuk...
- A. Mengurangi beban kerja perawat di rumah sakit
 - B. Membantu keluarga memahami kondisi anak dan cara perawatannya
 - C. Menggantikan peran dokter dalam memberikan informasi
 - D. Menghindari keluarga terlibat dalam pengambilan keputusan
 - E. Membatasi interaksi anak dengan lingkungan luar
9. Dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak, perawat harus memperhatikan prinsip atraumatic care, yang berarti...
- A. Menghindari semua tindakan medis pada anak
 - B. Memberikan perawatan dengan seminimal mungkin menyebabkan trauma fisik dan emosional
 - C. Hanya fokus pada perawatan fisik anak
 - D. Memberikan obat tanpa menjelaskan efek sampingnya
 - E. Melakukan tindakan tanpa memperdulikan kenyamanan anak
10. Peran perawat anak dalam aspek kuratif adalah...
- A. Melakukan promosi kesehatan kepada anak dan keluarga
 - B. Mengajarkan pola makan sehat kepada orang tua
 - C. Memberikan perawatan pada anak yang sedang sakit
 - D. Menyelenggarakan program imunisasi di sekolah
 - E. Melakukan skrining kesehatan di komunitas

JAWABAN

- 1. D
- 2. B
- 3. E
- 4. D

5. B
6. D
7. C
8. B
9. B
10. C

F. Rangkuman Materi

Peran perawat anak sangat krusial dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan anak sejak masa bayi hingga remaja. Dalam menjalankan perannya, perawat tidak hanya bertanggung jawab terhadap aspek kuratif, tetapi juga memiliki peran penting dalam upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif. Asuhan keperawatan anak menuntut pemahaman yang mendalam terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, serta penerapan filosofi keperawatan yang berfokus pada Family Centered Care dan Atraumatic Care. Pendekatan ini menempatkan anak sebagai individu unik yang memiliki kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang khas, serta menempatkan keluarga sebagai mitra dalam proses keperawatan.

Prinsip keperawatan anak menekankan pada pentingnya memberikan asuhan secara holistik, dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar anak seperti asuh (fisik), asih (kasih sayang), dan asah (stimulasi intelektual). Praktik keperawatan anak juga harus memperhatikan lingkungan internal dan eksternal yang memengaruhi kondisi kesehatan anak. Lingkup praktik keperawatan anak mencakup pengelolaan kasus secara menyeluruh, dari pengkajian hingga evaluasi, dengan tujuan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dan menghindari pengalaman traumatis selama hospitalisasi.

Dalam menjalankan tugasnya, perawat anak berperan sebagai edukator, konselor, kolaborator, pengambil keputusan etik, dan peneliti. Peran-peran ini mencerminkan tanggung jawab profesional yang menuntut kemampuan komunikasi efektif, empati, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dalam praktik keperawatan. Dengan demikian, perawat anak diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan anak, sekaligus mendukung terbentuknya generasi masa depan yang sehat, tangguh, dan berkualitas.

G. Glosarium

Pediatrik: Cabang ilmu kedokteran yang melibatkan perawatan medis untuk bayi , anak-anak , remaja , dan dewasa muda.

Koping: Upaya untuk menguasai suatu situasi yang poten- sial mengancam, membahayakan, menantang atau memuaskan.

Hospitalisasi: Proses perawatan di rumah sakit yang dilakukan karena alasan tertentu, seperti penyakit atau kondisi darurat.

Injury : Cedera

Body Image : Citra tubuh

H. Daftar Pustaka

Arif, M. (2022). *Keperawatan Anak*.

Damanik, S. M., & Sitorus, E. (2020). *Buku Materi Pembelajaran Praktikum Keperawatan Anak*.
<http://repository.uki.ac.id/2733/1/BukuMateriPembelajaranPraktikumKeperawatanAnak.pdf>

Henry, C. M., Liencewas, K. P., Sibarani, E. F., & Isti, E. (2024). *KEPERAWATAN PADA PASIEN ANAK DENGAN EFUSI PLEURA DAN STUNTING: STUDI KASUS*. 5, 11187–11196.

Juwinta, C. P. (2021). Modul konsep sehat dan sakit. *Biologi Dan Ilmu Lingkungan*, 9–10.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan. In *Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana*.

Krisna Triyono, S. D., & K. Herdiyanto, Y. (2018). Konsep Sehat Dan Sakit Pada Individu Dengan Urolithiasis (Kencing Batu) Di Kabupaten Klungkung, Bali. *Jurnal Psikologi Udayana*, 4(02), 263.
<https://doi.org/10.24843/jpu.2017.v04.i02.p04>

Nelson Tanjung, Restu Auliani, Mustar Rusli, Ice Ratnalela Siregar, & Taher, M. (2023). Peran Kesehatan Lingkungan dalam Pencegahan Penyakit Menular pada Remaja di Jakarta: Integrasi Ilmu Lingkungan, Epidemiologi, dan Kebijakan Kesehatan. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(09), 790–798.
<https://doi.org/10.58812/jmws.v2i09.629>

Suryanti, P. E. (2021). Konsep Sehat-Sakit : Sebuah Kajian Filsafat. *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, 12(1), 90. <https://doi.org/10.25078/sjf.v12i1.2005>

Tampubolon, R. et al. (2021). Peran Perawat Anak dalam Mencegah Masalah Tumbuh Kembang pada Anak dengan Penyakit Kronis. *Keperawatan*, 13(4).

<https://doi.org/https://doi.org/10.32583/keperawatan.v13i4.1440>

Wong. (2008). Buku Ajar Keperawatan Pediatrik Wong. In *Buku ajar pediatrik Edisi 6* (Nomor Jakarta;EG).

Wulanningrum, D. N. (2021). Perspektif Keperawatan Anak. In *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952*. (Vol. 2016).

Yolanda, H., Kusuma, A., Palupi, R., Wulanningrum, D. N., Penyami, Y., Jafar, C. P. S. H., & Potabuga, I. N. U. S. (2024). Perspektif Keperawatan Anak. In I. N. U. S. Potabuga (Ed.), *Eureka Media Aksara*. Eureka Media Aksara.

BAB 2

TREND DAN ISSUE KEPERAWATAN ANAK

Pendahuluan

Definisi dan Ruang Lingkup Keperawatan Anak

Keperawatan anak adalah cabang keperawatan yang berfokus pada pemberian asuhan keperawatan kepada anak sejak lahir hingga remaja, termasuk bayi baru lahir, balita, anak-anak usia sekolah, dan remaja. Keperawatan anak melibatkan proses terapeutik yang bertujuan untuk mempromosikan kesehatan, mencegah penyakit, serta membantu penyembuhan dan rehabilitasi anak yang sakit.

Menurut (Marilyn J. Hockenberry et al., 2019), keperawatan anak tidak hanya berpusat pada anak sebagai individu tetapi juga memperhatikan peran keluarga dalam proses perawatan. Ini disebabkan karena anak sangat bergantung pada keluarga mereka dalam pengambilan keputusan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Ruang Lingkup Keperawatan Anak meliputi:

- Promosi Kesehatan: Edukasi kepada anak dan keluarganya mengenai nutrisi, imunisasi, kebersihan diri, dan pola hidup sehat.
- Pencegahan Penyakit: Memberikan imunisasi, melakukan deteksi dini penyakit, dan melakukan penyuluhan kesehatan.
- Asuhan Kuratif: Memberikan perawatan langsung kepada anak yang sakit atau mengalami cedera.
- Rehabilitasi: Membantu anak yang memiliki penyakit kronis atau disabilitas agar bisa mencapai kualitas hidup terbaik.

Prinsip Dasar Keperawatan Anak

Dalam keperawatan anak, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam memberikan asuhan keperawatan, yaitu:

- *Family-Centered Care* (Perawatan Berpusat pada Keluarga) Asuhan keperawatan tidak hanya fokus pada anak, tetapi juga melibatkan keluarga sebagai mitra dalam memberikan perawatan. Keluarga memiliki peran penting dalam mendukung (Jane W. Ball, 2019) kesejahteraan anak .
- *Atraumatic Care* (Perawatan Tanpa Trauma) Menghindari atau meminimalkan stres dan trauma psikologis yang bisa dialami anak selama proses perawatan, misalnya

dengan membiarkan anak bersama orang tua selama prosedur medis (Marilyn J. Hockenberry et al., 2019).

- *Developmentally Appropriate Care* (Perawatan Sesuai Tahap Perkembangan) Pemberian asuhan disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan anak, misalnya komunikasi menggunakan bahasa sederhana untuk balita atau memberikan penjelasan logis untuk remaja.
- Advokasi Kesehatan Anak Perawat berperan sebagai advokat untuk memastikan hak anak terpenuhi, termasuk hak atas informasi, privasi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan mereka.

Peran dan Tanggung Jawab Perawat Anak

Perawat anak memiliki peran penting yang mencakup berbagai aspek, antara lain:

- Pemberi Asuhan (Caregiver): Memberikan perawatan langsung dan holistik kepada anak.
- Pendidik (Educator): Mengedukasi anak dan keluarganya mengenai pengelolaan penyakit, terapi, dan pencegahan.
- Koordinator (Coordinator): Berkolaborasi dengan tim kesehatan lain untuk memastikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi.
- Advokat (Advocate): Memastikan hak anak terpenuhi dan memperjuangkan kepentingan terbaik anak.
- Peneliti (Researcher): Melakukan penelitian untuk mengembangkan praktik keperawatan anak yang berbasis bukti.

Contoh Kasus

Seorang anak berusia 5 tahun dirawat di rumah sakit karena pneumonia. Perawat tidak hanya memberikan terapi oksigen dan obat sesuai resep dokter, tetapi juga melibatkan orang tua dalam proses perawatan, memberikan edukasi tentang cara mencegah infeksi saluran napas, serta menggunakan boneka untuk menjelaskan prosedur pengobatan agar anak tidak takut.

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM DAN KHUSUS

Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari buku ajar ini, mahasiswa keperawatan diharapkan mampu memahami dan menerapkan berbagai tren dan isu kontemporer dalam keperawatan anak melalui pendekatan holistik, kolaboratif, serta berbasis bukti, guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak.

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa keperawatan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar keperawatan anak dan pentingnya asuhan keperawatan berbasis keluarga.
2. Mengidentifikasi tren dan isu terkini dalam keperawatan anak, termasuk teknologi dan inovasi terbaru.
3. Menerapkan prinsip kolaborasi interprofesional dalam pemberian asuhan keperawatan anak.
4. Menggunakan evidence-based practice (EBP) untuk meningkatkan kualitas perawatan anak.
5. Mengembangkan rencana asuhan keperawatan anak yang sesuai dengan kebutuhan individu dan keluarganya.
6. Menggunakan teknologi dan inovasi dalam praktik keperawatan anak secara efektif.
7. Mengevaluasi hasil asuhan keperawatan anak berdasarkan data dan bukti ilmiah.

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan buku ajar ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami prinsip-prinsip keperawatan anak secara komprehensif.
2. Menganalisis berbagai tren dan isu kontemporer yang memengaruhi praktik keperawatan anak.
3. Merancang intervensi keperawatan anak berdasarkan riset dan bukti ilmiah.
4. Berkolaborasi secara efektif dengan berbagai profesi kesehatan dalam pemberian asuhan keperawatan anak.
5. Mengimplementasikan teknologi dan inovasi dalam mendukung pelayanan keperawatan anak.
6. Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap proses dan hasil asuhan keperawatan anak.

A. Isu-Isu Kontemporer Dalam Keperawatan Anak

1. Kesehatan Mental Anak: Dampak Teknologi dan Media Sosial

Kesehatan mental anak menjadi isu utama dalam keperawatan anak di era digital. Menurut (WHO, 2024), sekitar 10-20% anak dan remaja di dunia mengalami gangguan mental, dengan depresi dan kecemasan sebagai kasus terbanyak. Penggunaan media sosial yang berlebihan dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan mental karena:

- a. *Cyberbullying*: Anak rentan menjadi korban perundungan daring, yang memengaruhi harga diri dan memicu stres.
- b. Kecanduan Gadget: Membatasi waktu tidur dan aktivitas fisik, memperburuk suasana hati.
- c. *Social Comparison*: Anak sering membandingkan diri mereka dengan kehidupan "sempurna" orang lain di media sosial.

Contoh Kasus: Seorang remaja perempuan berusia 14 tahun dirawat di klinik psikologi anak karena gangguan kecemasan. Perawat menemukan bahwa remaja tersebut menghabiskan lebih dari 6 jam sehari di media sosial dan sering menerima komentar negatif terkait penampilannya. Intervensi melibatkan edukasi kepada orang tua untuk mengatur waktu layar dan konseling psikologis berbasis kognitif.

2. Anak dengan Kebutuhan Khusus: Dukungan Keluarga dan Perawat

Anak berkebutuhan khusus (ABK) mencakup mereka yang memiliki keterlambatan perkembangan, gangguan sensorik, atau disabilitas fisik. Peran perawat meliputi:

- a. Edukasi Orang Tua: Membantu keluarga memahami kondisi anak dan cara mendukung perkembangan mereka.
- b. Terapi Stimulasi: Bekerja sama dengan terapis okupasi atau fisioterapis untuk meningkatkan keterampilan anak.
- c. Dukungan Psikososial: Memberikan pendampingan kepada keluarga agar mampu beradaptasi dengan kondisi anak.

Contoh Kasus: Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun didiagnosis autisme. Perawat mendampingi keluarga dengan memberikan edukasi mengenai *Applied Behavior Analysis* (ABA), mengajarkan cara memberikan perintah sederhana, dan membangun rutinitas harian bagi anak.

3. Imunisasi: Mitos dan Fakta

Isu penolakan imunisasi menjadi tantangan global dalam keperawatan anak. Berdasarkan (National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), 2023), peningkatan *vaccine hesitancy* disebabkan oleh:

- a. Mitos Efek Samping: Keyakinan salah bahwa vaksin menyebabkan autisme.
- b. Informasi Keliru: Berita hoaks di media sosial memperparah ketakutan orang tua.
- c. Kurangnya Edukasi: Beberapa orang tua tidak memahami manfaat jangka panjang imunisasi.

4. Peran Perawat:

- a. Konseling: Memberikan informasi berbasis bukti kepada keluarga mengenai keamanan dan efektivitas vaksin.
- b. Advokasi: Melawan hoaks dengan menyebarkan informasi dari sumber terpercaya.
- c. Kolaborasi: Bekerja sama dengan dokter anak dan pihak sekolah untuk memastikan cakupan imunisasi.

Contoh Kasus: Seorang ibu menolak imunisasi DPT untuk bayinya karena mendengar mitos bahwa vaksin menyebabkan kejang. Perawat memberikan penjelasan menggunakan data dari WHO, menjelaskan bahwa efek samping biasanya ringan dan sementara, serta menunjukkan grafik penurunan kasus difteri sejak program vaksinasi.

B. Peran Perawat dalam Mengatasi Masalah Kesehatan Anak

1. Peran Perawat dalam Promosi Kesehatan Anak

Promosi kesehatan anak bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak melalui pendidikan kesehatan, pencegahan penyakit, dan advokasi. Peran perawat meliputi:

- a. Edukator: Memberikan informasi kepada anak dan keluarganya mengenai nutrisi seimbang, pentingnya imunisasi, dan kebiasaan hidup sehat.
- b. Motivator: Mendorong anak dan keluarga untuk menjalankan pola hidup sehat, seperti mengatur pola makan dan aktivitas fisik.
- c. Kolaborator: Bekerja sama dengan guru, dokter anak, dan pekerja sosial untuk memastikan anak mendapat dukungan kesehatan yang holistik.

Contoh Kasus: Di sebuah sekolah dasar, perawat melakukan edukasi mengenai cuci tangan pakai sabun. Setelah program berjalan selama sebulan, tercatat penurunan kasus diare pada siswa sebesar 30%.

2. Peran Perawat dalam Pencegahan Penyakit

Perawat berperan dalam pencegahan primer, sekunder, dan tersier, antara lain:

- a. Pencegahan Primer: Imunisasi, promosi ASI eksklusif, dan edukasi kebersihan.
- b. Pencegahan Sekunder: Skrining tumbuh kembang menggunakan KMS dan deteksi dini gangguan kesehatan.
- c. Pencegahan Tersier: Merawat anak dengan penyakit kronis untuk mencegah komplikasi.

Contoh Kasus: Seorang balita dengan riwayat berat badan kurang dipantau menggunakan KMS. Setelah terdeteksi risiko stunting, perawat bekerja sama dengan ahli gizi untuk menyusun rencana makan bergizi dan memantau pertumbuhan anak.

3. Peran Perawat dalam Rehabilitasi Anak dengan Penyakit Kronis

Rehabilitasi bertujuan mengoptimalkan kualitas hidup anak dengan kondisi kronis seperti asma, diabetes, atau cerebral palsy. Tugas perawat meliputi:

- a. Koordinator: Mengatur jadwal terapi fisik dan psikologis.
- b. Advokat: Memastikan anak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan.
- c. Pemberi Dukungan Psikososial: Membantu anak dan keluarga beradaptasi dengan kondisi medisnya.

Contoh Kasus: Seorang remaja dengan diabetes tipe 1 mendapat edukasi mengenai cara menggunakan insulin dan memantau kadar gula darah. Perawat juga mendukung keluarga dengan memberikan saran tentang pola makan sehat dan aktivitas fisik yang sesuai.

4. Evidence-Based Practice (EBP) dalam Peran Perawat Anak

Perawat anak perlu menerapkan praktik berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas perawatan. Contohnya:

- a. Intervensi berbasis bukti untuk mengurangi stunting: Menurut penelitian oleh (Black et al., 2017), pendekatan multidisiplin dengan keterlibatan perawat, ahli gizi, dan tenaga sosial terbukti efektif dalam memperbaiki status gizi anak di daerah rawan stunting.
- b. Manajemen asma berbasis bukti: Studi oleh Global Initiative for Asthma (*GINA-Main-Report-2022-FINAL-22-07-01-WMS*, n.d.) menunjukkan bahwa edukasi perawat mengenai pengelolaan asma di rumah mengurangi risiko serangan asma berulang pada anak.

C. Tantangan dan Peluang dalam Keperawatan Anak

1. Tantangan dalam Keperawatan Anak

Dalam praktik keperawatan anak, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi perawat, di antaranya:

- a. Keterbatasan Sumber Daya: Kekurangan fasilitas kesehatan, alat medis, dan obat-obatan khusus anak sering menjadi kendala.
- b. Beban Kerja yang Tinggi: Perawat anak sering merawat pasien dalam jumlah besar dengan kasus kompleks, terutama di rumah sakit rujukan.
- c. Kurangnya Pendidikan Berkelanjutan: Tidak semua perawat memiliki akses ke pelatihan terbaru mengenai teknologi medis dan intervensi berbasis bukti.
- d. Komunikasi dengan Anak dan Keluarga: Kesulitan memahami kebutuhan emosional anak dan menjelaskan kondisi medis kepada keluarga menjadi tantangan tersendiri.

Contoh Kasus: Seorang perawat di rumah sakit daerah menghadapi keterbatasan alat diagnostik untuk mengelola kasus pneumonia pada anak. Perawat bekerja sama dengan dokter untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, seperti memanfaatkan teknik auskultasi dan tanda klinis untuk memantau kondisi anak.

2. Peluang dalam Keperawatan Anak

Meski ada tantangan, keperawatan anak juga memiliki berbagai peluang, seperti:

- a. Pemanfaatan Teknologi: Telehealth dan aplikasi kesehatan anak mempermudah pemantauan tumbuh kembang anak dari jarak jauh.
- b. Kolaborasi Multidisiplin: Adanya tim kesehatan yang terdiri dari perawat, dokter anak, ahli gizi, dan psikolog memperkuat intervensi kesehatan anak.
- c. Kebijakan Kesehatan: Dukungan pemerintah melalui program imunisasi, pemberian makanan tambahan, dan edukasi kesehatan menjadi peluang besar bagi perawat untuk memperluas perannya.
- d. Riset dan Evidence-Based Practice (EBP): Meningkatnya akses terhadap jurnal ilmiah dan pelatihan berbasis bukti memungkinkan perawat untuk terus meningkatkan kompetensinya.

Contoh Kasus: Sebuah puskesmas di perkotaan mengadopsi aplikasi mobile untuk memantau tumbuh kembang anak dan mengingatkan jadwal imunisasi. Perawat bertugas menginput data anak dan memberi edukasi kepada orang tua tentang pentingnya imunisasi.

3. Strategi Menghadapi Tantangan dalam Keperawatan Anak

Untuk mengatasi berbagai tantangan, perawat anak dapat menerapkan strategi berikut:

- a. Peningkatan Kompetensi: Mengikuti pelatihan dan seminar untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan klinis.

- b. Advokasi Kesehatan: Mengajukan usulan kepada pemangku kebijakan agar meningkatkan fasilitas kesehatan anak.
- c. Pemberdayaan Keluarga: Melibatkan keluarga dalam proses perawatan agar mereka dapat membantu mempercepat proses penyembuhan anak.
- d. Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan aplikasi atau perangkat medis terkini untuk membantu diagnosis dan pemantauan pasien.

Contoh Kasus: Seorang perawat di rumah sakit anak menginisiasi program “Kelas Edukasi Orang Tua” yang membahas topik seperti pertolongan pertama pada anak dan nutrisi sehat. Program ini mendapat respon positif, meningkatkan kolaborasi antara perawat dan keluarga.

D. Perkembangan Kebijakan dan Regulasi dalam Keperawatan Anak

1. Kebijakan Kesehatan Anak di Indonesia

Kebijakan kesehatan anak di Indonesia terus berkembang seiring waktu untuk mengatasi berbagai tantangan kesehatan. Beberapa kebijakan utama meliputi:

- a. Program Imunisasi Nasional: Bertujuan meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap untuk mencegah penyakit menular pada anak.
- b. Gerakan Nasional Pencegahan Stunting: Dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan untuk mencegah stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif.
- c. Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA): Mengedepankan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Contoh Kasus: Di sebuah daerah rawan stunting, perawat bekerja sama dengan petugas kesehatan masyarakat untuk menjalankan program pemberian makanan tambahan bagi balita. Mereka juga memberikan edukasi gizi kepada ibu agar anak-anak mendapat asupan nutrisi yang cukup.

2. Regulasi dalam Keperawatan Anak

Perawat anak di Indonesia bekerja berdasarkan regulasi yang mengatur praktik keperawatan, di antaranya:

- a. Undang-Undang Keperawatan No. 38 Tahun 2014: Mengatur peran, tanggung jawab, dan kewenangan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan, termasuk pada anak.
- b. Standar Profesi Perawat Anak: Disusun oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) untuk memastikan bahwa perawat anak memberikan pelayanan sesuai standar etika dan kompetensi.
- c. Hak Anak atas Kesehatan: Berdasarkan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child, CRC*) yang telah diratifikasi Indonesia, anak-anak memiliki hak untuk memperoleh perawatan kesehatan terbaik.

Contoh Kasus: Seorang perawat anak di rumah sakit menggunakan pedoman dari UU No. 38 Tahun 2014 untuk memastikan bahwa hak anak terkait persetujuan tindakan medis (*informed consent*) selalu melibatkan orang tua dan mempertimbangkan pendapat anak sesuai usia dan tingkat pemahamannya.

3. Peran Perawat dalam Mengimplementasikan Kebijakan

Perawat memiliki peran krusial dalam mengimplementasikan kebijakan kesehatan anak, seperti:

- a. Edukator: Memberikan edukasi kepada keluarga tentang kebijakan imunisasi dan program pencegahan penyakit.
- b. Advokat: Membela hak anak atas pelayanan kesehatan yang layak dan aman.
- c. Kolaborator: Bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain untuk menjalankan program nasional seperti imunisasi massal atau kampanye pencegahan stunting.
- d. Peneliti: Melakukan riset kecil untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan di lapangan dan memberikan masukan untuk perbaikan.

Contoh Kasus: Perawat di sebuah puskesmas mengadakan sesi diskusi bersama ibu-ibu tentang pentingnya imunisasi dan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang akurat, membantu meningkatkan cakupan imunisasi hingga 95% di komunitas tersebut.

E. Inovasi dan Teknologi dalam Keperawatan Anak

1. Inovasi dalam Pelayanan Kesehatan Anak

Inovasi dalam keperawatan anak bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat proses penyembuhan. Beberapa inovasi yang diterapkan meliputi:

- a. *Telehealth dan Telemedicine*: Memungkinkan perawat untuk melakukan konsultasi jarak jauh, memantau kondisi anak, dan memberikan edukasi kesehatan kepada orang tua tanpa harus bertemu langsung.
- b. Aplikasi Kesehatan Anak: Aplikasi yang memantau tumbuh kembang anak, jadwal imunisasi, serta memberikan informasi terkait pola makan dan aktivitas fisik yang sehat.
- c. Metode Non-Farmakologi untuk Manajemen Nyeri: Seperti terapi bermain, musik, dan teknik distraksi untuk membantu anak mengatasi ketakutan atau nyeri selama tindakan medis.
- d. Robot Terapi: Robot seperti "PARO" digunakan di beberapa rumah sakit untuk memberikan dukungan emosional kepada anak-anak yang menjalani rawat inap jangka panjang.

Contoh Kasus: Seorang perawat di rumah sakit menggunakan aplikasi "PrimaKu" untuk membantu ibu memantau pertumbuhan bayinya. Dengan notifikasi

otomatis untuk jadwal imunisasi, cakupan imunisasi di komunitas tersebut meningkat hingga 90% dalam enam bulan.

2. Teknologi Medis dalam Perawatan Anak

Teknologi medis modern membantu meningkatkan akurasi diagnosis dan pengobatan anak, seperti:

- a. *Monitor Vital Signs Portable*: Memungkinkan perawat untuk memantau tanda-tanda vital anak secara real-time, bahkan saat anak dipindahkan antar-ruangan.
- b. *Smart Infusion Pump*: Mengatur pemberian obat intravena secara presisi, mengurangi risiko kesalahan dosis.
- c. *Virtual Reality (VR)*: Digunakan untuk mengurangi kecemasan anak selama prosedur medis tertentu, seperti pengambilan darah atau imunisasi.

Contoh Kasus: Sebuah rumah sakit anak menggunakan teknologi VR untuk mengalihkan perhatian anak selama prosedur injeksi. Studi internal menunjukkan bahwa 80% anak melaporkan lebih sedikit rasa takut dan nyeri dibandingkan metode tradisional.

3. Peran Perawat dalam Penerapan Inovasi dan Teknologi

Perawat memiliki peran penting dalam memastikan teknologi dan inovasi diterapkan secara efektif, di antaranya:

- a. Edukator: Mengajarkan keluarga cara menggunakan aplikasi kesehatan dan teknologi pemantauan jarak jauh.
- b. Kolaborator: Bekerja sama dengan tim IT rumah sakit untuk memastikan teknologi medis berfungsi optimal.
- c. Advokat: Memastikan inovasi dan teknologi yang digunakan ramah anak dan tidak mengabaikan aspek psikologis pasien.
- d. Peneliti: Melakukan riset tentang efektivitas teknologi tertentu, seperti VR atau robot terapi, dalam meningkatkan hasil kesehatan anak.

Contoh Kasus: Seorang perawat anak di rumah sakit riset terlibat dalam studi tentang efektivitas penggunaan aplikasi tumbuh kembang. Hasilnya dipublikasikan dalam jurnal nasional dan menjadi dasar adopsi teknologi tersebut di fasilitas kesehatan lain.

F. Kolaborasi Interprofesional dalam Keperawatan Anak

1. Konsep Kolaborasi Interprofesional

Kolaborasi interprofesional adalah proses di mana tenaga kesehatan dari berbagai profesi bekerja sama secara sinergis untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pasien. Dalam keperawatan anak, kolaborasi ini melibatkan dokter anak, ahli gizi, fisioterapis, psikolog, farmasis, dan pekerja sosial.

Prinsip utama kolaborasi interprofesional meliputi:

- a. Komunikasi Terbuka: Pertukaran informasi yang jelas dan tepat waktu antar-profesi.
- b. Respek dan Saling Percaya: Menghargai kontribusi masing-masing profesi dalam perawatan anak.
- c. Pengambilan Keputusan Bersama: Memastikan keputusan yang diambil memperhatikan perspektif semua pihak.
- d. Tanggung Jawab Bersama: Berbagi tanggung jawab atas hasil perawatan anak.

2. Manfaat Kolaborasi Interprofesional dalam Keperawatan Anak

Kolaborasi interprofesional memiliki dampak positif bagi pelayanan kesehatan anak, di antaranya:

- a. Peningkatan Kualitas Perawatan: Memastikan bahwa semua aspek kesehatan anak — fisik, mental, dan sosial — diperhatikan.
- b. Pencegahan Kesalahan Medis: Komunikasi yang baik membantu mengurangi risiko kesalahan, seperti pemberian obat yang salah.
- c. Peningkatan Kepuasan Pasien dan Keluarga: Keluarga merasa lebih didukung ketika tim kesehatan bekerja sama.
- d. Efisiensi Perawatan: Mengurangi waktu rawat inap dengan koordinasi interprofesional yang efektif.

3. Implementasi Kolaborasi Interprofesional

Dalam praktik keperawatan anak, kolaborasi interprofesional dapat diterapkan dalam berbagai situasi, seperti:

- a. Perawatan Anak dengan Penyakit Kronis: Anak dengan diabetes tipe 1 memerlukan perawat yang bekerja sama dengan dokter anak, ahli gizi, dan psikolog untuk mengatur pola makan, dosis insulin, serta dukungan emosional.
- b. Program Pencegahan Stunting: Perawat berkolaborasi dengan ahli gizi dan petugas kesehatan masyarakat untuk memberikan edukasi gizi kepada keluarga dan memantau tumbuh kembang anak.
- c. Manajemen Nyeri: Untuk anak yang menjalani operasi, perawat bekerja sama dengan dokter anastesi, farmasis, dan psikolog anak untuk mengelola nyeri secara efektif.

Contoh Kasus: Seorang anak penderita leukemia dirawat di rumah sakit. Tim interprofesional yang terdiri dari dokter anak, perawat, ahli gizi, dan psikolog bekerja sama untuk menyusun rencana perawatan holistik. Perawat bertanggung jawab memantau tanda vital dan efek samping kemoterapi, ahli gizi merancang pola makan khusus untuk menjaga kekebalan tubuh anak, sementara psikolog membantu mengelola kecemasan anak selama pengobatan.

Kolaborasi ini terbukti meningkatkan kepatuhan anak terhadap pengobatan dan mempercepat proses pemulihan.

4. Tantangan dan Solusi dalam Kolaborasi Interprofesional

Meskipun kolaborasi interprofesional memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti:

- a. Kurangnya Komunikasi: Informasi yang tidak tersampaikan dengan baik dapat menyebabkan kesalahan medis.
- b. Hierarki Profesi: Adanya kesenjangan antar-profesi dapat menghambat pengambilan keputusan bersama.
- c. Keterbatasan Sumber Daya: Fasilitas kesehatan dengan staf terbatas sering kesulitan mengimplementasikan kolaborasi interprofesional.

Solusi:

- a. Mengadakan pelatihan komunikasi efektif untuk seluruh tenaga kesehatan.
- b. Mendorong budaya kerja sama dan saling menghargai di antara profesi kesehatan.
- c. Menggunakan teknologi informasi untuk memfasilitasi pertukaran data pasien secara real-time.

G. Tren dalam Praktik Keperawatan Anak

1. Pengantar Tren Keperawatan Anak

Praktik keperawatan anak terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan kesehatan. Perawat anak dituntut untuk memahami tren terbaru guna memberikan pelayanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarganya. Tren ini mencakup pendekatan baru dalam asuhan keperawatan, integrasi teknologi, serta metode berbasis bukti (*evidence-based practice*).

2. Terkini dalam Praktik Keperawatan Anak

Beberapa tren penting dalam keperawatan anak meliputi:

a. Family-Centered Care (FCC)

FCC menekankan kemitraan antara perawat dan keluarga pasien. Keluarga dianggap sebagai bagian integral dari tim kesehatan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan klinis.

Contoh: Di rumah sakit pediatrik, perawat bekerja sama dengan orang tua anak dengan asma untuk menyusun rencana pencegahan serangan asma, termasuk edukasi mengenai pemicu dan penggunaan inhaler.

b. Evidence-Based Practice (EBP)

Penerapan praktik keperawatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaru, dikombinasikan dengan pengalaman klinis dan preferensi pasien.

Contoh: Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan terapi musik selama prosedur medis (misalnya, pengambilan darah) dapat mengurangi kecemasan dan rasa sakit pada anak (Kingsnorth et al., 2011).

c. Pemanfaatan Teknologi Kesehatan

Teknologi seperti aplikasi pemantauan tumbuh kembang, rekam medis elektronik (RME), dan telemedicine menjadi alat penting dalam keperawatan anak.

Contoh: Seorang perawat menggunakan aplikasi "PrimaKu" untuk membantu orang tua memantau pertumbuhan dan jadwal imunisasi bayi, meningkatkan cakupan imunisasi hingga 95% di suatu komunitas.

d. Perawatan Holistik dan Kesehatan Mental Anak

Tren terbaru menekankan pentingnya memperhatikan kesehatan mental anak, bukan hanya kondisi fisiknya.

Contoh: Anak dengan penyakit kronis seperti kanker menerima dukungan psikososial dari perawat yang berkolaborasi dengan psikolog untuk mengurangi stres dan kecemasan.

e. *Sustainable Healthcare dan Green Nursing*

Praktik keperawatan yang berorientasi pada keberlanjutan, termasuk pengurangan limbah medis dan penggunaan produk ramah lingkungan.

Contoh: Perawat anak di unit pediatrik menerapkan prinsip green nursing dengan menggunakan alat medis reusable dan mendidik anak serta keluarga tentang pentingnya menjaga lingkungan.

3. Dampak Tren terhadap Praktik Keperawatan Anak

Tren ini memiliki dampak signifikan terhadap keperawatan anak, seperti:

- a. Peningkatan Kualitas Asuhan: Evidence-based practice memastikan bahwa intervensi yang dilakukan aman dan efektif.
- b. Keterlibatan Keluarga: Family-centered care memperkuat dukungan emosional dan fisik anak melalui keterlibatan aktif keluarga.
- c. Akses Pelayanan yang Lebih Baik: Telehealth memudahkan konsultasi jarak jauh, terutama bagi anak-anak di daerah terpencil.

4. Tantangan dan Solusi dalam Mengadopsi Tren Baru

a. Kurangnya Pelatihan

Solusi: Mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi perawat anak terkait teknologi baru dan praktik berbasis bukti.

b. Keterbatasan Akses Teknologi

Solusi: Mendorong kolaborasi antara fasilitas kesehatan dan lembaga pemerintah untuk menyediakan teknologi yang merata.

c. Resistensi Terhadap Perubahan

Solusi: Membangun budaya inovasi dan mendorong diskusi terbuka terkait manfaat tren baru bagi anak dan keluarganya.

H. Riset dan Inovasi dalam Keperawatan Anak

1. Pengantar Riset dan Inovasi dalam Keperawatan Anak

Riset dan inovasi memegang peranan penting dalam pengembangan praktik keperawatan anak. Dengan riset, perawat dapat menerapkan intervensi berbasis bukti (*evidence-based practice*), sedangkan inovasi membantu menciptakan solusi kreatif yang meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Kombinasi keduanya mendorong perkembangan profesi keperawatan yang adaptif dan relevan dengan tantangan kesehatan anak masa kini.

2. Jenis-Jenis Riset dalam Keperawatan Anak

Riset dalam keperawatan anak umumnya dikategorikan menjadi:

a. Riset Kuantitatif

Menggunakan data numerik untuk mengukur hasil intervensi keperawatan.

Contoh: Studi eksperimen untuk membandingkan efektivitas terapi musik dan teknik distraksi dalam mengurangi nyeri prosedural pada anak kanker (Kingsnorth et al., 2011).

b. Riset Kualitatif

Mengeksplorasi pengalaman subjektif pasien, keluarga, dan perawat.

Contoh: Wawancara mendalam dengan orang tua anak prematur untuk memahami kebutuhan emosional mereka selama masa perawatan intensif.

c. Riset Campuran (Mixed Methods)

Menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memahami fenomena secara lebih komprehensif.

Contoh: Studi yang mengukur tingkat kecemasan anak sebelum dan sesudah intervensi terapi bermain, dilengkapi wawancara tentang pengalaman mereka.

d. Riset Tindakan (Action Research)

Bertujuan memecahkan masalah klinis tertentu dan langsung mengaplikasikan hasilnya dalam praktik.

Contoh: Penerapan program pencegahan stunting berbasis komunitas dengan evaluasi berkelanjutan.

3. Inovasi dalam Keperawatan Anak

Beberapa inovasi yang sedang berkembang dalam praktik keperawatan anak meliputi:

a. Pemanfaatan Teknologi Digital

Aplikasi kesehatan untuk memantau pertumbuhan anak, telehealth, dan rekam medis elektronik.

Contoh: Aplikasi "PrimaKu" membantu perawat memantau imunisasi anak dan memberikan edukasi kepada orang tua.

b. Robotika dan Artificial Intelligence (AI)

Robot pendamping untuk memberikan dukungan psikososial atau membantu anak dengan kebutuhan khusus.

Contoh: Robot "*Pepper*" digunakan di beberapa rumah sakit untuk menghibur anak selama prosedur medis, mengurangi kecemasan mereka.

c. Inovasi Terapi Non-Farmakologis

Metode seperti terapi seni, terapi musik, dan permainan medis untuk membantu anak mengelola nyeri dan stres.

Contoh: Studi menunjukkan bahwa terapi seni membantu anak-anak penderita kanker mengekspresikan emosi mereka, meningkatkan kesejahteraan psikologis.

d. Perawatan Kolaboratif Berbasis Aplikasi

Platform daring yang memfasilitasi komunikasi antara perawat, dokter, dan keluarga pasien.

Contoh: Aplikasi "SehatKita" memungkinkan perawat anak memberikan laporan harian kepada keluarga tentang kondisi anak selama rawat inap.

4. Contoh Kasus Riset dan Inovasi

Kasus 1: Seorang perawat anak di rumah sakit pediatrik memimpin riset tentang efektivitas terapi musik untuk mengurangi nyeri prosedural pada anak dengan kanker. Hasil menunjukkan bahwa anak yang mendengarkan musik sebelum dan selama prosedur menunjukkan skor nyeri 30% lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol.

Kasus 2: Di sebuah klinik komunitas, perawat menerapkan aplikasi "PrimaKu" untuk memantau pertumbuhan anak-anak. Data menunjukkan bahwa cakupan imunisasi meningkat 20% dalam 6 bulan setelah aplikasi tersebut digunakan.

5. Tantangan dan Solusi dalam Riset dan Inovasi

Tantangan:

- Keterbatasan Dana: Banyak riset keperawatan anak terkendala minimnya sumber daya finansial.
- Kurangnya Kolaborasi: Belum optimalnya kolaborasi antara perawat, peneliti, dan institusi akademis.
- Resistensi Terhadap Teknologi: Beberapa perawat merasa enggan menggunakan teknologi baru.

Solusi:

- Meningkatkan akses dana hibah riset melalui kerja sama dengan pemerintah dan lembaga swasta.

- b. Mendorong riset kolaboratif lintas profesi untuk memperkuat validitas hasil penelitian.
- c. Mengadakan pelatihan rutin terkait teknologi kesehatan untuk meningkatkan kesiapan perawat.

I. Penutup

Buku ajar ini telah membahas berbagai tren dan isu kontemporer dalam keperawatan anak, mulai dari konsep dasar hingga inovasi dan riset terbaru. Perawat anak memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi anak-anak melalui pendekatan holistik, kolaboratif, dan berbasis bukti. Diharapkan buku ini tidak hanya menjadi sumber referensi bagi mahasiswa keperawatan, tetapi juga menginspirasi praktisi untuk terus meningkatkan kompetensi dan mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam merawat anak.

Masa depan keperawatan anak bergantung pada kemampuan para perawat untuk beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan teknologi serta hasil riset terbaru. Kolaborasi interprofesional, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan inovasi harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas asuhan keperawatan anak. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan profesi keperawatan dan kesehatan anak di Indonesia.

J. Latihan

Pilihan Ganda

1. Salah satu tren dalam keperawatan anak adalah:
 - a. Pemanfaatan telemedicine.
 - b. Penurunan penggunaan teknologi.
 - c. Perawatan berbasis individu tanpa melibatkan keluarga.
 - d. Pemisahan anak dari keluarga selama perawatan.
2. Tantangan utama dalam keperawatan anak di daerah terpencil adalah:
 - a. Kelebihan tenaga medis.
 - b. Aksesibilitas layanan kesehatan.
 - c. Keterbatasan komunikasi dengan pasien.
 - d. Kurangnya pasien.

Essai

1. Jelaskan dampak kekurangan tenaga keperawatan anak terhadap kualitas pelayanan kesehatan.
2. Berikan contoh solusi inovatif untuk mengatasi kesenjangan akses layanan kesehatan pada anak.

Kunci Jawaban

Pilihan Ganda

1. a. Pemanfaatan telemedicine.
2. b. Aksesibilitas layanan kesehatan.

Essai

1. Jawaban dapat mencakup penurunan kualitas layanan, peningkatan risiko kesalahan medis, dan beban kerja yang tinggi pada tenaga kesehatan.
2. Jawaban dapat mencakup penggunaan telemedicine, pelatihan komunitas lokal, atau penyediaan fasilitas kesehatan bergerak.

K. Glosarium

Telemedicine: Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh.

Perawatan Berbasis Keluarga: Model perawatan yang melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan dan pemberian perawatan.

Informed Consent: Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau wali setelah mendapatkan penjelasan lengkap tentang prosedur medis.

L. Daftar Pustaka

- Black, M. M., Walker, S. P., Fernald, L. C. H., Andersen, C. T., DiGirolamo, A. M., Lu, C., McCoy, D. C., Fink, G., Shawar, Y. R., Shiffman, J., Devercelli, A. E., Wodon, Q. T., Vargas-Barón, E., & Grantham-McGregor, S. (2017). Early childhood development coming of age: science through the life course. *The Lancet*, 389(10064), 77–90. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)31389-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31389-7)
- Jane W. Ball, R. M. B. K. J. C. M. R. S. (2019). *Child Health Nursing: Partnering with Children & Families* (3rd ed., Vol. 3). Pearson.
- Kingsnorth, S., Treurnicht Naylor, K., Lamont, A., McKeever, P., & MacArthur, C. (2011). The effectiveness of music in pediatric healthcare: A systematic review of randomized controlled trials. In *Evidence-based Complementary and Alternative Medicine* (Vol. 2011). <https://doi.org/10.1155/2011/464759>
- Marilyn J. Hockenberry, David Wilson, & Cheryl C Rodgers. (2019). *Wong's Essentials of Pediatric Nursing: Vol. (10th ed.)*. Mosby.
- National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), D. of V. D. (2023). *Myths and Facts about COVID-19 Vaccines Bust Common Myths and*

Learn the Facts. https://archive.cdc.gov/www_cdc_gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html

GINA-Main-Report-2022-FINAL-22-07-01-WMS. (n.d.).

WHO. (2024). Mental health of adolescents. WHO, 1(1), 1–10.

BAB 3

MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT DI TATANAN PELAYANAN KESEHATAN

Pendahuluan

Balita merupakan kelompok usia yang beresiko terhadap penyakit infeksi dan gangguan kesehatan lainnya meningkatnya angka kesakitan dan kematian pada balita terutama di negara berkembang akan menjadi tantangan utama dalam bidang kesehatan di masyarakat. Hal ini diperburuk dengan terbatasnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, pengetahuan masyarakat yang kurang tentang perawatan balita dan belum optimalnya upaya pencegahan yang dilakukan.

Dalam rangka menjawab tantangan ini, *World Health Organization* (WHO) dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) mengembangkan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). MTBS ini adalah salah satu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan balita dengan pengelolaan kasus yang komprehensif dan terintegrasi. Pendekatan ini mengacu pada penilaian dan pengobatan penyakit, namun ada upaya pencegahan, promosi kesehatan dan edukasi pada keluarga balita.

Bab ini akan membahas tentang konsep, strategi dan penerapan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan MTBS, langkah-langkah dalam melakukan penilaian MTBS serta penilaian, klasifikasi dan tindakan atau pengobatan. Dengan adanya panduan MTBS akan mempermudah tenaga kesehatan, pendidik dan mahasiswa dalam memahami dan mengimplementasikan langkah-langkah penilaian MTBS dalam menangani balita sakit mulai dari pengenalan tanda bahaya serius, pengelolaan kasus sesuai klasifikasi hingga memberikan edukasi pada orang tua.

Tujuan Intruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami, menerapkan dan mengevaluasi langkah-langkah penilaian MTBS untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Tujuan Instruksional Khusus:

- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Manajemen Terpadu Balita Sakit
- Mahasiswa mampu menjelaskan strategi dan penerapan pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit
- Mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit
- Mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan Manajemen Terpadu Balita Sakit
- Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan penilaian, klasifikasi, tindakan/ pengobatan Manajemen Terpadu Balita Sakit

Capaian Pembelajaran:**Kognitif:**

1. Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep tentang MTBS
2. Mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan penerapan praktik MTBS pada studi kasus asuhan keperawatan

Psikomotor

1. Mahasiswa mampu melakukan tindakan keperawatan yang spesifik dan tepat dalam melakukan aplikasi penilaian, klasifikasi, tindakan/ pengobatan MTBS
2. Mahasiswa dapat berinteraksi secara profesional dengan pasien dan tim kesehatan, mengedukasi pasien dan bekerja dalam tim multidisipliner

Afektif

1. Mahasiswa dapat menunjukkan sikap empati pada pasien dan bertindak sesuai kode etik keperawatan
2. Mahasiswa memiliki sikap dalam memberikan pelayanan terbaik pada pasien dengan penuh tanggung jawab
3. Mahasiswa menunjukkan sikap terbuka dan kepedulian dalam berinteraksi dengan pasien, keluarga dan tim perawatan kesehatan
4. Mahasiswa dapat berkomunikasi dengan jelas dan efektif baik dalam edukasi pasien maupun dalam koordinasi dengan anggota tim kesehatan lainnya

A. Definisi MTBS

MTBS adalah suatu bentuk pengelolaan balita sakit umur 0-5 tahun, yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan anak serta kualitas pelayanan kesehatan anak. MTBS merupakan cara yang efektif dalam menurunkan angka kematian pada bayi dan anak. Pengelolaan balita sakit dilaksanakan secara bersamaan dan penanganan kasus tidak terpisah-pisah, yang meliputi manajemen anak sakit, pemberian nutrisi, pemberian imunisasi, pencegahan penyakit serta promosi untuk tumbuh kembang (Kemenkes RI, 2022)

Pada Tahun 1996, MTBS mulai diperkenalkan di Indonesia oleh *World Health Organization* (WHO). Pada Tahun 1997 Depkes RI bersama dengan WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) melaksanakan adaptasi modul MTBS WHO. MTBS merupakan standar pelayanan dan tatalaksana untuk menangani balita sakit yang datang ke pelayanan kesehatan pertama yaitu Puskesmas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan petugas kesehatan, dukungan sistem kesehatan dan meningkatkan praktik keluarga serta masyarakat dalam perawatan balita sakit di rumah.

Konsep utama MTBS adalah:

1. Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam pengelolaan penyakit pada balita
 2. Perbaikan sistem pelayanan kesehatan termasuk dalam penyediaan obat esensial
 3. Meningkatkan peran keluarga dan masyarakat dalam perawatan balita sakit
- (Subedi et al., 2024; Vhuromu et al., 2022)

B. Strategi dan Penerapan MTBS

Adapun strategi dan penerapan dalam pelaksanaan MTBS adalah:

- a. Kuratif yaitu penanganan langsung pada balita yang sakit seperti pneumonia, diare, malaria, campak, demam berdarah, masalah telinga dan masalah gizi
- b. Promotif dan preventif yaitu melakukan konseling gizi, konseling pemberian ASI, suplemen vitamin A dan pengobatan terhadap cacing.

Tenaga kesehatan yang dapat melaksanakan MTBS yaitu dokter, perawat dan bidan. Adapun peran dalam MTBS yaitu:

- a. Melaksanakan SOP pelayanan balita menggunakan format MTBS
- b. Dokter bersama perawat dan bidan melaksanakan SOP pelayanan balita dengan menggunakan format MTBS
- c. Dokter menerima rujukan internal dari poli KIA

- d. Memberikan contoh kepada semua petugas kesehatan dan menerapkan layanan kuratif tanpa meninggalkan upaya promotif dan preventif
- e. Melakukan integrasi pelayanan program dan pelayanan kuratif (Ernawati et al., 2023; Kemenkes RI, 2022)

Penerapan MTBS dapat dilaksanakan pada:

a. Puskesmas dan Klinik

Penerapan MTBS di Puskesmas dan klinik dilaksanakan dengan melibatkan tenaga kesehatan yang kompeten. Penerapan ini berkaitan dengan algoritma keputusan klinis dan tersedianya alat serta obat yang mendukung tatalaksana balita sakit.

b. Rumah Sakit

Penerapan MTBS digunakan untuk pendekatan awal dalam menilai dan menstabilkan kondisi pasien sebelum dirujuk ke spesialis bila diperlukan. Penerapan MTBS dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih.

c. Keluarga dan Masyarakat

Penerapan MTBS dalam deteksi dini dan perawatan balita sakit di rumah dapat dilakukan oleh keluarga. Edukasi sangat penting antara lain mengenai pemberian ASI, gizi seimbang, imunisasi serta tanda bahaya penyakit yang perlu diketahui oleh keluarga ketika anak sakit.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan MTBS

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan MTBS adalah:

1. Faktor tenaga kesehatan, yaitu:
 - a. Tersedianya tenaga kesehatan yang terlatih dalam penerapan MTBS
 - b. Adanya keterampilan dan pengetahuan tenaga kesehatan dalam menilai dan menangani balita sakit
2. Faktor sarana dan prasarana, yaitu:
 - a. Tersedianya alat kesehatan dan obat esensial di fasilitas pelayanan kesehatan
 - b. Infrastruktur yang mendukung aksesibilitas pelayanan MTBS
3. Faktor keluarga dan masyarakat, yaitu:
 - a. Tingkat pemahaman orang tua tentang MTBS dan perawatan balita sakit yang masih kurang
 - b. Belum optimalnya dukungan sosial dan ekonomi dalam memberikan nutrisi dan akses pelayanan kesehatan bagi balita
4. Faktor kebijakan dan sistem kesehatan, yaitu:
 - a. Kebijakan pemerintah dalam mendukung implementasi MTBS di pelayanan kesehatan primer yang belum optimal

- b. Belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan kasus MTBS dalam pemantauan dan evaluasi program

D. Langkah-Langkah Dalam Melakukan MTBS

Adapun langkah-langkah dalam melakukan MTBS adalah:

1. Penilaian adanya tanda dan gejala adanya suatu penyakit : lihat, dengar, raba atau melakukan pemeriksaan fisik dan anamnesa.
2. Membuat klasifikasi dengan menentukan tingkat kegawatan dari suatu penyakit untuk menentukan tindakan
3. Menentukan tindakan : mengobati, memberikan konseling, membuat resep, mengajari ibu tentang obat dan tindakan yang harus dilakukan dirumah.
4. Memberikan konseling dengan menilai cara pemberian makan dan kapan anak harus kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan
5. Memberikan pelayanan tindak lanjut pada kunjungan ulang

E. Penilaian, Klasifikasi, Tindakan/ Pengobatan Manajemen Terpadu Balita Sakit

Adapun penilaian, klasifikasi, tindakan/ pengobatan MTBS menurut Kemenkes RI (2022) adalah:

1. MTBS Anak Sakit Usia 2 Bulan Sampai 5 Tahun

a. Identifikasi tanda bahaya umum yaitu:

- 1) Apakah anak tidak bisa minum atau menyusu?
- 2) Apakah anak muntah terus-menerus?
- 3) Apakah anak mengalami kejang?
- 4) Apakah anak tampak letargis atau tidak sadar?

Jika terdapat salah satu tanda bahaya di atas, segera rujuk anak ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

b. Apakah anak menderita batuk dan/atau sukar bernapas?

Lihat, dengar dan periksa frekuensi nafas anak dan ada tidaknya tarikan dinding dada. Nafas cepat bila ≥ 50 x/menit (2 bulan-12 bulan) dan ≥ 40 x/menit (12 bulan-5 tahun).

Klasifikasinya terbagi atas:

- 1) Batuk bukan pneumonia (tidak ada tarikan dinding dada bagian bawah kedalam dan tidak ada nafas cepat), tindakan/pengobatannya adalah:
 - a) Beri pelega tenggorokan dan pereda batuk yang aman
 - b) Obati wheezing bila ada
 - c) Apabila batuk ≥ 2 minggu, lacak kemungkinan TB
 - d) Kunjungan ulang 5 hari jika tidak ada perbaikan
 - e) Nasihati kapan harus kembali segera

- 2) Pneumonia (nafas cepat), tindakan/ pengobatannya adalah:
 - a) Beri amoksisilin 2x sehari selama 3 hari atau 5 hari
 - b) Beri pelega tenggorokan dan pereda batuk yang aman
 - c) Obati wheezing bila ada · Apabila batuk ≥ 2 minggu, RUJUK untuk pemeriksaan TB dan sebab lain
 - d) Kunjungan ulang 2 hari
 - e) Nasihati kapan harus kembali segera
- 3) Pneumonia berat (adanya tarikan dinding dada ke dalam atau saturasi oksigen $\leq 92\%$), tindakan/pengobatannya adalah:
 - a) Beri oksigen 1-4 L/menit dengan menggunakan nasal prongs
 - b) Beri dosis pertama antibiotik yang sesuai
 - c) Obati wheezing bila ada
 - d) RUJUK SEGERA

c. Apakah anak menderita diare?

Periksa apakah ada tanda-tanda dehidrasi, sudah berapa lama dan adakah darah dalam tinja. Klasifikasinya terbagi atas:

- 1) Untuk dehidrasi, dibagi menjadi:
 - a) Diare tanpa dehidrasi (Tidak cukup tanda-tanda untuk diklasifikasikan sebagai diare dehidrasi berat, ringan/sedang). Tindakan/pengobatannya:
 - Beri cairan, tablet zinc, dan makanan sesuai Rencana Terapi A
 - Kunjungan ulang 2 hari jika tidak ada perbaikan
 - Nasihati kapan harus kembali segera
 - b) Diare dehidrasi ringan/sedang (Terdapat dua atau lebih tanda-tanda berikut yaitu rewel/mudah marah, mata cekung, haus, minum dengan lahap, cubitan kulit perut kembali lambat). Tindakan/pengobatannya:
 - Beri cairan, tablet zinc, dan makanan sesuai Rencana Terapi B
 - Jika terdapat klasifikasi berat lain: RUJUK SEGERA, Jika masih bisa minum, berikan ASI dan larutan oralit selama perjalanan
 - Kunjungan ulang 2 hari jika tidak ada perbaikan
 - Nasihati kapan harus kembali segera
 - c) Diare dehidrasi berat (Terdapat dua atau lebih tanda-tanda berikut yaitu letargi atau tidak sadar , mata cekung, Tidak bisa minum atau malas minum, cubitan kulit perut kembali sangat lambat). Tindakan/ pengobatannya:
 - Jika tidak ada klasifikasi berat lain, beri cairan untuk dehidrasi berat dan tablet zinc sesuai Rencana Terapi C
 - Jika anak juga mempunyai klasifikasi berat lain: RUJUK SEGERA, Jika masih bisa minum, berikan ASI dan larutan oralit selama perjalanan

- Jika anak > 2 tahun dan ada wabah kolera di daerah tersebut, beri antibiotik untuk kolera.
- 2) Jika diare 14 hari atau lebih, dibagi menjadi:
- a) Diare persisten (Tanpa dehidrasi). Tindakan/pengobatannya:
 - Berikan oralit
 - Beri tablet zinc selama 10 hari berturut turut
 - Kunjungan ulang 2 hari
 - Nasihati kapan harus kembali segera
 - b) Diare persisten berat (dengan dehidrasi), tindakan/ pengobatan:
 - Atasi dehidrasi sebelum dirujuk, kecuali ada klasifikasi berat lain
 - RUJUK
- 3) Jika ada darah dalam tinja, dibagi menjadi:
- a) Disentri (ada darah dalam tinja). Tindakan/ pengobatan:
 - Berikan oralit
 - Beri tablet zinc selama 10 hari berturut turut
 - Nasihati pemberian makan
 - Beri antibiotik yang sesuai
 - Kunjungan ulang 2 hari
 - Nasihati kapan harus kembali segera

d. Apakah anak menderita demam?

Cek suhu dan Tentukan kemungkinan penyebab seperti malaria atau infeksi bakteri lainnya. Klasifikasinya terbagi atas:

- 1) Non endemis malaria dan tidak ada riwayat bepergian ke daerah endemis malaria, terdiri dari:
 - a) Demam bukan malaria (Tidak ada tanda bahaya umum dan tidak ada kaku kuduk) tindakan/pengobatannya:
 - Beri satu dosis parasetamol untuk demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$
 - Obati penyebab lain dari demam
 - Kunjungan ulang 2 hari jika tetap demam
 - Nasihati kapan harus kembali segera
 - Jika demam berlanjut lebih dari 7 hari, RUJUK untuk penilaian lebih lanjut
 - b) Penyakit berat dengan demam (ada tanda bahaya umum atau kaku kuduk atau umur ≤ 3 bulan), tindakan/pengobatannya:
 - Beri dosis pertama antibiotik yang sesuai
 - Cegah agar gula darah tidak turun
 - Beri satu dosis parasetamol untuk demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$
 - RUJUK SEGERA

- 2) Endemis malaria tinggi atau rendah, terdiri dari:
- a) Demam mungkin bukan malaria (Mikroskopis negatif atau RDT negatif atau ditemukan penyebab lain dari demam, tindakan/pengobatannya:
 - Beri satu dosis parasetamol untuk demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$
 - Obati penyebab lain dari demam
 - Kunjungan ulang 3 hari jika tetap demam
 - Nasihati kapan harus kembali segera
 - Jika demam berlanjut lebih dari 7 hari, RUJUK untuk penilaian lebih lanjut
 - b) Malaria Demam (pada anamnesis atau teraba panas atau suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$) dan mikroskopis positif atau RDT positif, tindakan/pengobatannya :
 - Beri obat anti malaria oral pilihan pertama
 - Beri satu dosis parasetamol untuk demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$
 - Kunjungan ulang 3 hari jika tetap demam
 - Nasihati kapan harus kembali segera
 - Jika demam berlanjut lebih dari 7 hari, RUJUK untuk penilaian lebih lanjut
 - c) Penyakit berat dengan demam Ada tanda bahaya ATAU (kaku kuduk), tindakan/pengobatannya:
 - Beri dosis pertama dengan artesunate injeksi (IM/IV) untuk malaria berat
 - Beri dosis pertama antibiotik yang sesuai
 - Cegah agar gula darah tidak turun · Berikan satu dosis parasetamol untuk demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$
 - Jika tersedia, lakukan Tes Malaria
 - RUJUK SEGERA
- 3) Klasifikasi penyakit campak, terdiri dari:
- a) Campak (campak sekarang/ dalam 3 bulan terakhir). Tindakan/pengobatannya:
 - Beri vitamin A dosis pengobatan
 - Nasihati kapan harus kembali segera
 - b) Campak dengan komplikasi pada mata dan atau mulut (ada nanah pada mata atau ada luka pada mulut), tindakan/pengobatannya:
 - Beri vitamin A dosis pengobatan
 - Jika ada nanah pada mata, beri tetes/salep mata antibiotik
 - Jika ada luka pada mulut, oleskan antiseptik mulut
 - Jika anak gizi buruk, beri vitamin A sesuai dosis
 - Kunjungan ulang 3 hari

- Nasihati kapan harus kembali segera
- c) Campak dengan komplikasi berat (ada tanda bahaya umum atau adanya kekeruhan pada kornea mata atau ada luka di mulut yang dalam atau luas, tindakan/pengobatannya:
- Beri vitamin A dosis pengobatan
 - Beri dosis pertama antibiotik yang sesuai
 - Jika ada kekeruhan pada kornea atau nanah pada mata, berikan tetes/salep mata antibiotik
 - Beri satu dosis parasetamol untuk demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$
 - RUJUK SEGERA

e. Apakah anak menderita demam atau riwayat demam 2-7 hari?

Kaji riwayat demam, periksa apakah ada tanda syok dan lakukan pemeriksaan darah. Klasifikasinya terbagi atas:

- 1) Demam mungkin bukan dengue (demam 2-7 hari tanpa satu pun tanda dan gejala yang telah disebutkan), tindakan/ pengobatannya:
 - Obati penyebab lain dari demam
 - Beri dosis pertama parasetamol jika demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$, tidak boleh golongan salisilat, natrium diklofenak, ibuprofen, atau NSAID lain
 - Kunjungan ulang 2 hari jika tetap demam atau anak tampak belum membaik
 - Nasihati kapan harus kembali segera
- 2) Dengue tanpa *warning sign* (terdapat satu atau lebih gejala berikut: nyeri dan pegal/ nyeri kepala, nyeri mata, nyeri otot, dan sendi, ruam, uji tourniquet positif, leukopenia (Leukosit $< 4000/\text{mcl}$) dan/atau trombositopenia). Tindakan/ pengobatannya:
 - Pasien dapat dipulangkan
 - Kunjungan ulang 1 hari
 - Jika jauh dari fasilitas kesehatan atau fasilitas tidak memadai, RUJUK untuk rawat inap
 - Observasi di rumah dengan nasihati kapan harus kembali segera
- 3) Dengue dengan *warning signs* (terdapat satu atau lebih gejala berikut nyeri perut dan nyeri tekan perut kanan atas, muntah terus menerus, klinis akumulasi cairan, perdarahan mukosa, letargi, gelisah, pembesaran hepar $>2\text{ cm}$, Laboratorium: peningkatan hematokrit dengan penurunan trombosit yang cepat. tindakan/ pengobatannya:
 - Beri dosis pertama parasetamol jika demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$, tidak boleh golongan salisilat, natrium diklofenak, ibuprofen, atau NSAID lain

- Jika anak tidak syok tetapi muntah terus, tidak dapat minum, atau perdarahan beri cairan kristaloid isotonis intravena Ringer Laktat/ NaCl 0,9% sesuai dengan pemberian cairan pra rujukan dengue tanpa syok
 - RUJUK SEGERA untuk rawat inap di rumah sakit
- 4) Dengue berat /*severe dengue* (terdapat tanda bahaya umum atau perembesan plasma hebat menyebabkan: Syok (Dengue Shock Syndrome): Kaki/tangan tampak pucat, Waktu pengisian kapiler > 2 detik, Kaki/tangan teraba dingin, Nadi lemah atau tidak teraba, Nadi cepat, Sesak napas, napas cepat ATAU Perdarahan saluran cerna, muntah darah atau coklat seperti kopi, BAB berdarah/berwarna hitam ATAU Gangguan fungsi organ: Penurunan kesadaran, Penurunan frekuensi denyut nadi, Ikterik, nyeri perut hebat, Tidak BAK selama 6 jam. tindakan/ pengobatannya:
- Jika ada syok, atau distres napas, beri oksigen 1–2 L/menit nasal prongs dan beri cairan kristaloid isotonis intravena Ringer Laktat/NaCl 0,9% sesuai pedoman kemudian RUJUK SEGERA
 - Jika tidak ada syok tetapi anak muntah terus, tidak dapat minum, penurunan kesadaran atau perdarahan, beri cairan kristaloid isotonis intravena Ringer Laktat/NaCl 0,9% tetesan rumatan kemudian RUJUK SEGERA
 - Beri dosis pertama parasetamol jika demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$, tidak boleh golongan salisilat, natrium diklofenak, ibuprofen, atau NSAID lain

f. Apakah anak mempunyai masalah telinga?

Periksa adanya nyeri telinga, cairan keluar, atau bengkak di sekitar telinga. Klasifikasinya terbagi atas:

- 1) Tidak ada infeksi telinga (tidak ada nyeri telinga dan tidak ada nanah keluar dari telinga). Tindakan/ pengobatannya:
 - Tangani masalah telinga yang ditemukan
 - Nasihati kapan harus kembali segera
- 2) Infeksi telinga kronis (tampak cairan/nanah keluar dari telinga dan telah terjadi selama 14 hari atau lebih). Tindakan/ pengobatannya:
 - Keringkan telinga dengan bahan penyerap setelah dicuci dengan NaCl 0,9% atau H₂O₂ 3%
 - Beri tetes telinga antibiotik yang sesuai jika ada
 - Kunjungan ulang 5 hari
 - Nasihati kapan harus kembali segera
- 3) Infeksi telinga akut (nyeri telinga atau rasa penuh di telinga atau tampak cairan/nanah keluar dari telinga selama < 14 hari). Tindakan/ pengobatannya:

- Beri antibiotik yang sesuai selama 10 hari
 - Beri parasetamol untuk mengatasi nyeri
 - Keringkan telinga dengan bahan penyerap
 - Jika terdapat cairan keluar dari telinga, beri obat tetes pencuci NaCl 0,9% atau H₂O₂ 3% dan obat tetes antibiotik yang sesuai
 - Kunjungan ulang 5 hari
 - Nasihati kapan harus kembali segera
- 4) Mastoiditis (pembengkakan yang nyeri di belakang telinga). Tindakan/ pengobatannya:
- Beri dosis pertama antibiotik yang sesuai
 - Beri dosis pertama parasetamol untuk mengatasi nyeri
 - RUJUK SEGERA

g. Memantau Pertumbuhan dan Memeriksa Status gizi

Periksa apakah anak mengalami tanda-tanda gizi buruk, dengan klasifikasi status gizi yaitu:

- 1) Gizi Baik (Skor Z BB/PB atau BB/TB -2 SD sampai $+1$ SD DAN $\cdot$ LiLA $\geq 12,5$ cm (6 - 59 bulan), tindakan/ pengobatannya adalah:
 - Jika anak < 2 tahun, nilai pemberian makan anak. Jika ada masalah, kunjungan ulang 7 hari
 - Timbang berat badan anak setiap bulan
- 2) Gizi Kurang (dengan satu atau lebih tanda berikut: $\cdot$ Skor Z BB/PB atau BB/TB -3 SD sampai < -2 SD $\cdot$ LiLA 11,5 cm - $< 12,5$ cm (6 - 59 bulan), tindakan/ pengobatannya adalah:
 - Nilai pemberian makan anak. Jika ada masalah, kunjungan ulang 7 hari
 - Lakukan skrining perkembangan sesuai SDIDTK
 - Kunjungan ulang 14 hari $\cdot$ Nasihati kapan harus kembali segera
 - RUJUK ke dokter untuk melacak kemungkinan adanya penyakit penyerta (TB, HIV, dan penyakit penyerta lainnya)
- 3) Gizi Buruk tanpa Komplikasi (dengan satu atau lebih tanda berikut: Edema minimal, pada kedua punggung kaki/tangan (edema derajat $+1$ atau $+2$) $\cdot$ Skor Z BB/PB atau BB/TB < -3 SD $\cdot$ LiLA $< 11,5$ cm (6 - 59 bulan). Tindakan/pengobatannya adalah:
 - Beri amoksisilin 15 mg/kgBB setiap 8 jam selama 5 hari
 - Beri vitamin A dosis pertama
 - Cegah gula darah tidak turun
 - Nasihati cara menjaga anak tetap hangat selama perjalanan
 - Lakukan skrining perkembangan sesuai SDIDTK
 - Jika disertai diare, berikan cairan Resomal

- Kunjungan ulang 7 hari
 - Nasihati kapan harus kembali segera
 - RUJUK ke dokter untuk penanganan gizi buruk, termasuk kemungkinan adanya penyakit penyerta (TB, HIV, dan penyakit penyerta lainnya)
- 4) Gizi Buruk dengan Komplikasi Umur 6-59 bulan (dengan satu atau lebih tanda berikut: edema pada seluruh tubuh (derajat +3), Skor Z BB/PB atau BB/TB < -3 SD, LiLA < 11,5 cm dan terdapat salah satu atau lebih tanda-tanda komplikasi medis berikut: anoreksia, dehidrasi berat (muntah terus menerus, diare), letargi atau penurunan kesadaran, demam tinggi, pneumonia berat, anemia berat) ATAU · BB < 4 kg Umur < 6 bulan, dengan satu atau lebih tanda berikut: · Skor Z BB/PB < -3 SD, ada edema , terlalu lemah untuk menyusu, berat badan tidak naik atau turun, terdapat tanda-tanda komplikasi medis). Tindakan/ pengobatannya adalah:
- Beri dosis pertama antibiotik ampicilin 50 mg/kgBB dan gentamisin 7,5 mg/kgBB secara IM/IV
 - Beri vitamin A dosis pertama
 - Cegah gula darah tidak turun
 - Nasihati cara menjaga anak tetap hangat selama perjalanan
 - Jika disertai syok, berikan cairan infus
 - Jika disertai diare, berikan cairan Resomal RUJUK SEGERA
- 5) Beresiko gizi lebih (Skor Z BB/PB atau BB/TB > +1 SD sampai +2 SD Plot IMT/U untuk menegaskan diagnosis obesitas). Tindakan/ pengobatannya adalah:
- Lakukan konseling gizi untuk menentukan penyebab
 - Kunjungan ulang 14 hari, jika tidak ada perbaikan, RUJUK
 - Nasihati kapan harus kembali segera
- 6) Gizi Lebih (Skor Z BB/PB atau BB/TB > +2 SD sampai +3 SD). Tindakan/ pengobatannya adalah:
- Lakukan konseling gizi dan aktivitas anak ke petugas gizi
 - Kunjungan ulang 14 hari, jika tidak ada perbaikan, RUJUK
 - Nasihati kapan harus kembali segera
- 7) Obesitas (Skor Z BB/PB atau BB/TB > +3 SD). Tindakan/ pengobatannya:
- RUJUK ke RS untuk penanganan lebih lanjut

h. Memeriksa status pertumbuhan

Periksa apakah ada tanda-tanda stunting dengan mengukur panjang badan atau tinggi badan berdasarkan umur. Klasifikasinya berdasarkan status pertumbuhan terbagi atas:

- 1) Normal (Skor Z PB/U atau TB/U -2 SD sampai $+3$ SD), tindakan/ pengobatannya:
 - Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan setiap bulan
- 2) Pendek (*stunted*) (Skor Z PB/U atau TB/U < -2 SD sampai -3 SD), tindakan/ pengobatannya:
 - Umur < 2 tahun: RUJUK ke RS
 - Umur ≥ 2 tahun: Rujuk internal untuk konfirmasi parameter status gizi yang lain (BB/U dan BB/PB atau BB/TB), SDIDTK, Buku KIA, KPSP. Jika terdapat satu atau lebih masalah (indikator antropometri tidak sesuai, masalah perkembangan, infeksi, tidak ada perubahan setelah dilakukan penatalaksanaan gizi standar, atau kecurigaan masalah hormonal), maka RUJUK ke RS
- 3) Sangat pendek (*severely*) (Skor Z PB/U atau TB/U < -3 SD). tindakan/ pengobatannya:
 - RUJUK ke RS untuk penanganan lebih lanjut
- 4) Tinggi (*tall*) (Skor Z PB/U atau TB/U $> +3$ SD), tindakan/ pengobatannya:
 - RUJUK ke RS untuk penanganan lebih lanjut

Klasifikasi berdasarkan lingkaran kepala adalah:

- 1) Normal (Skor Z LK/U -2 SD sampai $+2$ SD), tindakan/ pengobatannya:
 - Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan setiap bulan
- 2) Mikrosefali Skor Z LK/U < -2 SD, tindakan/ pengobatannya:
 - RUJUK ke RS untuk penanganan lebih lanjut
- 3) Makrosefali Skor Z LK/U $> +2$ SD, tindakan/ pengobatannya:
 - RUJUK ke RS untuk penanganan lebih lanjut

i. Apakah anak mengalami tanda-tanda anemia?

Periksa apakah telapak tangan, konjungtiva, bibir, lidah dan bantalan kuku nampak sangat pucat atau pucat serta periksa kadar hemoglobin (Hb) jika tersedia. Klasifikasinya terbagi atas:

- 1) Tidak anemia (Tidak ditemukan tanda keputihan)
 - Jika anak < 2 tahun, nilai masalah pemberian makan, jika ada masalah kunjungan ulang 7 hari
 - Nasihati kapan harus kembali segera
- 2) Anemia (terdapat satu atau lebih tanda pucat pada telapak tangan/ konjungtiva/ bibir/ lidah/ bantalan kuku, dan hemoglobin $7-10$ g/dL). Tindakan/pengobatannya:
 - Nilai masalah pemberian makan anak. Jika ada masalah kunjungan ulang 7 hari
 - Beri zat besi

- Lakukan pemeriksaan tinja untuk deteksi cacingan. Jika hasil positif, berikan obat cacing
 - Jika anak tinggal di daerah endemis tinggi malaria, lakukan pemeriksaan RDT malaria
 - Kunjungan ulang setelah 7 hari
 - Nasihati kapan harus kembali segera
- 3) Anemia berat (terdapat satu atau lebih tanda sangat pucat pada telapak tangan/ konjungtiva/ bibir/ lidah/ bantalan kuku dan hemoglobin <7 g/dL tindakan/ pengobatannya:
- Bila masih menyusui, teruskan pemberian ASI
 - Rujuk segera

j. Memeriksa status HIV

Periksa status HIV anak dengan melihat riwayat penyakit ibu atau anak pernah di tes HIV. Klasifikasinya terbagi atas:

- 1) Mungkin bukan infeksi HIV (Tes HIV pada ibu dan anak negatif), tindakan/ pengobatannya:
 - Atasi, edukasi dan follow up infeksi yang terjadi · Nasihati kapan harus kembali segera
- 2) Terpajan HIV (Ibu HIV positif dan tes virologi negatif pada anak yang masih mendapat ASI atau baru berhenti kurang dari 6 minggu ATAU Ibu HIV positif dan anak belum dites ATAU Tes serologi positif pada anak < 18 bulan), tindakan/ pengobatannya:
 - Berikan profilaksis kotrimoksazol
 - RUJUK ke puskesmas/RS rujukan ARV untuk melakukan tes virologi atau serologi sesuai umur
- 3) Infeksi HIV terkonfirmasi (Tes virologi positif pada anak ATAU Tes serologi positif pada anak > 18 bulan), tindakan/ pengobatannya:
 - Berikan profilaksis kotrimoksazol
 - Lacak kemungkinan TB : Jika terbukti sakit TB, berikan OAT, Jika tidak terbukti sakit TB, berikan terapi pencegahan TB
 - RUJUK ke RS rujukan ARV

k. Periksa status imunisasi anak

Periksa status imunisasi anak sesuai dengan jadwal pemberian imunisasi berdasarkan umur yaitu:

- 1) Imunisasi dasar:
 - 0-24 jam : Hb-0
 - 1 bulan : BCG, OPV1
 - 2 bulan : DPT-HB-Hib1, OPV2, PCV1

- 3 bulan : DPT-HB-Hib2, OPV3, PCV2
- 4 bulan : DPT-HB-Hib3, OPV4, IPV 1
- 9 bulan : Campak Rubella

2) Imunisasi lanjutan

- 10 bulan : Japanese encephalitis (untuk daerah tertentu)
- 12 bulan : PCV 3
- 18 tahun : DPT-HB-Hib 4, Campak Rubella

I. Pemberian vitamin A

Jadwal suplementasi setiap bulan Februari dan Agustus, dengan dosis pemberian:

- Umur 6 - 11 bulan : kapsul lunak 100.000 IU (kapsul biru)
- Umur 12 - 59 bulan : kapsul lunak 200.000 IU (kapsul merah)

Pemberian Vitamin A untuk kasus Gizi Buruk adalah:

- Umur < 6 bulan : kapsul lunak 50.000 IU ($\frac{1}{2}$ kapsul biru)
- Umur 6 - 11 bulan : kapsul lunak 100.000 IU (kapsul biru)
- Umur 12 - 59 bulan : kapsul lunak 200.000 IU (kapsul merah)

Jika balita gizi buruk juga menderita campak pada 3 bulan terakhir dan/ atau menderita defisiensi vitamin A, maka pemberian kapsul vitamin A diberikan 3 kali, yaitu pada hari ke-1, ke-2, dan ke-15

m. Menilai masalah/ keluhan lain

Pastikan bahwa setiap anak dengan tanda bahaya umum apa pun harus dirujuk setelah mendapatkan tindakan pra rujukan

2. MTBS Bayi Muda (Usia < 2 Bulan)

a. Apakah bayi mengalami tanda-tanda infeksi?

Periksa apakah bayi mengalami tanda-tanda infeksi pada kunjungan pertama dengan klasifikasi:

1. Mungkin bukan infeksi (tidak terdapat salah satu tanda infeksi), tindakan/pengobatannya:
 - Lakukan asuhan dasar bayi muda
 - Nasihati kapan harus kembali segera
2. Infeksi bakteri lokal (terdapat salah satu tanda infeksi yaitu mata bernanah sedikit, pusar kemerahan dan ada pustul di kulit), tindakan/pengobatannya:
 - Jika mata bernanah, beri salep mata antibiotik
 - Jika pusar kemerahan, olesi dengan antiseptik
 - Jika ada pustul di kulit, olesi dengan antiseptik
 - Ajari cara mengobati infeksi bakteri lokal di rumah

- Lakukan asuhan dasar bayi muda
 - Kunjungan ulang 2 hari
 - Nasihati kapan harus kembali segera
3. Penyakit sangat berat/infeksi bakteri berat (terdapat salah satu tanda infeksi yaitu biru sekitar mulut saat bayi menangis/mengisap, saturasi oksigen < 95% pada tangan kanan dan kaki kiri, terdapat perbedaan saturasi oksigen > 3% antara tangan kanan dan kaki kiri, napas cepat (≥ 60 kali/menit), napas lambat (< 40 kali/menit), merintih, pernapasan cuping hidung, tarikan inding dada ke dalam yang sangat kua, lemah, tidak kuat bergerak/mengisap, kejang atau gerakan spontan tidak terkendali, suhu tubuh > 37,5°C, suhu tubuh < 36,5°C, tidak buang air besar 48 jam setelah lahir, muntah berisi susu atau cairan berwarna hijau, perut kembung dan sulit bernapas, tidak didapatkan lubang anus, atau kotoran keluar dari lubang tidak normal di sekitar anus, mata bernanah banyak, pusar bernanah dan pusar kemerahan meluas sampai dinding perut > 1 cm, tindakan/pengobatannya:
- Pastikan jalan napas bebas, bayi memiliki usaha bernapas, dan sirkulasi terjaga
 - Jika bayi kejang, hentikan dengan obat anti kejang
 - Jika ada tanda sumbatan saluran cerna, lakukan dekompresi saluran cerna dengan memasang pipa orogastrik dengan ujung terbuka
 - Jaga bayi tetap STABIL dengan: pasang infus Dekstrosa 10% sebanyak 60 ml/kgBB/24 jam dalam tetesan ml/jam, jaga tubuh tetap hangat, puasakan agar jalan napas bebas dan berikan oksigen 1 L/menit, jaga sirkulasi aliran darah
 - Berikan dosis pertama antibiotik intramuskular
 - Lakukan komunikasi dengan orang tua dan fasilitas rujukan lanjut
 - RUJUK SEGERA

b. Apakah bayi mengalami ikterik

Periksa tanda-tanda ikterik pada bayi pada mata, telapak tangan dan telapak kaki. Klasifikasinya terbagi atas:

1. Tidak ada ikterus (tidak kuning), tindakan/ pengobatannya:
 - Lakukan asuhan dasar bayi muda
 - Nasihati kapan harus kembali segera
2. Ikterus (timbul kuning pada umur > 24 jam sampai dengan umur 14 hari dan kuning tidak sampai telapak tangan atau kaki), tindakan/ pengobatannya:
 - Lakukan asuhan dasar bayi muda

- Menyusu lebih sering
 - Jika memungkinkan, RUJUK untuk penentuan kadar bilirubin dan tata laksana yang sesuai
 - Nasihati untuk menginformasikan hasil pemeriksaan bilirubin
 - Kunjungan ulang 1 hari
 - Nasihati kapan harus kembali segera
3. Ikterus berat (timbul kuning pada hari pertama/ <24 jam) setelah lahir ATAU kuning ditemukan pada umur >14 hari ATAU kuning seluruh tubuh mulai kepala, badan sampai telapak tangan atau telapak kaki, tindakan/ pengobatannya:
- Pertahankan asupan ASI agar tidak kurang cairan
 - Jaga tubuh tetap hangat
 - RUJUK SEGERA

c. Apakah bayi mengalami diare?

Periksa apakah bayi mengalami diare dengan melihat keadaan umum bayi, matanya dan memeriksa tanda-tanda diare lainnya. Klasifikasinya terbagi atas:

1. Diare tanpa dehidrasi (tidak cukup tanda untuk dehidrasi berat atau ringan/ sedang), tindakan/ pengobatannya:
 - Tangani sesuai Rencana Terapi A
 - Lakukan asuhan dasar bayi muda
 - Kunjungan ulang 1 hari
 - Nasihati kapan harus kembali segera
2. Diare dehidrasi ringan/sedang (terdapat dua atau lebih tanda berikut yaitu gelisah/rewel, mata cekung, cubitan kulit perut kembali lambat, tindakan/ pengobatannya:
 - Jika tidak terdapat klasifikasi berat lain, tangani sesuai Rencana Terapi B
 - Jika terdapat klasifikasi berat lainnya: RUJUK SEGERA setelah memenuhi syarat rujukan, dan berikan larutan oralit sedikit demi sedikit selama dalam perjalanan
 - Nasihati agar ASI tetap diberikan jika memungkinkan
 - Lakukan asuhan dasar bayi muda
 - Kunjungan ulang 1 hari
 - Nasihati kapan harus kembali segera
3. Diare dehidrasi berat (terdapat dua atau lebih tanda berikut yaitu bergerak hanya jika dirangsang atau tidak bergerak sama sekali (letargi), mata cekung, cubitan kulit perut kembali sangat lambat, tindakan/ pengobatannya:
 - Jika terdapat klasifikasi berat lain, tangani sesuai Rencana Terapi C ATAU

- Jika terdapat klasifikasi berat lainnya, RUJUK SEGERA setelah memenuhi syarat rujukan, dan berikan oralit sedikit demi sedikit selama dalam perjalanan
- Nasihati agar ASI tetap diberikan jika memungkinkan
- Nasihati cara menjaga bayi tetap hangat selama perjalanan

d. Penilaian tanda Infeksi HIV pada bayi muda

Periksa riwayat penyakit ibu dan apakah bayi pernah tes HIV. Klasifikasinya terbagi atas:

1. Bukan infeksi HIV (Ibu dengan tes HIV negatif atau bayi dengan tes virologis negatif), tindakan/ pengobatannya:
 - Obati dan tindak lanjut jika ada infeksi lain
 - Edukasi ibu tentang asupan makanan dan kesehatan ibu
 - Nasihati kapan harus kembali segera
2. Infeksi HIV (tidak diketahui Ibu atau bayi belum tes HIV), tindakan/ pengobatannya:
 - Inisiasi tes HIV dan konseling
 - Lakukan tes HIV pada ibu. Jika positif, lakukan tes virologis pada bayi
 - Lakukan tes virologis pada bayi jika ibu tidak ada
 - Nasihati kapan harus kembali segera
3. Terpajan HIV : mungkin infeksi HIV (bayi dengan tes serologis positif ATAU ibu HIV positif DAN bayi mendapat ASI atau berhenti menyusui < 6 minggu dengan tes virologis negatif ATAU ibu HIV positif dan bayi belum tes HIV, tindakan/ pengobatannya:
 - Berikan profilaksis kotrimoksazol* mulai umur 6 minggu
 - Mulai profilaksis antiretroviral (bila umur < 72 jam) atau lanjutkan berdasarkan penilaian risiko
 - Lakukan tes virologis pada bayi · Mulai terapi antiretroviral pada ibu jika belum pengobatan atau RUJUK
 - Edukasi ibu untuk perawatan di rumah
 - Tindak lanjut rutin sesuai pedoman nasional
 - Nasihati kapan harus kembali segera
4. Infeksi HIV terkonfirmasi (bayi dengan tes virologis positif), tindakan/ pengobatannya:
 - Berikan profilaksis kotrimoksazol* mulai umur 6 minggu
 - RUJUK untuk terapi antiretroviral dan perawatan HIV
 - RUJUK atau mulai terapi antiretroviral pada ibu jika belum pengobatan
 - Edukasi ibu untuk perawatan di rumah
 - Tindak lanjut sesuai pedoman nasional

e. Memeriksa kemungkinan berat badan rendah menurut umur dan masalah pemberian ASI

Timbang berat badan bayi dan periksa masalah pemberian ASI. Klasifikasinya terbagi atas:

- 1) Berat badan tidak rendah menurut umur dan tidak ada masalah pemberian ASI (tidak terdapat tanda/gejala di atas), tindakan/ pengobatannya:
 - Pujiilah ibu karena telah memberikan ASI kepada bayinya dengan benar
 - Nasihati kapan harus kembali segera
- 2) Berat badan rendah menurut umur dan/atau masalah pemberian ASI (terdapat satu atau lebih tanda berikut yaitu berat badan menurut umur rendah, ASI kurang dari 8 kali/hari, bayi diberi ASI menggunakan botol, mendapat makanan atau minuman lain selain ASI, posisi bayi salah, tidak melekat dengan baik atau tidak melekat sama sekali, tidak mengisap dengan efektif, terdapat bercak putih (*thrush*) di mulut dan terdapat celah bibir/langit-langit, tindakan/ pengobatannya:
 - Lakukan asuhan dasar bayi muda
 - Jika menyusui < 8 kali dalam 24 jam, nasihati ibu untuk menyusui lebih sering, sesuai keinginan bayi, baik siang maupun malam
 - Jika memberi ASI menggunakan botol, ajari penggunaan cangkir
 - Jika mendapat makanan/minuman selain ASI, nasihati ibu untuk relaktasi
 - Jika cara menyusui ada masalah, ajari ibu posisi/perlekatan
 - Jika ada bercak putih di mulut (*thrush*), nasihati ibu untuk mengobati di rumah dengan suspensi nistatin
 - Jika ada celah bibir/langit-langit, nasihati tentang alternatif pemberian minum
 - Kunjungan ulang 2 hari untuk masalah pemberian ASI dan thrush
 - Kunjungan ulang 7 hari untuk masalah berat badan rendah menurut umur
 - Nasihati kapan harus kembali segera
- 3) Berat badan sangat rendah menurut umur (berat badan < 2 kg pada bayi umur < 7 hari), tindakan/ pengobatannya:
 - RUJUK ke RS dengan Metode Kanguru
 - Cegah gula darah tidak turun
 - Nasihati cara menjaga bayi tetap hangat selama perjalanan

f. Memeriksa kemungkinan berat badan rendah menurut umur dan masalah pemberian minum (hanya digunakan pada ibu HIV positif yang tidak menyusui)

Timbang berat badan bayi dan masalah pemberian minum, klasifikasinya terbagi atas:

- 1) Berat badan tidak rendah menurut umur dan tidak ada masalah pemberian minum (berat badan (BB) menurut umur ≥ -2 SD dan tidak terdapat tanda/gejala di atas), tindakan/ pengobatannya:
 - Nasihati ibu untuk melanjutkan pemberian minum dan pastikan hygiene yang baik
 - Pujilah ibu karena telah memberikan minum kepada bayi dengan benar
 - Nasihati kapan harus kembali segera
- 2) Berat badan rendah menurut umur dan/atau masalah pemberian minum (berat badan (BB) menurut umur < -2 SD ATAU pemberian minuman pengganti yang tidak sesuai ATAU pemberian minuman pengganti dengan jumlah tidak adekuat ATAU pemberian susu yang disiapkan dengan tidak benar atau tidak higienis ATAU · Menggunakan botol ATAU ibu dengan HIV positif yang mem berikan ASI dan minuman lain sebelum bayi berumur 6 bulan ATAU terdapat bercak putih (*thrush*) di mulut terdapat celah bibir/langit-langit, tindakan/ pengobatannya:
 - Ajarkan ibu untuk memberikan minum dengan benar
 - Jelaskan tata cara pemberian minuman pengganti yang aman
 - Identifikasi masalah pada ibu dan keluarga mengenai pemberian minum
 - Jika ibu masih menggunakan botol, ajarkan penggunaan cangkir
 - Jika ada bercak putih di mulut (*thrush*), nasihati ibu untuk mengobati di rumah
 - Jika ada celah bibir/langit-langit, nasihati tentang alternatif pemberian minum
 - Kunjungan ulang 2 hari untuk masalah pemberian ASI/minum atau thrush
 - Kunjungan ulang 7 hari untuk masalah berat badan rendah menurut umur
 - Nasihati kapan harus kembali segera
- 3) Berat badan sangat rendah menurut umur (BB < 2 kg pada bayi umur < 7 hari), tindakan/ pengobatannya:
 - RUJUK ke RS dengan Metode Kanguru
 - Cegah agar gula darah tidak turun
 - Nasihati cara menjaga bayi tetap hangat selama perjalanan

3. Adapun kategori warna dalam MTBS & MTBM adalah:

- a. Merah**, digunakan untuk gawat darurat, harus segera **dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan**
- b. Kuning**, digunakan jika perlu pengobatan atau pemantauan di fasilitas kesehatan
- c. Hijau** digunakan jika tidak ada masalah serius, bayi atau anak dapat **dirawat di rumah dengan edukasi ibu.**

F. Latihan Soal

1. MTBS digunakan untuk menangani anak dalam rentang usia :
 - A. 0-1 bulan
 - B. 0-2 bulan
 - C. 2 bulan-5 tahun
 - D. 1-5 tahun
2. 6 bulan-5 tahun Dalam MTBM, bayi dengan berat lahir rendah diklasifikasikan ke dalam kategori:
 - A. Sehat
 - B. Risiko sedang
 - C. Risiko tinggi
 - D. Risiko sangat tinggi
 - E. Tidak berisiko
3. Langkah pertama dalam MTBS adalah:
 - A. Memberikan pengobatan yang sesuai
 - B. Menilai adanya tanda bahaya umum
 - C. Menentukan klasifikasi penyakit
 - D. Memberikan konseling pada ibu
 - E. Menimbang berat badan anak
4. Tanda bahaya umum dalam MTBS yang harus diperiksa, kecuali:
 - A. Tidak bisa minum atau menyusu
 - B. Kejang
 - C. Berat badan bertambah
 - D. Letargi atau tidak sadar
 - E. Muntah terus-menerus
5. Seorang anak dikatakan mengalami diare persisten jika berlangsung lebih dari:
 - A. 3 hari
 - B. 5 hari
 - C. 7 hari
 - D. 10 hari

- E. 14 hari
- 6. Berikut ini yang tidak termasuk klasifikasi dalam penilaian bayi usia 0 – 2 bulan menurut MTBM adalah:
 - A. Infeksi bakteri berat
 - B. Berat lahir rendah
 - C. Ikterus berat
 - D. Kekurangan vitamin A
 - E. Kesulitan menyusui
- 7. Seorang bayi muda dengan tanda letargi, kesulitan menyusui, dan napas cepat dikategorikan dalam klasifikasi:
 - A. Kuning
 - B. Hijau
 - C. Merah
 - D. Biru
 - E. Putih
- 8. Jika seorang balita mengalami demam lebih dari 7 hari, maka dalam MTBS perlu dilakukan pemeriksaan untuk menyingkirkan kemungkinan:
 - A. Diare akut
 - B. Pneumonia
 - C. Malaria atau demam berdarah
 - D. Infeksi telinga
 - E. Kekurangan zat besi
- 9. Dalam MTBS, bayi yang mengalami dehidrasi berat harus segera diberikan:
 - A. ASI eksklusif
 - B. Oralit
 - C. Cairan intravena
 - D. Air putih biasa
 - E. Teh manis hangat
- 10. Manfaat utama penerapan MTBS dan MTBM adalah:
 - A. Meningkatkan angka kejadian penyakit infeksi
 - B. Mengurangi angka kematian dan kesakitan pada bayi dan balita
 - C. Mempersingkat durasi rawat inap di rumah sakit
 - D. Mengurangi angka kelahiran bayi premature
 - E. Mempermudah orang tua dalam merawat bayi di rumah

Latihan soal essay

1. Jelaskan langkah-langkah utama dalam pendekatan MTBS untuk menangani balita sakit di fasilitas kesehatan!

2. Apa saja tanda bahaya umum pada bayi dan balita yang perlu segera mendapat rujukan dalam MTBS dan MTBM?
3. Bagaimana cara menilai status gizi balita dalam pendekatan MTBS? Sebutkan indikator yang digunakan dan bagaimana cara menafsirkannya!
4. Seorang bayi berusia 1 bulan mengalami kesulitan menyusu dan berat badannya tidak bertambah. Berdasarkan panduan MTBM, langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam menilai dan menangani kondisi ini?
5. Bagaimana cara menilai dan menangani bayi muda (0–2 bulan) yang mengalami demam menurut pedoman MTBM? Jelaskan langkah-langkahnya!

Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban : C (2 bulan – 5 tahun)
Pembahasan :
MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) dirancang untuk anak usia 2 bulan sampai 5 tahun dan untuk bayi usia 0-2 bulan ditangani dengan pendekatan **MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda)**.
2. Kunci Jawaban : C (Risiko tinggi)
Pembahasan:
Bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) memiliki risiko tinggi mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan, serta lebih rentan terhadap infeksi. Oleh karena itu, dalam MTBM, bayi BBLR dikategorikan sebagai **risiko tinggi** dan memerlukan pemantauan khusus.
3. Kunci Jawaban : B (Menilai adanya tanda bahaya umum)
Pembahasan:
Dalam pendekatan MTBS, langkah pertama adalah **menilai tanda bahaya umum**, seperti anak tidak bisa minum atau menyusu, mengalami kejang, letargi atau tidak sadar, dan muntah terus-menerus. Jika tanda bahaya ditemukan, anak segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.
4. Kunci Jawaban : C (Berat badan bertambah)
Pembahasan:
Tanda bahaya umum dalam MTBS meliputi:
 - Tidak bisa minum atau menyusu
 - Kejang
 - Letargi atau tidak sadar
 Muntah terus-menerus Sedangkan **penambahan berat badan** merupakan tanda pertumbuhan yang baik, sehingga bukan termasuk tanda bahaya umum.
5. Kunci Jawaban : E (14 hari)

Pembahasan:

Diare persisten adalah diare yang berlangsung **lebih dari 14 hari** dan dapat menyebabkan dehidrasi serta kekurangan gizi. Kasus ini perlu perhatian lebih, termasuk pemberian cairan yang adekuat dan pemantauan status gizi anak.

6. Kunci Jawaban : D (Kekurangan vitamin A)

Pembahasan:

Dalam MTBM, klasifikasi bayi mencakup:

- Infeksi bakteri berat
- Berat lahir rendah
- Ikterus berat
- Kesulitan menyusu

Kekurangan vitamin A lebih sering diklasifikasikan dalam kelompok anak usia lebih besar dan bukan bagian dari penilaian utama MTBM.

7. Kunci Jawaban : C (Merah)

Pembahasan:

Bayi dengan tanda **letargi, kesulitan menyusu, dan napas cepat** diklasifikasikan dalam **kategori merah**, yang berarti membutuhkan **rujukan segera** untuk penanganan lebih lanjut.

8. Kunci Jawaban : C (Malaria atau demam berdarah)

Pembahasan:

Demam lebih dari 7 hari tanpa penyebab yang jelas harus dicurigai sebagai penyakit **infeksi serius** seperti **malaria atau demam berdarah**, terutama di daerah endemis. Pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk konfirmasi diagnosis.

9. Kunci Jawaban : C (Cairan intravena)

Bayi dengan **dehidrasi berat** harus segera mendapatkan **cairan intravena (IV)** karena kehilangan cairan yang signifikan dapat mengancam nyawa. Oralit hanya digunakan pada dehidrasi ringan hingga sedang.

10. Kunci Jawaban : **B (Mengurangi angka kematian dan kesakitan pada bayi dan balita)**

Pembahasan:

Tujuan utama MTBS dan MTBM adalah **mengurangi angka kematian dan kesakitan pada bayi dan balita** dengan pendekatan terpadu dalam penanganan penyakit umum serta promosi kesehatan bagi ibu dan keluarga.

G. Rangkuman Materi

1. MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)

MTBS adalah pendekatan terpadu dalam menangani balita usia **2 bulan hingga 5 tahun** dengan fokus pada **penyakit infeksi utama, status gizi, dan imunisasi**. MTBS bertujuan untuk **mengurangi angka kesakitan dan kematian** akibat penyakit yang sering terjadi pada balita.

Langkah-langkah utama dalam MTBS

- **Menilai dan mengklasifikasikan penyakit** berdasarkan gejala dan tanda klinis
- **Menentukan kategori warna (merah, kuning, hijau)** untuk prioritas penanganan

Memberikan pengobatan yang sesuai di fasilitas kesehatan

- **Memberikan edukasi kepada ibu/pengasuh** tentang perawatan di rumah
- **Menentukan apakah anak perlu dirujuk** ke rumah sakit

Penyakit utama yang ditangani dalam MTBS

- **Pneumonia dan batuk**
- **Diare** (dehidrasi, persisten, atau berdarah)
- **Demam** (termasuk kemungkinan malaria dan demam berdarah)
- **Masalah gizi dan anemia**
- **Masalah telinga (infeksi atau nyeri telinga kronis)**

Kategori klasifikasi warna MTBS:

- **Merah** → Kondisi gawat darurat → **Segera rujuk**
- **Kuning** → Kondisi butuh pengobatan di fasilitas kesehatan → **Rawat di tempat**
- **Hijau** → Penyakit ringan → **Rawat jalan & edukasi ibu**

2. MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda)

MTBM digunakan untuk menangani bayi usia **0–2 bulan**, yang lebih rentan terhadap komplikasi serius. Fokus utama MTBM adalah **penilaian infeksi serius, status menyusui, dan pertumbuhan bayi**.

Langkah-langkah utama dalam MTBM:

- **Menilai tanda bahaya umum** pada bayi muda
- **Klasifikasi masalah berdasarkan kategori warna**
- **Menentukan tindakan segera (rujuk atau rawat di fasilitas kesehatan)**
- **Mengevaluasi pemberian ASI dan pertumbuhan bayi**
- **Memberikan edukasi kepada ibu tentang perawatan di rumah**

Masalah utama yang ditangani dalam MTBM:

- **Infeksi bakteri berat** (sepsis, pneumonia berat, meningitis)

- **Berat lahir rendah (BBLR) atau bayi kecil untuk usia kehamilan (SGA)**
- **Ikterus berat (kuning pada bayi yang meluas ke seluruh tubuh)**
- **Kesulitan menyusu atau tidak mendapat ASI yang cukup**
- **Demam atau hipotermia**

Kategori klasifikasi warna MTBM:

- **Merah** → Infeksi berat atau kondisi gawat → **Rujuk segera**
- **Kuning** → Masalah yang memerlukan pengobatan atau pemantauan ketat → **Rawat di fasilitas kesehatan**
- **Hijau** → Bayi sehat → **Rawat di rumah & edukasi ibu**

H. Glosarium

Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS): pendekatan terpadu dalam menangani penyakit balita usia **2 bulan – 5 tahun** dengan fokus pada penyakit infeksi, status gizi, dan imunisasi.

Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM): panduan penanganan bayi **usia 0–2 bulan**, dengan fokus pada infeksi, berat badan, dan pemberian ASI.

Tanda Bahaya Umum: gejala serius yang memerlukan **penanganan segera**, seperti **tidak bisa minum/menyusu, kejang, letargi, napas cepat, hipotermia, atau demam tinggi.**

Diare Persisten: diare yang berlangsung **lebih dari 14 hari**, yang berisiko menyebabkan **malnutrisi dan dehidrasi berat.**

Berat Lahir Rendah (BBLR): bayi yang lahir dengan berat **kurang dari 2500 gram**, yang memiliki risiko tinggi mengalami **hipotermia, infeksi, dan gangguan pertumbuhan.**

Ikterus Berat: kondisi **kulit dan mata bayi menguning**, yang bisa menjadi tanda masalah serius jika meluas ke telapak tangan dan kaki atau terjadi dalam **24 jam pertama kehidupan.**

Dehidrasi Berat: kehilangan cairan tubuh yang signifikan dengan tanda-tanda seperti **mata cekung, turgor kulit buruk, napas cepat, dan tidak bisa minum.**

Pneumonia Berat : infeksi paru-paru dengan tanda-tanda **napas cepat, retraksi dada, atau kesulitan bernapas**, yang memerlukan **antibiotik segera dan rujukan.**

Kategori warna merah dalam MTBS & MTBM: gawat darurat, harus segera **dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan**

Kategori warna kuning dalam MTBS & MTBM: perlu pengobatan atau pemantauan di fasilitas kesehatan.

Kategori warna hijau dalam MTBS & MTBM: tidak ada masalah serius, bayi atau anak dapat **dirawat di rumah dengan edukasi ibu.**

I. Daftar Pustaka

- Ernawati, Wahyuni, S., Aritonang, T. R., Meliyana, E., & Mayasari, D. (2023). *Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir* (M. B. Karo, Y. D. Lestari, & R. P. Novembriani (eds.)). Rena Cipta Mandiri.
- Kemendes RI. (2022). Buku Bagan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). In *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Subedi, R. K., VanderZanden, A., Adhikari, K., Bastola, S., Hirschhorn, L. R., Binagwaho, A., & Maskey, M. (2024). Integrated Management of Childhood Illness implementation in Nepal: understanding strategies, context, and outcomes. *BMC Pediatrics*, 23(Suppl 1). <https://doi.org/10.1186/s12887-023-03889-3>
- Vhuromu, T., Gonzalez, G., & Davhana-Maselesele, B. (2022). Integrated Management Of Childhood Illness (IMCI): Planning, Implementing and Evaluating Pre-Service Training. *International Journal of Quality in Health Care*, 48(8).

BAB 4

PROSEDUR PELAKSANAAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA BAYI BERDASARKAN NEONATUS ESSENSIAL

Tujuan Intruksional:

1. Memahami Konsep Neonatus Esensial
2. Menguasai Prosedur Asuhan Keperawatan Berdasarkan Neonatus Esensial
3. Menerapkan Prinsip Keamanan dan Pencegahan Infeksi
4. Berkomunikasi Efektif dengan Ibu dan Keluarga
5. Mendokumentasikan Asuhan Keperawatan dengan Tepat

Capaian Pembelajaran :

Capaian pembelajaran Prosedur Pelaksanaan Asuhan Keperawatan Pada Bayi Berdasarkan Neonatus Esensial mencakup kemampuan peserta didik untuk:

1. Menguasai konsep Neonatus Esensial secara komprehensif, termasuk prinsip-prinsip dasar, manfaat, dan langkah-langkah utama dalam pelaksanaannya.
2. Melakukan penilaian awal bayi baru lahir dengan sistematis dan mengidentifikasi kebutuhan bayi sesuai dengan prinsip Neonatus Esensial.
3. Mendemonstrasikan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) secara benar dan efektif, termasuk memberikan dukungan kepada ibu.
4. Melaksanakan pencegahan hipotermi pada bayi baru lahir melalui berbagai metode, terutama kontak kulit ke kulit, sesuai standar.
5. Melakukan perawatan tali pusat secara aman dan mencegah terjadinya infeksi.
6. Menerapkan prinsip-prinsip pencegahan infeksi dalam setiap tindakan asuhan keperawatan pada bayi baru lahir.
7. Berkomunikasi secara efektif dengan ibu dan keluarga mengenai kondisi bayi dan asuhan yang diberikan.
8. Mendokumentasikan seluruh asuhan keperawatan yang diberikan sesuai dengan standar yang berlaku.

Pendahuluan:

Masa neonatus merupakan periode krusial dalam kehidupan manusia, di mana bayi baru lahir mengalami transisi fisiologis dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin. Keberhasilan adaptasi ini sangat dipengaruhi oleh kualitas asuhan keperawatan yang diberikan segera setelah kelahiran. Asuhan yang tepat dan berbasis bukti pada periode ini tidak hanya menyelamatkan jiwa, tetapi juga berdampak jangka panjang pada tumbuh kembang bayi.

Konsep Neonatus Esensial muncul sebagai pendekatan holistik dalam memberikan asuhan kepada bayi baru lahir. Pendekatan ini menekankan serangkaian intervensi sederhana, efektif, dan terjangkau yang terbukti secara signifikan mengurangi morbiditas dan mortalitas neonatal. Prinsip utama dalam Neonatus Esensial meliputi kontak dini kulit ke kulit antara ibu dan bayi, inisiasi menyusu dini (IMD) dalam satu jam pertama kelahiran, pencegahan hipotermi, perawatan tali pusat terbuka dan kering, serta penanganan infeksi secara dini.

Pelaksanaan asuhan keperawatan berdasarkan prinsip Neonatus Esensial memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai fisiologi bayi baru lahir dan keterampilan praktis dalam menerapkan setiap langkah prosedur. Standarisasi prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap bayi baru lahir menerima asuhan yang optimal, terlepas dari tempat dan tenaga kesehatan yang menanganinya.

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan pada bayi berdasarkan Neonatus Esensial menjadi kompetensi esensial bagi setiap tenaga kesehatan, khususnya perawat. Dengan menguasai prosedur ini, diharapkan perawat dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan neonatal dan menurunkan angka kesakitan serta kematian bayi baru lahir di Indonesia. Panduan ini akan menguraikan secara sistematis langkah-langkah dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada bayi baru lahir berdasarkan prinsip-prinsip Neonatus Esensial.

A. Neonatus Essensial

Neonatus Essensial adalah konsep yang dikembangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang bertujuan untuk memberikan perawatan dasar yang komprehensif dan berkualitas tinggi bagi bayi baru lahir atau neonatus. Konsep ini menekankan pentingnya pendekatan yang berbasis pada pencegahan, deteksi dini, dan penanganan tepat pada kondisi kritis bayi yang baru lahir, untuk mengurangi angka kematian dan morbiditas bayi di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang.

Neonatus Essensial mencakup serangkaian pedoman perawatan yang harus diterapkan dalam beberapa jam dan hari pertama kehidupan bayi untuk mendukung kesehatan bayi secara optimal dan meminimalkan risiko komplikasi. Konsep ini memfokuskan perhatian pada aspek dasar perawatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan keluarga, baik di rumah sakit maupun di komunitas.

1. Tujuan Neonatus Essensial:

- a. **Mengurangi Angka Kematian Neonatal:** Dengan memberikan perawatan yang tepat pada bayi baru lahir, konsep ini bertujuan untuk menurunkan tingkat kematian neonatal, yang sering disebabkan oleh infeksi, kelainan kongenital, dan kelahiran prematur.
- b. **Meningkatkan Kualitas Kehidupan Bayi:** Meningkatkan kesehatan jangka panjang bayi dengan mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial yang sehat.
- c. **Meningkatkan Pengetahuan Orang Tua:** Memberikan pendidikan kepada orang tua mengenai cara merawat bayi mereka, tanda-tanda bahaya, dan langkah-langkah preventif yang dapat mereka lakukan di rumah.

2. Komponen Utama Neonatus Essensial:

Neonatus Essensial melibatkan beberapa komponen penting dalam perawatan bayi baru lahir, yang mencakup hal-hal berikut:

- a. Perawatan Kulit ke Kulit (Skin-to-Skin Contact)
 - 1) **Tujuan:** Meningkatkan ikatan emosional antara ibu dan bayi serta mendukung proses termoregulasi bayi.
 - 2) **Penerapan:** Segera setelah lahir, bayi diletakkan di dada ibu dalam posisi skin-to-skin untuk memberikan kehangatan alami, mendukung proses menyusui pertama, dan menstabilkan suhu tubuh bayi.
- b. Pemberian ASI Eksklusif

- 1) **Tujuan:** Memberikan nutrisi optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, serta mendukung sistem kekebalan tubuhnya.
 - 2) **Penerapan:** Memberikan ASI pada bayi dalam satu jam pertama setelah lahir dan melanjutkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan. ASI adalah sumber makanan terbaik untuk bayi dan juga membantu membangun kekebalan tubuh bayi.
- c. Penghangatan Bayi
- 1) **Tujuan:** Menghindari hipotermia yang dapat terjadi pada bayi baru lahir karena ketidakmampuan tubuh bayi untuk mengatur suhu sendiri.
 - 2) **Penerapan:** Bayi baru lahir harus segera dipanaskan dengan cara skin-to-skin contact atau dengan menggunakan pakaian hangat, selimut, dan penghangat ruangan. Penghangatan bayi sangat penting untuk mencegah hipotermia yang dapat meningkatkan risiko infeksi.
- d. Penilaian Kondisi Bayi (Skor Apgar)
- 1) **Tujuan:** Mengevaluasi keadaan umum bayi segera setelah kelahiran untuk menentukan apakah ada kebutuhan perawatan medis tambahan.
 - 2) **Penerapan:** Melakukan penilaian dengan Skor Apgar pada menit pertama dan kelima setelah kelahiran untuk menilai kondisi bayi berdasarkan 5 indikator: detak jantung, pernapasan, refleks, tonus otot, dan warna kulit.
- e. Imunisasi dan Pemberian Vitamin
- 1) **Tujuan:** Melindungi bayi dari penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi dan mendukung pembekuan darah.
 - 2) **Penerapan:**
 - a) **Vitamin K** diberikan pada bayi baru lahir untuk mencegah perdarahan.
 - b) **Imunisasi Hepatitis B** diberikan segera setelah lahir.
 - c) **Imunisasi BCG** dan **Polio** diberikan sesuai dengan pedoman kesehatan yang berlaku.
- f. Perawatan Tali Pusat
- 1) **Tujuan:** Mengurangi risiko infeksi pada bayi melalui perawatan yang tepat pada tali pusat.
 - 2) **Penerapan:** Tali pusat harus dipotong dengan alat yang steril dan dijaga kebersihannya dengan antiseptik untuk mencegah infeksi.
- g. Deteksi Dini Masalah Kesehatan
- 1) **Tujuan:** Menangani masalah kesehatan bayi secara cepat dan tepat untuk mencegah komplikasi serius.
 - 2) **Penerapan:** Pemeriksaan fisik untuk mendeteksi adanya kelainan kongenital atau tanda-tanda penyakit pada bayi seperti gangguan pernapasan, dehidrasi, atau kelainan genetik.

h. Pencegahan Infeksi

- 1) **Tujuan:** Mengurangi risiko infeksi pada bayi baru lahir yang rentan terhadap penyakit.
- 2) **Penerapan:** Perawatan tangan yang baik oleh tenaga kesehatan dan keluarga, menjaga kebersihan bayi, serta pemberian antibiotik apabila diperlukan dalam kondisi tertentu.

i. Pemberian Perawatan Rutin

- 1) **Tujuan:** Menjaga kondisi kesehatan bayi tetap optimal.
- 2) **Penerapan:** Pemantauan kesehatan bayi secara rutin, termasuk pemeriksaan berat badan, panjang tubuh, perkembangan bayi, serta status imunisasi.

B. Prosedur Asuhan Keperawatan Berdasarkan Neonatus Esensial

1. Penilaian Awal Bayi Baru Lahir

Penilaian awal bayi baru lahir adalah langkah pertama yang sangat penting untuk mengevaluasi kondisi kesehatan bayi segera setelah kelahiran. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa bayi tidak mengalami komplikasi yang serius dan untuk menentukan tindakan medis yang tepat. Proses ini biasanya dilakukan dalam waktu 1-5 menit setelah kelahiran. Berikut adalah langkah-langkah dalam penilaian awal bayi baru lahir:

a. Penilaian Skor Apgar

Skor Apgar adalah sistem penilaian yang digunakan untuk menilai kondisi umum bayi pada menit pertama dan kelima setelah kelahiran. Penilaian ini dilakukan berdasarkan lima indikator utama:

- 1) A (Appearance) – Warna kulit
- 2) P (Pulse) – Denyut jantung
- 3) G (Grimace) – Refleks atau respon terhadap rangsangan
- 4) A (Activity) – Tonus otot (gerakan tubuh)
- 5) R (Respiration) – Pernapasan

Skor Apgar diberikan angka antara 0 hingga 2 untuk masing-masing indikator, dengan total skor maksimum 10.

Tabel 4.1: Interpretasi Skor Apgar

Skor	Kondisi
7–10	Bayi dalam kondisi baik
4–6	Bayi memerlukan perawatan medis segera
0–3	Bayi dalam keadaan kritis dan memerlukan resusitasi

b. Pengukuran Berat Badan dan Panjang Badan

- 1) Berat Badan: Pengukuran berat badan bayi dilakukan untuk mengetahui status gizi bayi dan memastikan bahwa bayi tidak mengalami kekurangan atau kelebihan berat badan. Berat badan bayi yang lahir cukup bulan biasanya antara 2,500 hingga 4,000 gram.
- 2) Panjang Badan: Panjang tubuh bayi diukur dari ujung kepala hingga ujung kaki. Panjang normal bayi baru lahir biasanya antara 48 hingga 52 cm.

c. Pemeriksaan Kondisi Fisik

Setelah penilaian skor Apgar dan pengukuran berat badan, pemeriksaan fisik dilakukan untuk mendeteksi kelainan bawaan atau masalah kesehatan lain yang mungkin ada. Beberapa aspek yang diperiksa antara lain:

- 1) Warna Kulit: Kulit bayi harus diperiksa untuk memastikan tidak ada tanda-tanda kekuningan (jaundice) atau sianosis (kebiruan).
- 2) Pernapasan: Pemeriksaan untuk memastikan bayi bernapas dengan baik, tidak ada kesulitan bernapas, atau tanda-tanda distress pernapasan.
- 3) Refleks dan Tonus Otot: Memeriksa respon bayi terhadap rangsangan (misalnya mengisap jari atau merespon suara) dan memeriksa tonus otot (gerakan lengan dan kaki).
- 4) Jantung dan Pembuluh Darah: Pemeriksaan denyut jantung bayi (normalnya sekitar 120-160 denyut per menit) serta adanya kelainan jantung atau pembuluh darah.

d. Pemeriksaan Tali Pusat

Tali pusat diperiksa untuk memastikan bahwa tidak ada komplikasi, seperti pendarahan atau infeksi. Tali pusat harus dipotong dengan alat yang steril, dan diperhatikan bahwa tali pusat tidak terinfeksi. Penanganan dan perawatan tali pusat yang tepat adalah bagian penting dari penilaian awal bayi.

a. Pemeriksaan Refleks dan Aktivitas Neurologis

Bayi yang baru lahir harus diperiksa untuk refleks dasar, seperti refleks moro (refleks kejut), refleks menghisap, dan refleks menggenggam tangan. Refleks ini menunjukkan kesehatan sistem saraf pusat bayi.

b. Pemeriksaan Penglihatan dan Pendengaran

Penglihatan dan pendengaran bayi tidak sepenuhnya berkembang setelah lahir, tetapi pemeriksaan awal dapat dilakukan untuk memeriksa apakah bayi merespons rangsangan visual atau suara.

c. Penilaian Resiko Kesehatan

Jika bayi lahir dengan risiko tertentu, seperti kelahiran prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), atau memiliki kelainan bawaan yang diketahui (misalnya hipotiroidisme kongenital), maka pemeriksaan tambahan akan dilakukan untuk mengevaluasi kondisi kesehatan secara menyeluruh.

d. Pemberian Vitamin dan Imunisasi

Pada penilaian awal ini juga termasuk pemberian vitamin K untuk mencegah perdarahan, serta pemberian imunisasi pertama, seperti vaksin hepatitis B jika belum diberikan. Pemberian imunisasi ini penting untuk melindungi bayi dari penyakit infeksi.

2. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah proses pemberian ASI pertama kali kepada bayi dalam satu jam pertama setelah kelahiran. IMD merupakan langkah penting dalam mendukung kesehatan bayi dan ibu, serta membangun ikatan emosional yang kuat antara keduanya. IMD juga memiliki manfaat kesehatan yang signifikan, termasuk pemberian nutrisi terbaik untuk bayi serta meningkatkan produksi ASI bagi ibu.

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan Inisiasi Menyusu Dini secara benar dan efektif, termasuk cara memberikan dukungan kepada ibu:

a. Persiapan Sebelum IMD

Sebelum melakukan IMD, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk memastikan proses berjalan dengan lancar:

- 1) Lingkungan yang Nyaman dan Aman: Pastikan ruang kelahiran atau ruang perawatan bayi bersih, nyaman, dan cukup hangat. Suhu ruangan perlu dijaga agar bayi tidak merasa kedinginan, karena bayi baru lahir belum dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri.
- 2) Persiapan Alat dan Bahan: Pastikan bahwa peralatan medis yang dibutuhkan sudah siap dan dalam keadaan bersih, termasuk sarung tangan bersih (jika diperlukan), kain hangat untuk bayi, dan alat bantu medis untuk ibu dan bayi (jika diperlukan).
- 3) Komunikasi dengan Ibu: Jelaskan kepada ibu tentang pentingnya IMD dan cara yang benar untuk melakukannya. Berikan informasi bahwa IMD akan memperkuat ikatan ibu dan bayi, serta mendukung kesehatan bayi.

b. Langkah-Langkah Inisiasi Menyusu Dini yang Benar

1) Skin-to-Skin Contact (Kontak Kulit ke Kulit)

- a) Bayi diletakkan pada dada ibu: Setelah kelahiran, bayi harus segera diletakkan di dada ibu dalam posisi skin-to-skin contact. Posisi ini memungkinkan bayi merasakan kehangatan tubuh ibu, mendukung regulasi suhu tubuh bayi, dan memulai proses menyusui secara alami.
- b) Bayi dalam posisi tengkurap: Bayi harus diletakkan dalam posisi tengkurap di dada ibu, dengan kepala bayi sedikit miring dan tubuh bayi ditempatkan di atas tubuh ibu.
- c) Kontak langsung dengan kulit ibu: Bayi akan merasakan suhu tubuh ibu yang hangat dan insting untuk mencari puting susu secara alami. Skin-

to-skin contact juga mengurangi stres pada bayi dan meningkatkan perasaan aman.

2) Mendorong Refleks Mencari Puting (Rooting Reflex)

- a) Mencari puting susu: Setelah diletakkan di dada ibu, bayi akan mulai merespons dengan mencari puting susu ibu. Ini adalah refleks alami bayi yang dikenal sebagai rooting reflex. Ibu dapat membantu dengan memperkenalkan puting susu kepada bayi jika bayi belum berhasil menemukannya secara spontan.
- b) Bayi merangkak menuju puting: Bayi yang sehat dan cukup bulan akan merangkak atau menggerakkan mulutnya untuk mencari puting susu ibu. Ibu sebaiknya membiarkan bayi melakukan ini secara alami, tanpa paksaan.

3) Posisi Latching yang Benar

- a) Membantu bayi untuk latch-on dengan benar: Pastikan bayi dapat menghisap dengan baik (latch-on) pada puting susu ibu. Posisi mulut bayi harus mencakup sebagian besar areola (bagian gelap di sekitar puting) dan bukan hanya puting susu saja. Hal ini akan mengurangi risiko nyeri pada puting susu ibu dan memastikan bayi mendapatkan ASI secara efektif.
- b) Posisi tubuh bayi: Pastikan posisi tubuh bayi sejajar dengan tubuh ibu, dengan kepala bayi sejajar dengan tubuh, dan bayi tidak terpaksa menoleh atau membungkuk.

4) Biarkan Bayi Menyusu Sesuai Kebutuhan

- a) Frekuensi menyusui: Biarkan bayi menyusui selama bayi menginginkannya. Biasanya, bayi akan menyusui selama 10-20 menit pada setiap payudara. Jangan terburu-buru untuk menghentikan menyusui, karena bayi akan mendapatkan kolostrum (ASI pertama yang kaya nutrisi) yang sangat bermanfaat.
- b) Biarkan bayi menyusui di kedua payudara: Jika bayi ingin, tawarkan payudara kedua setelah menyusui dari payudara pertama. Pastikan bayi diberi kesempatan untuk menyusui secara bebas.

3. Pencegahan Hipotermi

Hipotermi pada bayi baru lahir merupakan kondisi medis yang serius, di mana suhu tubuh bayi turun di bawah suhu normal (di bawah 36,5°C). Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh bayi yang sangat rentan, karena mekanisme pengaturan suhu tubuhnya belum berkembang dengan baik. Pencegahan hipotermi sangat penting untuk mencegah komplikasi yang dapat mengancam nyawa bayi.

a. Penyebab Hipotermi pada Bayi Baru Lahir:

- 1) **Kehilangan panas yang berlebihan:** Bayi baru lahir memiliki kadar lemak tubuh yang rendah dan kulit yang tipis, sehingga lebih mudah kehilangan panas melalui konduksi (kontak langsung dengan permukaan dingin), konveksi (aliran udara dingin), radiasi (perpindahan panas tanpa kontak langsung), dan evaporasi (penguapan dari kulit yang basah).
- 2) **Kondisi lingkungan yang dingin:** Ruang yang tidak terisolasi dengan baik, seperti suhu ruangan yang rendah atau penggunaan pakaian bayi yang tidak cukup hangat, dapat memicu hipotermi.
- 3) **Kondisi medis bayi:** Bayi yang lahir prematur atau dengan berat badan lahir rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami hipotermi, karena mereka tidak memiliki cadangan lemak tubuh yang cukup untuk menjaga suhu tubuhnya.

b. Tanda-Tanda Hipotermi pada Bayi Baru Lahir:

- 1) Kulit bayi terasa dingin, terutama pada ekstremitas (tangan dan kaki).
- 2) Bayi tampak lesu atau tidak aktif.
- 3) Pernafasan menjadi cepat atau dangkal.
- 4) Bayi tampak lebih pucat atau kebiruan.
- 5) Gangguan pada pola makan dan menghisap.

c. Langkah-Langkah Pencegahan Hipotermi pada Bayi Baru Lahir:

1) Pemanasan Ruangan yang Cukup

Pastikan ruang di mana bayi baru lahir berada memiliki suhu yang sesuai, yaitu sekitar 25-28°C. Hal ini penting untuk mengurangi risiko kehilangan panas akibat suhu lingkungan yang rendah.

2) Penghangatan Saat Persalinan

Pada saat persalinan, pastikan bayi langsung dibersihkan dan dikeringkan dengan handuk kering yang hangat, kemudian diberikan skin-to-skin contact dengan ibu atau dimasukkan dalam inkubator yang telah dipanaskan. Ini membantu menjaga suhu tubuh bayi secara alami.

3) Pakaian yang Tepat

Kenakan pakaian yang cukup tebal pada bayi, seperti kaos, topi, dan kaus kaki. Pastikan pakaian bayi menutupi seluruh tubuh, terutama kepala yang merupakan area tubuh yang dapat kehilangan panas dengan cepat.

4) Skin-to-Skin Contact (Kontak Kulit ke Kulit)

Praktikkan skin-to-skin contact dengan ibu atau ayah bayi segera setelah lahir. Ini membantu menstabilkan suhu tubuh bayi karena tubuh orang dewasa memberikan sumber panas alami. Kontak kulit ke kulit juga meningkatkan ikatan emosional dan memberi kenyamanan pada bayi.

5) Penggunaan Selimut atau Tirai Panas

Selimut atau tirai panas (thermal blankets) dapat digunakan untuk menjaga suhu tubuh bayi, terutama pada bayi yang lahir prematur atau dengan berat badan lahir rendah yang lebih rentan terhadap hipotermi.

6) Pemantauan Suhu Tubuh

Penting untuk memantau suhu tubuh bayi secara berkala. Gunakan termometer bayi yang tepat dan pastikan suhu tubuh tetap berada pada kisaran normal (36,5-37,5°C).

7) Menjaga Kebersihan dan Pengeringan Bayi

Setelah lahir, bayi harus segera dibersihkan dan dikeringkan dari cairan ketuban yang masih menempel di tubuhnya, karena cairan yang basah dapat menyebabkan evaporasi yang cepat dan penurunan suhu tubuh.

8) Pemberian ASI

Memberikan ASI pada bayi segera setelah kelahiran dapat membantu menstabilkan suhu tubuh bayi, karena ASI mengandung banyak nutrisi dan antibodi yang penting untuk bayi, selain berfungsi sebagai sumber kenyamanan dan kehangatan.

d. Penanganan Hipotermi

Jika bayi sudah mengalami hipotermi, segera lakukan langkah-langkah pemanasan dengan cara yang aman:

- 1) Letakkan bayi dalam inkubator dengan pengaturan suhu yang tepat.
- 2) Lakukan pemanasan secara bertahap untuk menghindari cedera termal pada kulit bayi.
- 3) Cobalah menghangatkan bayi dengan menggunakan selimut hangat atau tirai panas jika inkubator tidak tersedia.

4. Perawatan Tali Pusat

Tali pusat adalah struktur penting yang menghubungkan bayi dengan plasenta ibu selama masa kehamilan, berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dan nutrisi ke bayi, serta mengeluarkan produk sampingan dari tubuh bayi. Setelah bayi lahir, tali pusat dipotong, dan sisa tali pusat yang terlepas, atau yang sering disebut sebagai stump, memerlukan perawatan yang tepat agar tidak terjadi infeksi dan komplikasi lainnya.

a. Tujuan Perawatan Tali Pusat

- 1) Mencegah infeksi pada sisa tali pusat.
- 2) Menjaga kebersihan dan kelembapan area tali pusat.
- 3) Memastikan proses penyembuhan yang cepat dan aman.
- 4) Mengurangi risiko perdarahan atau komplikasi lainnya.

b. Langkah-Langkah Perawatan Tali Pusat

- 1) Pembersihan Tali Pusat
 - a) Setelah tali pusat dipotong, bagian yang tertinggal (stump) harus dijaga tetap bersih dan kering.
 - b) Biasanya, perawatan yang dianjurkan adalah membersihkan area sekitar tali pusat dengan kapas yang dibasahi alkohol 70% (isopropil alkohol) atau cairan antiseptik lain yang disarankan oleh tenaga medis.
 - c) Hindari penggunaan air atau sabun pada awalnya, karena dapat menyebabkan infeksi.
- 2) Menjaga Kebersihan
 - a) Jangan menutup tali pusat dengan popok atau pakaian bayi yang ketat, karena hal ini dapat menyebabkan kelembapan dan menghambat penyembuhan.
 - b) Pastikan area tali pusat selalu kering dengan tidak membiarkannya basah terlalu lama. Cuci tangan terlebih dahulu sebelum dan setelah merawat tali pusat bayi.
- 3) Penggunaan Popok:
 - a) Lipat popok bayi agar tali pusat tidak tertutup popok. Hal ini untuk menghindari gesekan atau tekanan yang dapat menyebabkan iritasi atau infeksi.
 - b) Popok harus selalu dijaga agar tetap kering dan bersih.
- 4) Pemantauan Kondisi Tali Pusat:
 - a) Perhatikan adanya tanda-tanda infeksi, seperti kemerahan, pembengkakan, atau nanah. Jika terjadi perdarahan atau adanya bau tidak sedap, segera konsultasikan dengan dokter atau petugas medis.
 - b) Biasanya, tali pusat akan mengering dalam waktu beberapa hari dan lepas dalam waktu 1 hingga 3 minggu setelah kelahiran.
- 5) Proses Penyembuhan:
 - a) Selama proses penyembuhan, sisa tali pusat akan mengering, berwarna kecoklatan, dan akhirnya lepas secara alami. Ini adalah tanda bahwa proses penyembuhan telah berlangsung dengan baik.
 - b) Jangan mencoba menarik atau memotong tali pusat yang belum lepas.
- 6) Tanda Bahaya:
 - a) Tali pusat harus dipantau dengan hati-hati. Jika ada tanda-tanda infeksi seperti pembengkakan atau kemerahan yang meluas, pus atau nanah pada area tali pusat, perdarahan yang berlebihan, demam pada bayi, bau yang tidak sedap.
 - b) Segera cari pertolongan medis.

C. Prinsip Prinsip Pencegahan Infeksi Pada Bayi Baru Lahir

Infeksi pada bayi baru lahir merupakan salah satu masalah kesehatan yang dapat menimbulkan dampak serius jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Bayi baru lahir, terutama yang prematur atau dengan kondisi medis tertentu, memiliki sistem kekebalan tubuh yang belum matang, sehingga mereka lebih rentan terhadap infeksi. Oleh karena itu, pencegahan infeksi pada bayi baru lahir sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan kelangsungan hidup bayi.

1. Penyebab Infeksi pada Bayi Baru Lahir

Infeksi pada bayi baru lahir dapat disebabkan oleh berbagai patogen seperti bakteri, virus, atau jamur. Beberapa faktor yang menyebabkan infeksi pada bayi baru lahir antara lain:

- a. **Kontak dengan patogen:** Bayi dapat terpapar patogen dari lingkungan, misalnya melalui tangan yang tidak bersih atau alat medis yang tidak steril.
- b. **Proses kelahiran:** Infeksi bisa terjadi saat proses persalinan, terutama pada bayi yang lahir melalui persalinan caesar atau yang mengalami penurunan daya tahan tubuh akibat komplikasi persalinan.
- c. **Kondisi medis ibu:** Ibu dengan infeksi, seperti infeksi saluran kemih atau infeksi menular seksual, dapat menularkan patogen kepada bayi.

2. Prinsip Pencegahan Infeksi pada Bayi Baru Lahir

Pencegahan infeksi pada bayi baru lahir melibatkan berbagai langkah yang dapat dilakukan oleh tenaga medis, orang tua, dan keluarga yang merawat bayi. Beberapa prinsip dasar pencegahan infeksi pada bayi baru lahir adalah sebagai berikut:

a. Cuci Tangan yang Benar

- 1) **Cuci tangan secara teratur** adalah langkah pertama yang sangat penting dalam mencegah infeksi. Semua orang yang menyentuh bayi baru lahir harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama sebelum menyentuh wajah atau tubuh bayi.
- 2) Penggunaan **hand sanitizer berbasis alkohol** juga dapat digunakan jika sabun dan air tidak tersedia.

b. Menjaga Kebersihan Lingkungan

- 1) **Sterilisasi alat medis:** Semua peralatan yang digunakan untuk perawatan bayi, seperti alat makan, botol susu, dan alat medis lainnya, harus disterilkan dengan benar untuk menghindari penularan infeksi.
- 2) **Pembersihan lingkungan rumah:** Memastikan lingkungan tempat tinggal bayi bersih dari kuman, termasuk membersihkan permukaan tempat tidur, mainan, dan benda-benda yang sering disentuh bayi.

c. Perawatan Tali Pesar

Tali pusar bayi yang baru lahir merupakan tempat masuknya patogen, sehingga harus dijaga kebersihannya. Tali pusar harus dijaga tetap kering dan dibersihkan dengan antiseptik yang tepat (seperti alkohol 70%) hingga tali pusar lepas.

d. Vaksinasi

- 1) Memberikan **vaksinasi yang tepat** pada bayi baru lahir sangat penting untuk melindungi bayi dari infeksi yang berpotensi serius, seperti hepatitis B dan tuberkulosis.
- 2) **Imunisasi yang tepat waktu** sesuai dengan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Kementerian Kesehatan Indonesia harus dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap infeksi yang dapat dicegah dengan vaksin.

e. Penggunaan Perlengkapan yang Bersih

Pastikan **selimut, pakaian, dan alas tidur bayi** selalu dalam keadaan bersih dan dicuci dengan deterjen yang aman. Pakaian bayi harus dijaga agar tetap kering dan bersih untuk mencegah infeksi kulit.

f. Perawatan ASI

Memberikan ASI eksklusif pada bayi baru lahir memiliki manfaat penting dalam mencegah infeksi. ASI mengandung antibodi alami yang membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh bayi, memberikan perlindungan terhadap infeksi saluran cerna, infeksi pernapasan, dan lain-lain.

g. Mencegah Kontak dengan Orang yang Sakit

Bayi baru lahir sebaiknya dijauhkan dari orang yang sedang sakit, terutama yang mengalami gejala infeksi saluran pernapasan atau penyakit menular lainnya, untuk mengurangi risiko tertular infeksi.

h. Pemantauan Kondisi Bayi

Pemantauan suhu tubuh bayi secara rutin sangat penting. Suhu tubuh yang tinggi bisa menjadi tanda adanya infeksi. Pemeriksaan kesehatan rutin oleh tenaga medis untuk mendeteksi infeksi sejak dini akan sangat membantu dalam pencegahan infeksi lebih lanjut.

3. Faktor Risiko Infeksi pada Bayi Baru Lahir

Beberapa faktor yang meningkatkan risiko infeksi pada bayi baru lahir antara lain:

- a. **Prematuritas:** Bayi prematur lebih rentan terhadap infeksi karena sistem kekebalan tubuh mereka yang belum sepenuhnya berkembang.
- b. **Berat badan lahir rendah (BBLR):** Bayi dengan berat badan lahir rendah memiliki daya tahan tubuh yang lemah dan lebih rentan terhadap infeksi.

- c. **Kondisi medis ibu:** Infeksi ibu yang tidak terdeteksi atau tidak diobati, seperti infeksi menular seksual atau infeksi saluran kemih, dapat menularkan patogen kepada bayi selama proses persalinan.

4. Komplikasi Infeksi pada Bayi Baru Lahir

Jika infeksi tidak segera diatasi, dapat menyebabkan berbagai komplikasi, seperti:

- a. **Sepsis Neonatal:** Infeksi berat yang mempengaruhi seluruh tubuh dan dapat menyebabkan kerusakan organ.
- b. **Pneumonia:** Infeksi saluran pernapasan yang dapat mengganggu pernapasan bayi.
- c. **Meningitis:** Infeksi pada lapisan otak dan sumsum tulang belakang yang dapat menyebabkan kerusakan otak permanen.
- d. **Kematian:** Infeksi yang parah, jika tidak segera ditangani, dapat berakhir dengan kematian bayi.

D. Komunikasi Efektif dengan Ibu dan Keluarga

Komunikasi yang efektif dengan ibu dan keluarga yang memiliki bayi baru lahir sangat penting untuk mendukung perawatan yang optimal dan kesejahteraan bayi. Bayi baru lahir membutuhkan perhatian dan perawatan khusus, sementara ibu dan keluarga sering kali mengalami stres dan kecemasan karena peran baru mereka sebagai pengasuh. Oleh karena itu, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dapat membantu mengurangi kecemasan mereka, meningkatkan pemahaman tentang perawatan bayi, dan memperkuat hubungan antara tenaga medis dan keluarga. Berikut adalah prinsip-prinsip dan strategi komunikasi yang dapat diterapkan dalam berinteraksi dengan ibu dan keluarga bayi baru lahir.

1. Pentingnya Komunikasi dalam Perawatan Bayi Baru Lahir

Komunikasi yang efektif membantu ibu dan keluarga dalam memahami perawatan bayi yang benar, mengenali tanda-tanda bahaya, serta meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam merawat bayi baru lahir. Selain itu, komunikasi juga membantu:

- a. Mengurangi kecemasan ibu dan keluarga tentang kesehatan bayi.
- b. Meningkatkan keterlibatan keluarga dalam perawatan bayi.
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi perawatan yang diberikan oleh tenaga medis.

2. Prinsip-Prinsip Komunikasi yang Efektif

- a. Mendengarkan dengan empati
 - 1) Mendengarkan dengan penuh perhatian adalah langkah pertama dalam komunikasi yang efektif. Berikan perhatian penuh pada ibu dan keluarga, tunjukkan bahwa Anda memahami kekhawatiran mereka.

- 2) **Empati** adalah kunci. Cobalah untuk memahami perasaan dan kekhawatiran ibu dan keluarga, dan responlah dengan kata-kata yang mendukung dan penuh pengertian.
- b. Memberikan Informasi yang jelas dan sederhana
 - 1) Bayi baru lahir sering kali memerlukan perawatan medis yang kompleks, tetapi ibu dan keluarga mungkin tidak selalu memahami istilah medis. Oleh karena itu, penting untuk memberikan informasi dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami.
 - 2) Hindari penggunaan jargon medis yang membingungkan, dan jelaskan setiap prosedur atau tindakan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
- c. Berikan Dukungan Emosional
 - 1) Ibu yang baru melahirkan mungkin merasa cemas, lelah, atau bahkan terisolasi. Komunikasi yang efektif bukan hanya tentang memberikan informasi, tetapi juga memberikan dukungan emosional.
 - 2) Tanyakan bagaimana perasaan mereka dan berikan dorongan positif. Kata-kata yang penuh kasih dan pengertian dapat meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam merawat bayinya.
- d. Menghargai Keputusan Ibu dan Keluarga
 - 1) Setiap ibu dan keluarga memiliki nilai, keyakinan, dan budaya yang berbeda dalam merawat bayi. Sebagai tenaga medis, penting untuk **menghargai keputusan mereka** terkait perawatan bayi, meskipun tidak selalu sejalan dengan pendekatan medis yang direkomendasikan.
 - 2) Selalu jelaskan alasan di balik setiap keputusan medis, namun tetap terbuka terhadap diskusi dan pertanyaan dari ibu dan keluarga.
- e. Gunakan Komunikasi Non-Verbal yang Positif
 - 1) Komunikasi non-verbal, seperti kontak mata, senyuman, dan bahasa tubuh yang terbuka, sangat penting dalam menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung.
 - 2) Pastikan untuk menunjukkan sikap yang ramah dan penuh perhatian melalui bahasa tubuh, yang dapat membantu ibu merasa dihargai dan didukung.
3. **Strategi Komunikasi yang Efektif**
 - a. Berikan *Informasi yang Tepat pada Waktu yang Tepat*
 - 1) Bayi baru lahir memerlukan banyak perhatian, tetapi ibu juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Oleh karena itu, berikan informasi penting pada waktu yang tepat, misalnya saat ibu merasa lebih siap untuk menerima informasi.

- 2) **Sesuaikan tempo komunikasi** dengan keadaan ibu; jika mereka merasa lelah atau cemas, sampaikan informasi secara bertahap dan pastikan mereka memahami apa yang Anda katakan.
- b. Gunakan Pendekatan Kolaboratif
 - 1) Alih-alih memberikan instruksi yang kaku, cobalah untuk menggunakan pendekatan yang lebih **kolaboratif** dengan ibu dan keluarga. Ajak mereka untuk berdiskusi mengenai perawatan bayi dan berbagi pandangan mereka.
 - 2) Diskusikan pilihan-pilihan perawatan yang tersedia dan beri kesempatan bagi ibu untuk mengajukan pertanyaan atau mengungkapkan keraguannya.
- c. Berikan Edukasi tentang Perawatan Bayi Baru Lahir
 - 1) Edukasi tentang perawatan bayi baru lahir sangat penting, terutama untuk ibu yang baru pertama kali menjadi orang tua. Jelaskan hal-hal dasar seperti pemberian ASI, cara merawat tali pusar, tidur yang aman untuk bayi, dan cara mengenali tanda-tanda bayi yang tidak sehat.
 - 2) Gunakan **materi visual** (seperti gambar atau video) jika perlu, untuk memudahkan pemahaman ibu dan keluarga.
- d. Ciptakan Lingkungan yang Aman dan Terbuka untuk Berkomunikasi
 - 1) Pastikan ibu dan keluarga merasa nyaman untuk berbicara dengan Anda. Ciptakan lingkungan yang aman, di mana mereka merasa bebas untuk mengungkapkan perasaan dan kekhawatiran tanpa takut dihakimi.
 - 2) **Perhatikan perasaan ibu** dan keluarga, serta respon terhadap apa yang mereka sampaikan. Ini akan membantu membangun hubungan kepercayaan yang kuat.
- e. Pantau dan Tindak Lanjut Komunikasi
 - 1) Setelah memberikan informasi atau saran, pastikan untuk melakukan **tindak lanjut**. Cek kembali dengan ibu dan keluarga apakah mereka membutuhkan klarifikasi lebih lanjut atau apakah mereka merasa lebih baik setelah mendapatkan dukungan.
 - 2) Jangan ragu untuk menawarkan bantuan lebih lanjut atau mengatur sesi konsultasi lanjutan untuk membahas hal-hal yang belum terselesaikan.
4. Tantangan dalam Komunikasi dengan Ibu dan Keluarga

Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi tenaga medis dalam berkomunikasi dengan ibu dan keluarga yang memiliki bayi baru lahir meliputi:

 - a. **Kecemasan dan ketegangan emosional:** Ibu mungkin merasa khawatir atau cemas tentang kesejahteraan bayi, yang bisa mempengaruhi kemampuan mereka untuk menerima informasi.

- b. **Keterbatasan waktu:** Tenaga medis seringkali memiliki jadwal yang padat, namun penting untuk memberikan perhatian penuh kepada ibu dan keluarga meskipun dalam waktu singkat.
- c. **Perbedaan budaya dan keyakinan:** Beberapa keluarga mungkin memiliki pandangan atau praktik budaya yang berbeda dalam merawat bayi. Tenaga medis harus bijaksana dalam menghargai dan mengakomodasi perbedaan ini.

E. Pendokumentasian Asuhan Keperawatan

Pendokumentasian asuhan keperawatan pada neonatus esensial adalah proses penting yang bertujuan untuk mencatat secara sistematis semua informasi terkait perawatan yang diberikan kepada bayi baru lahir (neonatus). Asuhan neonatus esensial meliputi tindakan keperawatan dasar yang bertujuan untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan bayi baru lahir serta mencegah komplikasi kesehatan yang dapat terjadi pada periode neonatal. Pendokumentasian yang baik memastikan bahwa semua prosedur dan intervensi yang dilakukan tercatat dengan jelas, sehingga memudahkan koordinasi antar tim medis, mengurangi risiko kesalahan, serta memberikan bukti yang jelas untuk evaluasi dan perencanaan lanjutan.

1. Tujuan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan pada Neonatus Esensial

Pendokumentasian asuhan keperawatan bertujuan untuk:

- a. **Mencatat perkembangan kesehatan neonatus:** Melalui dokumentasi, perawat dapat melacak kondisi kesehatan bayi dari waktu ke waktu, mendeteksi perubahan atau perkembangan yang memerlukan intervensi.
- b. **Meningkatkan koordinasi tim medis:** Dokumentasi yang lengkap memudahkan komunikasi antara tenaga medis yang berbeda (misalnya, perawat, dokter, atau ahli gizi) untuk memastikan perawatan yang konsisten dan tepat.
- c. **Meningkatkan kualitas perawatan:** Dengan mendokumentasikan setiap tindakan perawatan, perawat dapat mengidentifikasi area perawatan yang perlu perbaikan dan melakukan penyesuaian berdasarkan evaluasi berkala.
- d. **Memberikan dasar hukum:** Dokumentasi yang akurat dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus hukum atau dalam proses audit medis untuk memastikan bahwa perawatan yang diberikan sesuai dengan standar profesional dan hukum.

2. Komponen Dokumentasi Asuhan Keperawatan pada Neonatus Esensial

Dokumentasi asuhan keperawatan pada neonatus esensial harus mencakup berbagai aspek penting yang berhubungan dengan kondisi fisik, status

kesehatan, dan tindakan yang telah dilakukan. Beberapa komponen utama yang perlu dicatat antara lain:

a. Identitas Pasien

- 1) Nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan informasi identitas lainnya.
- 2) Data ibu, seperti usia, status kesehatan, serta riwayat medis yang relevan.

b. Status Fisik Neonatus

- 1) **Tanda vital:** Mencatat suhu tubuh, frekuensi pernapasan, denyut jantung, dan tekanan darah bayi.
- 2) **Berat badan dan panjang badan:** Informasi ini penting untuk memantau pertumbuhan neonatus selama periode neonatal.
- 3) **Warna kulit:** Memperhatikan tanda-tanda ikterus atau sianosis.
- 4) **Tali pusar:** Kondisi tali pusar, apakah kering atau terjadi infeksi.
- 5) **Pengaturan suhu tubuh:** Monitoring dan pencatatan apakah bayi mengalami hipotermi atau hipertermia, dan bagaimana upaya pemanasan dilakukan.

c. Asupan dan Pemberian ASI

- 1) Jumlah ASI yang diterima oleh bayi, baik secara langsung dari ibu atau melalui botol.
- 2) Pemberian sufor jika diperlukan (terutama jika ibu mengalami kesulitan menyusui).
- 3) Evaluasi tentang teknik menyusui dan peran keluarga dalam mendukung ibu.

d. Pemberian Obat dan Intervensi Medis

- 1) Pemberian vaksinasi, seperti vaksin hepatitis B dan BCG, serta catatan mengenai pengobatan medis lainnya jika diperlukan.
- 2) Dokumentasi terkait penggunaan alat medis atau teknologi kesehatan, seperti inkubator, alat bantu pernapasan, atau alat pemantau vital.

e. Perawatan Kulit dan Sanitasi

- 1) Pencatatan mengenai perawatan kulit bayi, termasuk perawatan tali pusar dan pencegahan infeksi kulit.
- 2) Catatan tentang kebersihan bayi, termasuk pemberian mandi dan perubahan popok.

f. Keadaan Psikososial dan Dukungan Keluarga

- 1) Dokumentasi mengenai keterlibatan keluarga dalam perawatan, terutama ibu, serta dampak emosional dari kelahiran terhadap ibu.
- 2) Dukungan yang diberikan kepada ibu, termasuk konseling menyusui dan penanganan masalah psikologis yang mungkin terjadi, seperti baby blues atau depresi pasca-persalinan.

3. Metode Pendokumentasian

Ada berbagai cara untuk mendokumentasikan asuhan keperawatan pada neonatus esensial, antara lain:

a. Dokumentasi Manual

Pendokumentasian menggunakan formulir atau catatan tangan yang berisi semua data penting tentang neonatus. Meskipun metode ini masih banyak digunakan, catatan manual memiliki kelemahan dalam hal kecepatan pencarian data dan keakuratan informasi.

b. Dokumentasi Elektronik

1) Sistem rekam medis elektronik (Electronic Health Record/EHR) merupakan metode yang semakin populer untuk mendokumentasikan asuhan keperawatan. Dengan menggunakan sistem ini, data pasien dapat diakses lebih cepat, mempermudah pengawasan, dan meningkatkan koordinasi antar tim medis.

2) EHR juga memungkinkan penggunaan kode standar untuk kondisi medis dan prosedur yang membantu mempercepat dokumentasi dan mengurangi kesalahan manusia.

4. Standar Dokumentasi Asuhan Neonatus

Pendokumentasian harus dilakukan dengan memperhatikan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga kesehatan, seperti: **Standar Asuhan Neonatus** dari Kementerian Kesehatan atau organisasi kesehatan internasional dan **standar Operasional Prosedur (SOP)** yang ditetapkan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan tempat bayi dirawat.

a. Keteraturan dan Konsistensi

Setiap dokumentasi harus dilakukan secara konsisten dan dengan waktu yang tepat, sehingga tidak ada informasi yang terlewat dan tim medis dapat melacak perkembangan kondisi neonatus secara akurat.

b. Keamanan Data

Penting untuk menjaga kerahasiaan data bayi dan keluarga. Semua informasi yang dicatat harus dijaga keamanannya untuk mencegah penyalahgunaan data.

5. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Setelah pendokumentasian, penting untuk melakukan evaluasi terhadap perawatan yang diberikan. Evaluasi ini mencakup:

a. **Review kondisi neonatus** secara berkala untuk memastikan bahwa semua intervensi medis dan perawatan berjalan sesuai rencana.

b. **Rencana tindak lanjut** jika diperlukan, seperti kunjungan kontrol atau pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan temuan dokumentasi.

F. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat

1. Salah satu tindakan penting dalam perawatan bayi baru lahir yang melibatkan pemanasan bayi segera setelah lahir adalah:
 - A. Pemberian ASI pertama
 - B. Melakukan tindakan resusitasi pada bayi
 - C. Mengatur suhu ruangan bayi agar tetap hangat
 - D. Menjaga kebersihan tangan perawat
 - E. Memberikan vaksinasi hepatitis B
2. Dokumentasi yang akurat dan terperinci dalam asuhan keperawatan neonatus esensial sangat penting karena:
 - A. Hanya diperlukan untuk laporan administrasi rumah sakit
 - B. Dapat digunakan untuk mengurangi biaya perawatan bayi
 - C. Mempermudah komunikasi dan koordinasi antar tim medis
 - D. Menunjukkan kualitas perawatan secara finansial
 - E. Mencegah kelelahan perawat dalam merawat bayi
3. Pelaksanaan asuhan keperawatan pada bayi baru lahir yang meliputi pemantauan tanda vital seperti suhu tubuh, frekuensi napas, denyut jantung, dan tekanan darah, bertujuan untuk:
 - A. Meningkatkan keterlibatan keluarga dalam perawatan bayi
 - B. Menilai kondisi fisik bayi dan mendeteksi perubahan yang membutuhkan intervensi
 - C. Memberikan informasi kepada ibu tentang kesehatan bayi
 - D. Menyediakan data statistik untuk laporan rumah sakit
 - E. Mengatur jadwal imunisasi bayi
4. Pemberian ASI eksklusif pada bayi baru lahir memiliki manfaat untuk:
 - A. Meningkatkan berat badan bayi dengan cepat
 - B. Meningkatkan kualitas tidur bayi
 - C. Meningkatkan kekebalan tubuh bayi dan melindungi dari infeksi
 - D. Membantu perkembangan sistem pencernaan bayi yang lebih baik
 - E. Menjaga kebersihan kulit bayi
5. Jika bayi baru lahir mengalami hipotermi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah:
 - A. Memberikan sufor segera
 - B. Menempatkan bayi pada inkubator atau melakukan pemanasan dengan skin-to-skin
 - C. Melakukan evaluasi terhadap tanda vital

- D. Memberikan obat demam
- E. Menunggu hingga suhu tubuh bayi naik dengan sendirinya

Jawablah pertanyaan berikut

1. Jelaskan prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan pada bayi baru lahir yang melibatkan pemantauan tanda vital, termasuk suhu tubuh, frekuensi pernapasan, denyut jantung, dan tekanan darah!
2. Deskripsikan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan bayi baru lahir tidak mengalami hipotermi dan bagaimana cara mendokumentasikan perawatannya!
3. Jelaskan prosedur perawatan tali pusar pada bayi baru lahir dan bagaimana cara mendokumentasikan hasil perawatan tersebut!
4. Jelaskan langkah-langkah prosedural yang dilakukan dalam pemantauan dan perawatan kulit bayi baru lahir, serta bagaimana mencatat temuan dari perawatan tersebut!
5. Apa saja prosedur yang harus dilakukan oleh perawat dalam memberikan ASI pertama kepada bayi baru lahir, dan bagaimana cara mendokumentasikan tindakan tersebut?

Kunci Jawaban Soal Objektif

1. C
2. C
3. B
4. C
5. B

G. Rangkuman Materi

Pelaksanaan asuhan keperawatan pada bayi baru lahir berdasarkan neonatus esensial mencakup langkah-langkah penting untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan bayi. Prosedur utama yang dilakukan adalah **Pemantauan Tanda Vital**: Memantau suhu tubuh, frekuensi pernapasan, denyut jantung, dan tekanan darah bayi secara rutin untuk memastikan bayi dalam kondisi stabil; **Pencegahan Hipotermi**: Memberikan pemanasan pada bayi segera setelah kelahiran untuk mencegah penurunan suhu tubuh yang berbahaya, melalui metode skin-to-skin atau incubator; **Pemberian ASI**: Memberikan ASI eksklusif segera setelah kelahiran untuk meningkatkan kekebalan tubuh bayi dan mendukung pertumbuhan yang sehat; **Perawatan Tali Pusar**: Memastikan tali pusar bayi tetap kering dan bersih

untuk mencegah infeksi, dengan menggunakan antiseptik dan pemantauan rutin; **Imunisasi:** Pemberian vaksin hepatitis B dan BCG dalam 24 jam pertama untuk melindungi bayi dari infeksi berbahaya; **Perawatan Kulit:** Membersihkan kulit bayi dengan lembut untuk mencegah infeksi dan menjaga kebersihan; **Dokumentasi:** Semua tindakan dan temuan selama perawatan bayi harus dicatat dengan jelas untuk memastikan koordinasi yang baik antar tenaga medis dan untuk evaluasi lebih lanjut. Tujuan dari pelaksanaan asuhan ini adalah untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir berjalan dengan optimal dan mengurangi risiko komplikasi kesehatan.

H. Glosarium

Neonatus Esensial : Pengasuhan dasar dan tindakan keperawatan yang sangat penting untuk menjaga kesehatan bayi baru lahir, termasuk pemantauan kondisi fisik, pencegahan infeksi, pemberian nutrisi, serta pemeliharaan suhu tubuh yang stabil.

Pemantauan Tanda Vital : Proses pengukuran dan pencatatan kondisi fisik bayi baru lahir seperti suhu tubuh, frekuensi napas, denyut jantung, dan tekanan darah untuk mendeteksi adanya perubahan kondisi yang memerlukan intervensi medis.

Hipotermi : Kondisi medis yang terjadi ketika suhu tubuh bayi turun di bawah 36,5°C. Hipotermi pada bayi baru lahir sangat berbahaya dan dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak ditangani dengan segera.

Skin-to-Skin Contact : Teknik perawatan di mana bayi diletakkan langsung di dada ibu tanpa pakaian untuk menjaga suhu tubuh bayi tetap hangat, memperkuat ikatan ibu dan bayi, serta mendukung proses menyusui awal.

ASI Eksklusif : Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara penuh tanpa tambahan makanan atau minuman lainnya pada bayi baru lahir selama enam bulan pertama kehidupan untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan sistem imun bayi.

Imunisasi Neonatus : Pemberian vaksin kepada bayi baru lahir untuk melindungi dari penyakit infeksi. Vaksin yang diberikan dalam 24 jam pertama termasuk hepatitis B dan BCG (untuk tuberkulosis).

Perawatan Tali Pusar: Proses merawat tali pusar bayi setelah kelahiran untuk mencegah infeksi. Tali pusar harus tetap kering, dibersihkan dengan antiseptik, dan diperiksa secara rutin untuk memastikan tidak ada tanda infeksi.

Perawatan Kulit: Tindakan menjaga kebersihan dan kesehatan kulit bayi baru lahir melalui mandi dengan air hangat dan sabun lembut, serta pemantauan untuk mendeteksi iritasi atau infeksi kulit yang dapat terjadi pada bayi.

Dokumentasi Keperawatan: Proses pencatatan segala tindakan perawatan yang dilakukan kepada bayi baru lahir, termasuk pengukuran tanda vital, pemberian ASI, pemberian imunisasi, serta perawatan tali pusar dan kulit. Dokumentasi ini sangat penting untuk koordinasi antar tenaga medis dan evaluasi perawatan.

Perawatan Neonatal: Semua aspek perawatan yang diberikan pada bayi baru lahir untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan bayi. Ini termasuk pemeriksaan fisik, pemberian nutrisi, pencegahan infeksi, serta perawatan rutin lainnya yang mendukung pertumbuhan bayi yang sehat.

Tali Pusar: Struktur yang menghubungkan bayi dengan plasenta di dalam rahim ibu, yang harus dipotong setelah bayi lahir. Perawatan tali pusar penting untuk mencegah infeksi pasca kelahiran.

Vaksin Hepatitis B: Vaksin yang diberikan pada bayi baru lahir untuk melindungi mereka dari infeksi hepatitis B, yang dapat berakibat fatal jika tidak dicegah.

Vaksin BCG (Bacillus Calmette-Guérin): Vaksin yang diberikan pada bayi baru lahir untuk melindungi dari tuberkulosis (TB). Vaksin ini biasanya diberikan pada lengan bayi dalam 24 jam pertama setelah kelahiran.

Pengukuran Berat Badan: Proses pengukuran berat badan bayi baru lahir yang sangat penting untuk memantau perkembangan dan kesehatan bayi. Berat badan yang rendah dapat menjadi indikator adanya masalah gizi atau kesehatan.

Evaluasi Perawatan Neonatal: Proses menilai kondisi bayi secara berkala selama periode neonatal untuk memastikan bahwa semua tindakan perawatan dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan standar medis.

I. Daftar Pustaka

American Academy of Pediatrics (AAP). (2016). *Communicating with Parents: Approaches to Providing Information to Parents in Neonatal Care*. Pediatrics, 138(6). <https://doi.org/10.1542/peds.2016-3441>

American Academy of Pediatrics (AAP). (2016). *Guidelines for Perinatal Care*. 8th edition. American Academy of Pediatrics.

American Academy of Pediatrics (AAP). (2016). *Neonatal Nursing: Essential Care and Documentation*. Pediatrics, 138(6). <https://doi.org/10.1542/peds.2016-3374>

American Academy of Pediatrics. (2017). *Infections in Neonates*. Pediatrics, 139(3). <https://doi.org/10.1542/peds.2016-3374>

American Academy of Pediatrics. (2017). *Prevention of Hypothermia in Newborns*. Pediatrics, 139(1). <https://doi.org/10.1542/peds.2016-2492>

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2020). *Prevention of Neonatal Infections*. CDC. Retrieved from [<https://www.cdc.gov>]

- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2015). *Wong's Nursing Care of Infants and Children*. Elsevier Health Sciences.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.** (2018). *Pedoman Asuhan Keperawatan Neonatus di Rumah Sakit*. Kementerian Kesehatan RI.
- Mayo Clinic.** (2020). *Umbilical Cord Care: When to Call a Doctor*. Mayo Clinic. [Link](#)
- Morrow, R., & Barroso, D. (2020).** *Nursing Care of the Newborn and Infant: A Family-Centered Approach*. Jones & Bartlett Learning.
- Seidman, D. S., & Shah, A. S. (2017).** *Care of the Umbilical Cord Stump in Newborns*. *Pediatrics*, 139(1), e20163279.
- Sullivan, G. M., & Lister, G. (2017). *Communication Strategies in Neonatal Care*. Elsevier Health Sciences.
- Sullivan, G. M., & Lister, G. (2017).** *Neonatal Care and Documentation: Standards and Best Practices*. Elsevier Health Sciences.
- Sullivan, G. M., & Lister, G. (2017).** *Newborn Care: Prevention of Hypothermia in Neonates*. Elsevier Health Sciences.
- World Health Organization (WHO). (2013). *Communication for Maternal and Newborn Health*. WHO. Retrieved from [\[https://www.who.int\]](https://www.who.int)
- World Health Organization (WHO).** (2014). *Neonatal Hypothermia: Assessment and Management*. WHO. Retrieved from [\[https://www.who.int\]](https://www.who.int)
- World Health Organization (WHO).** (2015). *Essential Newborn Care*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization (WHO).** (2015). *Infection Prevention and Control of Epidemic- and Pandemic-Prone Acute Respiratory Infections in Health Care*. WHO. Retrieved from [\[https://www.who.int\]](https://www.who.int)

BAB 5

KONSEP ASUHAN KEPERAWATAN PADA BAYI DAN ANAK DENGAN GANGGUAN KEBUTUHAN ELIMINASI PATOLOGIS DARI SISTEM PENCERNAAN DAN KEMIH/KELAINAN KONGENITAL/PERIOPERATIF CARE

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada bayi dan anak dengan gangguan kebutuhan eliminasi patologis dari sistem pencernaan dan kemih, kelainan kongenital, serta mampu mengelola perawatan perioperatif secara aman, efektif, dan humanistik.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan topik ini, mahasiswa diharapkan mampu:

Memahami konsep dasar gangguan eliminasi patologis pada bayi dan anak dari sistem pencernaan dan kemih serta kelainan kongenital terkait.

Melaksanakan proses asuhan keperawatan yang terintegrasi pada bayi dan anak dengan gangguan eliminasi.

Mengelola asuhan perioperatif secara efektif dan aman pada bayi dan anak yang menjalani tindakan bedah akibat gangguan eliminasi dan kelainan kongenital.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan etiologi, tanda, gejala, dan dampak gangguan eliminasi patologis pada bayi dan anak.
- Mengidentifikasi berbagai kelainan kongenital pada sistem pencernaan dan kemih yang berhubungan dengan gangguan eliminasi.
- Merumuskan diagnosa keperawatan berdasarkan pengkajian yang komprehensif.
- Merancang dan melaksanakan intervensi keperawatan yang tepat, sesuai dengan kondisi klinis pasien.
- Melakukan evaluasi asuhan keperawatan untuk memastikan tercapainya tujuan terapi secara efektif.

- Memahami prinsip dan praktik perawatan perioperatif yang spesifik pada bayi dan anak dengan gangguan eliminasi.

Pendahuluan

Asuhan keperawatan pada bayi dan anak dengan gangguan kebutuhan eliminasi patologis sistem pencernaan dan kemih merupakan salah satu area kritis dalam praktik keperawatan pediatrik. Gangguan ini bisa disebabkan oleh berbagai kondisi patologis, seperti kelainan kongenital, infeksi, atau kondisi pascaoperasi. Pengetahuan dan keterampilan yang tepat sangat penting agar perawat dapat memberikan asuhan optimal kepada bayi dan anak, serta mendukung keluarga dalam proses perawatan. Buku ajar ini akan membahas konsep dasar, pendekatan asuhan keperawatan yang komprehensif, serta manajemen perioperatif yang aman dan efektif.

A. Konsep Dasar Gangguan Eliminasi pada Bayi dan Anak

Konsep dasar gangguan eliminasi pada bayi dan anak merupakan aspek yang penting dalam memahami berbagai kondisi patologis yang mempengaruhi sistem pencernaan maupun sistem kemih, yang pada akhirnya menyebabkan gangguan pada proses eliminasi, baik berupa urine maupun tinja. Secara umum, eliminasi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Pada bayi dan anak, gangguan eliminasi sering kali menjadi masalah serius yang dapat mengganggu pertumbuhan, perkembangan, serta kualitas hidup mereka. Oleh sebab itu, pemahaman yang komprehensif tentang berbagai kondisi yang melatarbelakangi gangguan eliminasi ini sangat diperlukan oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat anak.

Gangguan eliminasi pada bayi dan anak tidak selalu berkaitan dengan faktor tunggal, melainkan dapat terjadi karena berbagai penyebab yang melibatkan faktor anatomis, fungsional, maupun akibat infeksi. Secara anatomis, bayi dan anak memiliki struktur organ yang masih berkembang dan cenderung lebih sensitif terhadap berbagai gangguan. Hal ini menjadikan mereka rentan mengalami kelainan kongenital atau bawaan sejak lahir yang mengganggu fungsi organ eliminasi.

Salah satu contoh kelainan kongenital yang sering ditemukan pada bayi dan anak adalah penyakit Hirschsprung. Penyakit ini disebabkan oleh kegagalan perkembangan saraf pada sebagian usus besar yang berfungsi mengatur pergerakan usus (peristaltik). Akibat ketiadaan sel ganglion pada bagian tertentu usus besar, terjadi hambatan dalam proses eliminasi tinja, sehingga usus mengalami dilatasi atau pembesaran akibat tinja yang menumpuk. Secara klinis, bayi atau anak dengan penyakit Hirschsprung biasanya mengalami konstipasi kronis, distensi abdomen, serta kesulitan dalam buang air besar yang berlangsung lama. Kondisi ini membutuhkan intervensi bedah untuk memperbaiki fungsi usus yang terganggu, disertai dengan manajemen perioperatif yang cermat.

Selain itu, gangguan eliminasi juga dapat terjadi karena kelainan anatomis lain seperti atresia ani, suatu kondisi di mana bayi dilahirkan tanpa lubang anus atau dengan lubang anus yang tidak sempurna. Atresia ani merupakan kondisi darurat medis yang harus segera dikenali dan ditangani sejak dini. Bayi dengan kelainan ini biasanya tidak mampu buang air besar sama sekali setelah lahir, mengalami distensi abdomen progresif, muntah, dan terlihat kesakitan. Penatalaksanaan kondisi ini melibatkan tindakan bedah untuk membuat lubang anus baru, dan perawat perlu memberikan asuhan perioperatif serta edukasi kepada orang tua terkait perawatan jangka panjang.

Pada sistem kemih, gangguan eliminasi sering kali diakibatkan oleh refluks vesikoureteral, kondisi yang terjadi ketika urine dari kandung kemih mengalir balik ke ureter bahkan sampai ke ginjal. Kondisi ini berpotensi menyebabkan infeksi saluran kemih berulang serta dapat merusak ginjal apabila tidak segera ditangani. Bayi atau anak dengan refluks vesikoureteral dapat menunjukkan gejala seperti infeksi saluran kemih berulang, demam tinggi tanpa sebab jelas, serta kesakitan saat berkemih. Deteksi dini melalui pemeriksaan pencitraan sangat penting guna menentukan derajat keparahan serta intervensi medis maupun bedah yang dibutuhkan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Selain kelainan refluks, bayi dan anak juga rentan mengalami kondisi hipospadia, kelainan bawaan pada organ genital pria di mana letak lubang uretra berada tidak pada posisi normal di ujung penis, tetapi lebih ke bawah atau ke samping. Hipospadia tidak hanya mengganggu proses eliminasi urine tetapi juga mempengaruhi aspek psikososial pada anak saat bertambah besar. Kelainan ini memerlukan koreksi melalui operasi yang umumnya dilakukan saat anak berusia antara 6 hingga 18 bulan. Perawat memiliki peran penting dalam memberikan asuhan perioperatif, termasuk edukasi keluarga mengenai perawatan luka operasi serta dukungan emosional bagi orang tua dan anak dalam menghadapi prosedur bedah.

B. Pengkajian Keperawatan pada Gangguan Eliminasi

Pengkajian keperawatan pada bayi dan anak dengan gangguan eliminasi merupakan langkah yang penting dalam mengidentifikasi berbagai masalah yang mendasari kondisi tersebut, sehingga dapat dilakukan intervensi keperawatan secara tepat dan efektif. Proses pengkajian ini harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik fisik maupun psikologis. Pengkajian yang baik akan memberikan gambaran klinis yang akurat mengenai kondisi pasien, serta memberikan arahan dalam menyusun perencanaan asuhan keperawatan yang optimal.

Proses pengkajian dimulai dengan tahap anamnesis komprehensif, yang merupakan tahapan awal yang krusial dalam mengumpulkan informasi mengenai riwayat kesehatan anak. Dalam tahap ini, perawat harus menggali informasi secara mendalam dari orang tua atau pengasuh tentang keluhan utama yang dirasakan oleh anak, durasi keluhan, intensitas keluhan, serta faktor-faktor yang memperberat atau meringankan gejala tersebut. Misalnya, jika keluhan terkait dengan gangguan eliminasi tinja, perawat perlu mengidentifikasi frekuensi dan konsistensi tinja, adanya konstipasi atau diare kronis, serta riwayat defekasi yang abnormal seperti adanya tinja berdarah atau berlendir. Begitu pula untuk gangguan eliminasi urin, perawat harus mencatat pola miksi, seperti frekuensi berkemih, volume urine, dan keluhan nyeri saat berkemih yang mungkin terjadi.

Selain anamnesis, observasi terhadap tanda dan gejala klinis secara langsung merupakan komponen yang sangat penting. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan data objektif yang mendukung temuan anamnesis. Perawat perlu mengamati tanda-tanda fisik seperti adanya distensi abdomen, perubahan bentuk atau konsistensi feses, serta adanya tanda-tanda obstruksi atau retensi urin, misalnya pembesaran kandung kemih yang teraba dari luar, adanya bengkak atau inflamasi pada area genital, atau kelainan anatomi yang dapat terlihat secara kasat mata seperti hipospadia. Nyeri juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam observasi, karena nyeri yang dialami anak dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup anak secara keseluruhan.

Selanjutnya, pengkajian keperawatan juga memerlukan pemeriksaan penunjang yang relevan guna mendukung diagnosis medis dan membantu menentukan arah tindakan selanjutnya. Pemeriksaan penunjang tersebut mencakup pemeriksaan ultrasonografi (USG), yang dapat mengidentifikasi kelainan anatomis pada organ-organ pencernaan maupun kemih secara visual. USG merupakan pemeriksaan yang sering digunakan karena bersifat non-invasif, aman, dan relatif nyaman bagi anak-anak. Selain itu, pemeriksaan laboratorium juga sangat penting untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya infeksi atau kelainan metabolik, seperti pemeriksaan urine lengkap untuk mendeteksi infeksi saluran kemih, darah lengkap untuk menilai infeksi atau anemia, dan pemeriksaan feses untuk melihat adanya darah, lendir, atau infeksi lainnya. Pemeriksaan pencitraan lain seperti sinar-X abdomen, sistogram miksi, atau CT-scan dapat dipertimbangkan untuk kasus yang lebih kompleks atau jika USG tidak cukup memberikan informasi yang diperlukan.

Aspek psikologis pasien dan keluarga juga perlu mendapat perhatian khusus dalam proses pengkajian keperawatan pada gangguan eliminasi ini. Adanya gangguan eliminasi, terutama pada kondisi kronis atau kelainan kongenital, seringkali menimbulkan beban emosional dan psikologis yang signifikan bagi anak maupun keluarga. Orang tua mungkin mengalami stres atau kecemasan yang tinggi karena kondisi anak yang tidak kunjung membaik, sedangkan anak sendiri bisa merasa malu, rendah diri, atau mengalami gangguan psikososial akibat keterbatasan dalam aktivitas sosial. Perawat perlu menggali bagaimana keluarga merespons kondisi anak tersebut, bagaimana pola asuh dan dukungan yang diberikan keluarga, serta tingkat pemahaman keluarga tentang kondisi kesehatan anak. Pengkajian psikologis ini bertujuan untuk memberikan intervensi yang tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek psikososial secara menyeluruh.

C. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan pada bayi dan anak dengan gangguan eliminasi mencerminkan berbagai permasalahan yang dialami pasien dan memerlukan perhatian serta intervensi keperawatan yang tepat. Diagnosa keperawatan ini

merupakan hasil dari analisis data pengkajian yang telah dilakukan secara mendalam, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun aspek lingkungan yang mempengaruhi kondisi anak tersebut. Berbagai diagnosa keperawatan yang umum ditemukan pada pasien dengan gangguan eliminasi mencakup eliminasi urine dan feses terganggu, risiko infeksi, nyeri akut, ansietas, serta risiko gangguan pertumbuhan dan perkembangan.

Eliminasi urine dan feses terganggu adalah diagnosa keperawatan yang paling umum dan menjadi inti permasalahan pada bayi dan anak dengan gangguan eliminasi patologis. Diagnosa ini terjadi akibat adanya hambatan anatomi, perubahan fungsi organ, atau dampak dari tindakan bedah yang menyebabkan anak mengalami kesulitan atau ketidakmampuan mengeluarkan urine atau tinja secara normal. Manifestasi klinis yang sering menyertai diagnosa ini meliputi distensi abdomen, perubahan frekuensi buang air besar atau kecil, serta pola eliminasi yang tidak teratur. Anak dapat mengalami retensi urin yang menyebabkan ketidaknyamanan, nyeri, bahkan komplikasi lanjutan seperti infeksi saluran kemih atau kerusakan ginjal apabila tidak segera ditangani. Demikian pula dengan gangguan eliminasi tinja yang kronis, misalnya akibat penyakit Hirschsprung, yang dapat mengakibatkan konstipasi kronis, megakolon, serta berbagai masalah terkait nutrisi dan metabolisme.

Risiko infeksi merupakan diagnosa penting lain yang perlu diperhatikan pada gangguan eliminasi patologis ini. Kondisi seperti refluks vesikoureteral atau tindakan invasif seperti pemasangan kateter urin dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran kemih yang berulang. Infeksi saluran kemih pada anak bisa berkembang menjadi komplikasi yang lebih serius, seperti pielonefritis atau sepsis, yang tentunya dapat membahayakan nyawa anak jika tidak segera ditangani dengan baik. Demikian pula pada gangguan eliminasi feces seperti pada anak dengan atresia ani yang memerlukan operasi, terdapat risiko infeksi luka operasi maupun infeksi saluran cerna. Perawat perlu memantau tanda-tanda awal infeksi seperti demam, nyeri lokal, perubahan warna atau bau pada urine atau feses, serta gejala sistemik lain seperti letargi atau nafsu makan menurun agar intervensi segera dapat dilakukan.

Nyeri akut juga merupakan diagnosa keperawatan yang penting karena nyeri menjadi keluhan utama yang sering dialami bayi dan anak yang mengalami gangguan eliminasi. Nyeri dapat bersumber dari distensi abdomen akibat retensi urine atau tinja, inflamasi, infeksi, atau rasa sakit pascaoperasi. Identifikasi nyeri pada anak sering kali memerlukan pendekatan yang lebih khusus mengingat keterbatasan kemampuan anak dalam mengekspresikan nyeri secara verbal. Perawat harus menggunakan observasi terhadap ekspresi wajah, tangisan, gerakan tubuh, serta perubahan perilaku anak seperti mudah rewel atau menarik diri untuk mengenali keberadaan nyeri ini. Manajemen nyeri yang adekuat tidak hanya

meningkatkan kenyamanan anak, tetapi juga mendukung proses pemulihan yang lebih cepat serta meningkatkan kepatuhan terhadap intervensi terapeutik lainnya.

Ansietas menjadi diagnosa keperawatan lain yang sangat relevan pada gangguan eliminasi patologis anak. Ansietas dapat muncul tidak hanya pada anak tetapi juga pada orang tua dan anggota keluarga lainnya. Rasa cemas ini umumnya muncul karena ketidakpastian mengenai kondisi anak, prognosis, tindakan medis atau bedah yang akan dilakukan, serta kekhawatiran akan dampak jangka panjang dari kondisi tersebut terhadap kehidupan anak. Perawat perlu memberikan perhatian khusus terhadap aspek ini, dengan memberikan dukungan emosional, edukasi yang jelas, serta kesempatan bagi orang tua untuk mengekspresikan perasaan dan kekhawatiran mereka. Pendekatan empatik dan komunikasi terapeutik yang efektif sangat penting dalam meredakan kecemasan dan membantu keluarga memahami kondisi serta rencana perawatan yang diberikan kepada anak.

Risiko gangguan pertumbuhan dan perkembangan adalah diagnosa keperawatan yang juga tidak boleh diabaikan, terutama pada anak dengan gangguan eliminasi kronis atau kelainan kongenital. Gangguan eliminasi yang tidak teratasi dengan baik akan mempengaruhi nutrisi anak, menyebabkan masalah makan akibat ketidaknyamanan abdomen, serta mengurangi kualitas tidur dan aktivitas anak secara keseluruhan. Kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan fisik maupun perkembangan psikososial anak. Perawat harus senantiasa memantau parameter tumbuh kembang seperti berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala, serta kemampuan motorik dan sosial anak secara rutin. Intervensi keperawatan yang tepat seperti manajemen nutrisi, stimulasi perkembangan yang sesuai, serta pemantauan ketat dapat membantu meminimalkan risiko ini sehingga anak tetap bisa mencapai tahapan tumbuh kembang yang optimal.

D. Perencanaan dan Intervensi Keperawatan

Perencanaan dan intervensi keperawatan pada bayi dan anak dengan gangguan eliminasi merupakan tahap yang esensial dalam proses asuhan keperawatan, di mana tujuan utamanya adalah untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan yang telah diidentifikasi dalam diagnosa keperawatan, serta untuk meningkatkan kualitas hidup pasien secara menyeluruh. Perencanaan yang matang dan intervensi yang tepat tidak hanya berfokus pada pengelolaan gejala fisik, tetapi juga mencakup edukasi dan dukungan psikososial yang bertujuan memberdayakan keluarga untuk dapat terlibat aktif dalam proses perawatan.

Salah satu aspek penting dalam intervensi keperawatan pada anak dengan gangguan eliminasi adalah manajemen nyeri. Mengingat nyeri dapat secara signifikan mengganggu kenyamanan anak, perawat perlu melakukan penilaian nyeri secara berkala menggunakan alat ukur yang sesuai dengan usia anak, seperti skala wajah (Wong-Baker Faces Pain Scale), FLACC scale, atau skala perilaku lainnya.

Setelah penilaian dilakukan, perawat kemudian harus menentukan metode manajemen nyeri yang sesuai, mulai dari intervensi farmakologis dengan pemberian analgesik sesuai anjuran dokter hingga metode nonfarmakologis seperti relaksasi, distraksi melalui permainan, penggunaan teknik sentuhan terapeutik, dan kehangatan lokal untuk mengurangi rasa nyeri. Tujuan dari manajemen nyeri ini tidak hanya untuk mengurangi atau menghilangkan nyeri tetapi juga untuk membantu anak merasa lebih nyaman sehingga proses pemulihan dapat berlangsung dengan lebih optimal.

Pengawasan status eliminasi juga menjadi intervensi utama yang harus dilakukan secara kontinu dan cermat. Perawat bertanggung jawab untuk memonitor pola eliminasi urin dan feses secara rutin, mencatat jumlah, frekuensi, konsistensi, warna, serta bau yang abnormal jika ditemukan. Pemantauan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini perubahan status eliminasi yang mungkin mengindikasikan komplikasi seperti retensi urin, obstruksi saluran cerna, atau perkembangan infeksi yang lebih serius. Selain itu, perawat juga bertanggung jawab memastikan pasien mendapatkan asupan cairan yang adekuat untuk membantu memperlancar proses eliminasi, mencegah terjadinya dehidrasi, serta menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh.

Perawatan kulit menjadi intervensi penting lainnya, terutama pada pasien yang mengalami gangguan eliminasi kronis atau pascaoperasi yang meningkatkan risiko terjadinya kerusakan integritas kulit akibat kontak dengan urine atau feses. Perawat harus menjaga kebersihan area perineal, genital, maupun area sekitar anus secara rutin dan hati-hati. Perawatan ini meliputi penggantian popok atau balutan secara berkala, pembersihan area kulit dengan air hangat atau larutan pembersih kulit yang lembut, penggunaan krim pelindung kulit untuk mencegah iritasi, serta inspeksi berkala untuk mendeteksi tanda-tanda infeksi kulit atau iritasi dini. Tujuan utama dari intervensi ini adalah untuk mencegah terjadinya komplikasi kulit yang lebih lanjut, seperti dermatitis atau ulkus akibat paparan cairan tubuh yang berkepanjangan.

Edukasi pasien dan keluarga mengenai pola eliminasi sehat merupakan komponen intervensi keperawatan yang sangat penting, terutama pada keluarga yang memiliki anak dengan gangguan eliminasi kronis atau pasca tindakan operasi korektif. Perawat bertanggung jawab memberikan penjelasan yang jelas mengenai kondisi medis anak, prosedur atau tindakan yang telah atau akan dilakukan, serta perawatan mandiri yang perlu dilakukan di rumah. Edukasi ini mencakup informasi mengenai pola makan yang sehat dan seimbang, asupan cairan yang cukup, serta teknik yang tepat untuk merawat luka operasi atau area kulit yang sensitif. Orang tua juga diajarkan mengenai tanda-tanda komplikasi yang harus diwaspadai serta pentingnya melakukan kontrol rutin ke fasilitas kesehatan. Proses edukasi ini harus disampaikan dengan metode yang mudah dimengerti, dilengkapi demonstrasi dan

praktik langsung untuk memastikan keluarga benar-benar memahami informasi yang diberikan.

Selain itu, dukungan emosional dan psikologis juga menjadi intervensi penting yang harus dilakukan oleh perawat secara terintegrasi dalam proses keperawatan. Kondisi kesehatan yang kompleks pada bayi atau anak dapat menimbulkan kecemasan yang tinggi serta tekanan emosional bagi keluarga, sehingga perawat perlu menyediakan dukungan psikososial melalui komunikasi terapeutik yang empatik, mendengarkan keluhan dan kekhawatiran keluarga secara aktif, serta memberikan dorongan positif untuk membantu keluarga mengatasi stres atau kecemasan. Dukungan ini membantu keluarga lebih percaya diri dan mampu menghadapi tantangan perawatan dengan lebih tenang dan efektif.

Kolaborasi dengan tim multidisiplin juga menjadi bagian penting dalam perencanaan dan intervensi keperawatan yang komprehensif. Perawat perlu bekerja sama secara erat dengan dokter spesialis anak, dokter bedah, ahli gizi, psikolog, maupun pekerja sosial guna memastikan perawatan yang diberikan kepada pasien benar-benar holistik. Perawat memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan komunikasi antar anggota tim, menyampaikan informasi terbaru mengenai perkembangan kondisi pasien, serta memastikan implementasi rekomendasi dari berbagai disiplin ilmu berjalan dengan harmonis. Kolaborasi yang efektif ini bertujuan memastikan seluruh kebutuhan pasien terpenuhi secara maksimal, mempercepat proses pemulihan, dan meminimalkan komplikasi atau efek samping dari kondisi kesehatan yang sedang dialami.

E. Evaluasi Asuhan Keperawatan

Evaluasi asuhan keperawatan merupakan bagian penting dari proses keperawatan, yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa intervensi yang telah diberikan benar-benar efektif dalam mencapai tujuan asuhan. Dalam konteks gangguan eliminasi pada bayi dan anak, evaluasi berfokus pada sejauh mana intervensi yang dilakukan mampu mengatasi masalah eliminasi, memperbaiki gejala klinis yang dialami anak, serta meningkatkan kemampuan keluarga dalam melakukan perawatan mandiri di rumah. Evaluasi tidak hanya sebatas pengamatan sesaat, tetapi mencakup penilaian jangka panjang yang berkelanjutan, untuk memastikan bahwa perbaikan yang dicapai bersifat permanen dan berkelanjutan.

Evaluasi pertama yang sangat penting dilakukan adalah terkait perbaikan pola eliminasi bayi atau anak. Dalam aspek ini, perawat harus secara berkala menilai dan memantau apakah intervensi yang telah diberikan berhasil mengembalikan pola eliminasi menjadi lebih normal dan teratur. Hal ini dapat dinilai dengan beberapa parameter spesifik seperti:

1. Frekuensi eliminasi

Evaluasi dilakukan dengan mencatat secara rutin frekuensi buang air kecil maupun buang air besar pasien. Pola eliminasi yang membaik ditandai dengan frekuensi yang lebih teratur sesuai usia dan kondisi klinis anak. Sebagai contoh, bayi yang sebelumnya mengalami konstipasi kronis akibat penyakit Hirschsprung diharapkan memiliki frekuensi defekasi yang lebih rutin setelah operasi, tanpa mengalami episode konstipasi yang berkepanjangan.

2. Konsistensi dan karakteristik eliminasi

Perawat juga menilai kualitas dari hasil eliminasi, baik tinja maupun urine, untuk memastikan adanya perbaikan nyata. Misalnya, bayi yang sebelumnya mengalami konstipasi parah dengan tinja yang keras dan sulit keluar, setelah perawatan yang efektif, akan mengalami perubahan tinja menjadi lebih lembut dan mudah dikeluarkan tanpa rasa sakit. Demikian pula dengan gangguan urinas, anak yang sebelumnya mengalami retensi urin diharapkan memiliki volume urin normal, tanpa rasa nyeri, dan tidak disertai tanda-tanda obstruksi.

Selanjutnya, evaluasi berfokus pada berkurangnya gejala klinis yang dialami pasien. Gejala-gejala klinis merupakan indikator penting keberhasilan intervensi keperawatan dan medis yang diberikan. Evaluasi gejala klinis mencakup beberapa hal:

1. Evaluasi nyeri

Perawat secara rutin mengevaluasi apakah intervensi manajemen nyeri yang telah diberikan mampu mengurangi atau menghilangkan keluhan nyeri yang dialami pasien. Penilaian ini dilakukan menggunakan skala nyeri yang sesuai usia anak secara periodik, sehingga perubahan nyeri dari waktu ke waktu dapat didokumentasikan secara objektif.

2. Evaluasi infeksi

Perawat juga secara teliti menilai tanda-tanda infeksi, seperti demam, nyeri lokal, perubahan warna atau bau urin dan tinja, serta gejala sistemik seperti penurunan nafsu makan dan letargi. Penurunan atau hilangnya tanda-tanda infeksi menunjukkan keberhasilan intervensi, khususnya pada kasus gangguan eliminasi yang disebabkan atau diperberat oleh infeksi.

3. Evaluasi kondisi kulit dan integritas jaringan

Kondisi kulit sekitar area eliminasi juga perlu dievaluasi secara berkala. Jika perawatan kulit yang diberikan berhasil, kulit pasien akan tampak sehat, tidak ada tanda-tanda kemerahan, iritasi, luka, atau infeksi baru yang berkembang.

Evaluasi yang kedua adalah kemampuan keluarga dalam melakukan perawatan mandiri di rumah. Mengingat bayi dan anak sangat bergantung pada orang tua atau keluarga untuk melanjutkan perawatan di rumah, evaluasi ini menjadi sangat krusial dalam memastikan kesinambungan perawatan di lingkungan rumah tangga. Evaluasi ini mencakup aspek-aspek berikut:

1. Pemahaman keluarga terhadap kondisi anak

Perawat mengevaluasi sejauh mana keluarga telah memahami dengan benar tentang gangguan eliminasi yang dialami anak, termasuk gejala yang harus diwaspadai, komplikasi yang mungkin timbul, serta intervensi mandiri yang harus dilakukan di rumah. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan metode tanya-jawab, demonstrasi, atau observasi langsung terhadap tindakan keluarga.

2. Kemampuan keluarga dalam melakukan perawatan mandiri

Evaluasi ini meliputi kemampuan keluarga dalam merawat anak secara mandiri, termasuk teknik perawatan luka pascaoperasi, manajemen eliminasi (seperti penggunaan kateter urin jika diperlukan, penggantian popok secara tepat, menjaga kebersihan area perineal), serta pemenuhan kebutuhan nutrisi dan cairan anak. Keberhasilan dalam aspek ini terlihat dari keterampilan keluarga yang meningkat, sehingga mereka bisa melakukan tindakan-tindakan tersebut secara benar tanpa supervisi yang intensif dari tenaga kesehatan.

3. Kepercayaan diri keluarga

Evaluasi terhadap aspek psikologis keluarga juga penting untuk menilai apakah keluarga merasa lebih percaya diri dalam menghadapi kondisi anak setelah mendapatkan dukungan edukasi dan psikologis dari perawat. Meningkatnya rasa percaya diri keluarga menjadi indikator penting bahwa keluarga siap secara mental untuk menjalankan perawatan secara mandiri di rumah.

Terakhir, evaluasi harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan agar dapat mengidentifikasi masalah baru yang mungkin muncul selama proses perawatan. Jika ditemukan hasil evaluasi yang kurang optimal atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan, maka perawat harus melakukan revisi terhadap rencana perawatan. Revisi ini dapat mencakup penyesuaian intervensi, modifikasi pendekatan edukasi, serta peningkatan kolaborasi dengan tim multidisiplin guna mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan asuhan keperawatan.

F. Asuhan Perioperatif pada Bayi dan Anak

Asuhan perioperatif pada bayi dan anak merupakan serangkaian tindakan keperawatan yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah prosedur operasi. Tindakan ini bertujuan untuk mempersiapkan pasien secara optimal agar siap menjalani operasi, memantau kondisi pasien secara ketat selama operasi, serta memastikan pemulihan yang cepat, aman, dan efektif setelah operasi dilakukan. Mengingat bayi dan anak memiliki kondisi fisiologis dan psikologis yang berbeda dibandingkan pasien dewasa, asuhan perioperatif pada kelompok usia ini memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati, holistik, dan berorientasi pada kebutuhan unik anak dan keluarganya.

1. Asuhan Preoperasi

Asuhan preoperasi merupakan tahapan awal yang sangat penting karena akan menentukan kesiapan pasien dalam menjalani tindakan operasi. Pada tahap ini,

perawat melakukan beberapa tindakan penting yang harus diperhatikan dengan teliti:

- a. Edukasi Pasien dan Keluarga: Sebelum prosedur operasi dilakukan, perawat wajib memberikan edukasi yang jelas dan komprehensif kepada keluarga pasien mengenai prosedur operasi, tujuan operasi, risiko, serta manfaat yang diharapkan. Penjelasan harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, menggunakan media visual atau demonstrasi jika diperlukan. Edukasi ini bertujuan untuk mengurangi kecemasan, meningkatkan kepatuhan keluarga terhadap rencana perawatan, serta memberikan pemahaman yang baik mengenai peran keluarga dalam perawatan setelah operasi selesai dilakukan.
- b. Puasa Praoperasi: Anak yang akan menjalani operasi diwajibkan menjalani puasa sesuai protokol medis untuk mengurangi risiko aspirasi selama anestesi. Puasa umumnya dilakukan selama 4–6 jam untuk makanan padat dan 2–4 jam untuk cairan jernih, bergantung pada usia anak serta kebijakan rumah sakit. Perawat bertanggung jawab memastikan bahwa orang tua memahami aturan puasa ini dengan baik agar prosedur operasi berjalan aman dan lancar.
- c. Pemeriksaan Praoperasi: Persiapan fisik mencakup pemeriksaan laboratorium seperti darah lengkap, pemeriksaan urin, evaluasi fungsi ginjal, serta pemeriksaan pencitraan (USG, sinar-X, atau CT scan) untuk mendapatkan data kondisi anatomi maupun fisiologi yang lebih jelas sebelum tindakan operasi dilakukan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasien dalam kondisi optimal secara fisik dan bahwa risiko komplikasi selama operasi dapat diminimalkan.
- d. Persiapan Psikologis: Pada bayi dan anak, persiapan psikologis juga sangat krusial. Perawat harus menggunakan pendekatan yang empatik untuk mengurangi rasa takut dan kecemasan anak. Hal ini dapat dilakukan melalui teknik bermain terapeutik, distraksi, atau teknik relaksasi sederhana. Memberikan waktu bagi keluarga untuk mendampingi anak juga dapat membantu mengurangi kecemasan anak selama masa persiapan operasi.

2. Asuhan Intraoperasi

Pada tahap intraoperasi, asuhan keperawatan berfokus pada pemantauan dan pengawasan yang intensif terhadap kondisi vital pasien selama tindakan operasi berlangsung. Tahap ini melibatkan beberapa aspek penting, di antaranya adalah:

- a. Pemantauan Status Vital: Perawat yang bertugas di ruang operasi harus secara ketat memantau tanda-tanda vital pasien, yang mencakup denyut jantung, tekanan darah, suhu tubuh, pernapasan, dan saturasi oksigen secara kontinu. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini apabila terjadi perubahan status vital yang dapat mengancam keselamatan pasien selama prosedur bedah berlangsung.

- b. Pemeliharaan Suhu Tubuh Pasien: Bayi dan anak memiliki risiko tinggi mengalami hipotermia selama operasi akibat paparan suhu ruangan operasi yang dingin. Oleh karena itu, perawat harus aktif menjaga suhu tubuh pasien agar tetap dalam kisaran normal dengan menggunakan selimut hangat, pengatur suhu ruangan, atau alat penghangat khusus.
- c. Pencegahan Cedera Operasi: Perawat bertanggung jawab memastikan posisi pasien selama operasi tepat dan aman, serta terhindar dari risiko cedera akibat alat-alat operasi yang digunakan. Hal ini meliputi penggunaan padding yang tepat pada titik-titik tekanan tubuh pasien dan memastikan bahwa alat-alat medis terpasang dengan benar.

3. Asuhan Pascaoperasi

Setelah operasi selesai, asuhan pascaoperasi diberikan untuk mendukung proses pemulihan pasien secara efektif dan optimal. Fokus utama dalam tahap ini adalah:

- a. Manajemen Nyeri: Pasien pascaoperasi sering mengalami nyeri akut akibat luka operasi maupun manipulasi jaringan selama prosedur. Perawat harus secara rutin melakukan penilaian nyeri dengan menggunakan skala nyeri yang sesuai dengan usia anak, memberikan analgesik sesuai instruksi dokter, serta menerapkan intervensi nonfarmakologis seperti distraksi, relaksasi, atau sentuhan terapeutik untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan kenyamanan pasien.
- b. Pencegahan Infeksi: Risiko infeksi merupakan perhatian utama setelah operasi, terutama pada luka operasi atau prosedur invasif lainnya seperti kateterisasi. Perawat wajib menjaga kebersihan luka operasi dengan teknik aseptik, mengganti balutan secara teratur sesuai prosedur, memantau tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, nyeri, bengkak, serta demam. Kebersihan personal pasien juga harus dijaga secara ketat untuk mencegah infeksi sekunder yang dapat memperlambat proses penyembuhan.
- c. Pemulihan Fungsi Eliminasi: Setelah operasi yang berhubungan dengan sistem pencernaan atau kemih, perawat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa fungsi eliminasi pasien pulih secara optimal. Hal ini mencakup pengawasan ketat terhadap pola eliminasi urin dan tinja, memonitor tanda-tanda retensi urin atau konstipasi, serta memberikan stimulasi yang tepat untuk mempercepat pemulihan fungsi organ eliminasi. Perawat juga harus memastikan bahwa hidrasi pasien terjaga dengan baik guna mempermudah pemulihan fungsi eliminasi tersebut.
- d. Dukungan Emosional dan Edukasi Pascaoperasi: Setelah operasi, keluarga mungkin masih memiliki kecemasan atau kekhawatiran terkait kondisi pasien. Oleh karena itu, perawat harus memberikan dukungan emosional secara kontinu serta edukasi yang berkelanjutan kepada keluarga mengenai

perawatan di rumah, tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai, serta pentingnya kontrol rutin ke fasilitas kesehatan.

- e. Kolaborasi Multidisiplin: Perawat wajib melakukan koordinasi dan kolaborasi yang erat dengan dokter bedah, dokter anak, ahli gizi, serta tenaga kesehatan lainnya yang terlibat dalam perawatan pasien. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek kebutuhan pasien terpenuhi secara holistik dan terintegrasi.

G. Latihan Soal

Soal 1

Seorang bayi laki-laki usia 3 bulan dibawa ke klinik dengan keluhan sulit buang air besar sejak lahir. Ibunya mengeluhkan bayi sering menangis saat mencoba buang air besar dan perutnya terlihat semakin membesar. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan distensi abdomen yang jelas, peristaltik usus melemah, dan terdapat riwayat keluarnya mekonium lebih dari 48 jam setelah kelahiran. Diagnosis medis yang mungkin pada kasus ini adalah...

A. Atresia ani

B. Penyakit Hirschsprung (Kunci Jawaban)

C. Refluks vesikoureteral

D. Hipospadia

E. Megakolon fungsional

Rasional:

A: Tidak tepat karena pada atresia ani bayi tidak memiliki lubang anus, biasanya langsung diketahui saat lahir.

B (Benar): Gejala Hirschsprung khas adalah konstipasi kronis, distensi abdomen, serta terlambat keluarnya mekonium.

C: Refluks vesikoureteral lebih terkait gangguan urinasi dan infeksi saluran kemih berulang.

D: Hipospadia merupakan kelainan anatomi uretra, tidak menyebabkan konstipasi atau distensi abdomen.

E: Megakolon fungsional biasanya terjadi pada anak yang lebih besar akibat pola defekasi yang tidak teratur.

Soal 2

Seorang anak perempuan usia 5 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan demam berulang, nyeri saat buang air kecil, dan sering mengalami infeksi saluran kemih. Hasil pemeriksaan penunjang menunjukkan adanya aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter dan ginjal. Berdasarkan gejala tersebut, masalah utama yang dialami anak ini adalah...

A. Atresia ani

B. Penyakit Hirschsprung

C. Refluks vesikoureteral (Kunci Jawaban)

D. Infeksi gastroenteritis

E. Hipospadia

Rasional:

A: Tidak tepat karena atresia ani menyebabkan gangguan eliminasi tinja, bukan urin.

B: Penyakit Hirschsprung terkait gangguan eliminasi tinja kronis, bukan infeksi saluran kemih.

C (Benar): Gejala yang muncul, yaitu demam berulang dan infeksi saluran kemih, merupakan ciri khas refluks vesikoureteral.

D: Gastroenteritis umumnya gejala gastrointestinal seperti muntah, diare, bukan gangguan urinasi.

E: Hipospadia adalah kelainan posisi lubang uretra, tidak menyebabkan infeksi saluran kemih berulang secara khas.

Soal 3

Seorang bayi laki-laki usia 7 hari dibawa ke rumah sakit karena tidak pernah buang air besar sejak lahir, disertai muntah hijau dan perut kembung. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tidak ditemukan lubang anus. Diagnosis medis yang paling tepat adalah...

A. Hipospadia

B. Atresia ani (Kunci Jawaban)

C. Penyakit Hirschsprung

D. Ileus paralitik

E. Megakolon toksik

Rasional:

A: Tidak tepat karena hipospadia berhubungan dengan posisi uretra, bukan anus.

B (Benar): Atresia ani adalah kelainan bawaan tanpa lubang anus yang ditandai dengan distensi abdomen dan tidak ada defekasi sejak lahir.

C: Hirschsprung biasanya bayi memiliki lubang anus normal tetapi ada kesulitan defekasi kronis.

D: Ileus paralitik biasanya disebabkan oleh gangguan fungsional usus sementara, bukan kelainan anatomis sejak lahir.

E: Megakolon toksik terjadi sebagai komplikasi inflamasi berat usus, tidak sesuai dengan bayi baru lahir tanpa anus.

Soal 4

Seorang bayi laki-laki usia 8 bulan akan menjalani operasi koreksi hipospadia. Dalam perencanaan asuhan perioperatif, tindakan prioritas yang perlu dilakukan perawat sebelum operasi adalah...

A. Memastikan bayi puasa sesuai protokol medis (Kunci Jawaban)

- B. Mengajarkan latihan defekasi pada bayi
- C. Mengatur posisi tidur terlentang bayi secara rutin
- D. Melakukan perawatan luka operasi
- E. Menyiapkan obat analgesik pascaoperasi

Rasional:

- A (Benar): Puasa penting untuk mencegah aspirasi selama anestesi dan merupakan tindakan prioritas sebelum operasi.
- B: Latihan defekasi tidak relevan untuk operasi hipospadia.
- C: Posisi tidur penting, tetapi bukan prioritas utama sebelum operasi.
- D: Perawatan luka operasi dilakukan setelah operasi.
- E: Persiapan analgesik merupakan tindakan penting tetapi dilaksanakan setelah operasi selesai.

Soal 5

Seorang anak usia 4 tahun pascaoperasi koreksi refluks vesikoureteral dirawat di ruang rawat inap. Dalam evaluasi keperawatan, indikator utama keberhasilan perawatan terkait fungsi eliminasi urin adalah...

- A. Berkurangnya nyeri abdomen
- B. Pola buang air besar teratur

C. Tidak ada demam atau tanda infeksi saluran kemih (Kunci Jawaban)

- D. Peningkatan nafsu makan
- E. Kulit perineal bebas iritasi

Rasional:

- A: Berkurangnya nyeri abdomen bukan indikator utama dalam fungsi eliminasi urin pasca koreksi refluks vesikoureteral.
- B: Pola buang air besar tidak langsung terkait dengan masalah urin pada refluks vesikoureteral.
- C (Benar): Tidak adanya demam atau tanda infeksi merupakan indikator utama bahwa refluks sudah terkoreksi baik.
- D: Nafsu makan meningkat penting, namun bukan indikator utama keberhasilan fungsi eliminasi urin.
- E: Kulit perineal bebas iritasi baik, tetapi tidak secara langsung menunjukkan keberhasilan koreksi refluks.

H. Rangkuman Materi

Gangguan eliminasi pada bayi dan anak merupakan kondisi yang kompleks serta dapat disebabkan oleh berbagai faktor anatomi, fungsional, maupun infeksi. Kondisi ini memerlukan pemahaman komprehensif dari tenaga kesehatan, khususnya perawat anak, karena gangguan eliminasi secara signifikan dapat

memengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan kualitas hidup anak. Beberapa kelainan kongenital yang sering ditemukan adalah penyakit Hirschsprung, atresia ani, refluks vesikoureteral, dan hipospadia, yang masing-masing memerlukan intervensi khusus serta perawatan perioperatif yang intensif.

Proses pengkajian keperawatan merupakan langkah awal penting dalam menentukan intervensi yang tepat. Pengkajian dilakukan secara menyeluruh, mencakup anamnesis mendalam, observasi klinis, pemeriksaan penunjang seperti ultrasonografi, pemeriksaan laboratorium, pencitraan, serta perhatian terhadap aspek psikologis pasien dan keluarganya. Hasil pengkajian menjadi dasar penentuan diagnosa keperawatan utama yang meliputi gangguan eliminasi urin dan feses, risiko infeksi, nyeri akut, ansietas, serta risiko gangguan pertumbuhan dan perkembangan.

Perencanaan dan intervensi keperawatan disusun secara holistik, mencakup manajemen nyeri yang adekuat, pemantauan ketat terhadap pola eliminasi, perawatan kulit, edukasi pasien dan keluarga, dukungan psikologis serta emosional, serta kolaborasi multidisiplin dengan tenaga kesehatan lainnya. Perawat memegang peran penting dalam mengoordinasikan komunikasi antar anggota tim multidisiplin guna memastikan perawatan optimal yang terintegrasi.

Evaluasi asuhan keperawatan dilakukan secara kontinu dan sistematis, dengan fokus pada perbaikan pola eliminasi, berkurangnya gejala klinis seperti nyeri dan infeksi, serta meningkatnya kemampuan keluarga dalam melakukan perawatan mandiri di rumah. Evaluasi ini juga menilai kondisi kulit, integritas jaringan, dan perkembangan psikososial pasien serta keluarga.

Dalam konteks asuhan perioperatif, perhatian khusus diberikan mulai dari tahap praoperasi dengan persiapan fisik, edukasi, puasa, pemeriksaan penunjang, hingga dukungan psikologis; dilanjutkan tahap intraoperasi dengan pemantauan status vital secara ketat; serta diakhiri tahap pascaoperasi yang berfokus pada manajemen nyeri, pencegahan infeksi, pemulihan fungsi eliminasi, dukungan emosional, serta edukasi lanjutan kepada keluarga. Dengan pendekatan yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, perawat mampu memberikan asuhan keperawatan yang efektif dalam mengatasi gangguan eliminasi pada bayi dan anak, sehingga tercapai kualitas hidup optimal bagi pasien dan keluarganya.

I. Glosarium

1. Atresia ani

Kelainan kongenital di mana bayi lahir tanpa lubang anus atau memiliki lubang anus yang tidak sempurna, menyebabkan ketidakmampuan bayi untuk buang air besar secara normal.

2. Diagnosa keperawatan

Kesimpulan yang diambil perawat berdasarkan analisis data dari hasil pengkajian pasien untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang spesifik, seperti gangguan eliminasi, nyeri, ansietas, atau risiko infeksi.

3. Eliminasi

Proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, berupa urine maupun tinja.

4. Gangguan eliminasi

Kondisi patologis yang menyebabkan ketidakmampuan atau kesulitan dalam mengeluarkan zat sisa metabolisme, seperti urine atau tinja, secara normal.

5. Hipospadia

Kelainan bawaan pada bayi laki-laki di mana letak lubang uretra tidak berada di ujung penis tetapi di sisi bawah atau samping penis, mengganggu proses eliminasi urine dan berpotensi menimbulkan dampak psikososial.

6. Infeksi saluran kemih (ISK)

Infeksi yang terjadi di sepanjang saluran kemih, dari ginjal hingga uretra, yang bisa disebabkan oleh gangguan eliminasi seperti refluks vesikoureteral.

7. Kelainan kongenital

Kelainan yang sudah ada sejak bayi dilahirkan akibat gangguan selama perkembangan dalam kandungan.

8. Manajemen nyeri

Serangkaian tindakan intervensi farmakologis maupun nonfarmakologis yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit yang dialami pasien.

9. Megakolon

Pembesaran abnormal pada usus besar yang sering kali disebabkan oleh gangguan kronis, seperti penyakit Hirschsprung, sehingga terjadi penumpukan tinja.

10. Penyakit Hirschsprung

Kelainan kongenital akibat tidak berkembangnya saraf pada sebagian usus besar, menyebabkan gangguan pergerakan usus (peristaltik) dan konstipasi kronis.

11. Pengkajian keperawatan

Proses sistematis dalam mengumpulkan informasi melalui anamnesis, observasi klinis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang untuk menilai kondisi kesehatan pasien secara menyeluruh.

12. Perawatan perioperatif

Tindakan keperawatan yang dilakukan sebelum (preoperasi), selama (intraoperasi), dan setelah (pascaoperasi) tindakan bedah, mencakup persiapan pasien, pemantauan, dan upaya pemulihan pascaoperasi.

13. Refluks vesikoureteral

Kondisi patologis di mana terjadi aliran balik urine dari kandung kemih menuju ureter bahkan ke ginjal, meningkatkan risiko infeksi saluran kemih dan kerusakan ginjal.

14. Retensi urin

Ketidakmampuan untuk mengosongkan kandung kemih secara penuh atau optimal, menyebabkan rasa tidak nyaman, nyeri, dan potensi komplikasi seperti infeksi saluran kemih.

15. Sistogram miksi

Pemeriksaan pencitraan radiologis dengan memasukkan zat kontras untuk mengamati aliran urine dari kandung kemih menuju ureter dan ginjal, terutama digunakan dalam diagnosis refluks vesikoureteral.

16. Ultrasonografi (USG)

Pemeriksaan pencitraan menggunakan gelombang suara yang bersifat non-invasif untuk mendeteksi kelainan anatomis pada organ tubuh seperti sistem kemih dan pencernaan.

17. Distensi abdomen

Kondisi di mana perut terlihat membesar akibat penumpukan gas, cairan, atau feses, sering ditemui pada bayi atau anak dengan gangguan eliminasi kronis.

18. Evaluasi keperawatan

Tahapan dalam proses keperawatan yang dilakukan secara kontinu untuk menilai efektivitas dari intervensi keperawatan yang telah diberikan, termasuk menilai pola eliminasi, nyeri, infeksi, dan kemampuan perawatan mandiri keluarga.

19. Puasa praoperasi

Protokol persiapan sebelum operasi untuk mengurangi risiko aspirasi selama anestesi, dengan membatasi asupan makanan dan minuman dalam jangka waktu tertentu sebelum operasi dilakukan.

20. Dukungan psikososial

Bantuan berupa dukungan emosional, edukasi, dan komunikasi terapeutik dari tenaga kesehatan kepada pasien dan keluarga untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap kondisi kesehatan yang dialami.

J. Daftar Pustaka

- Alatas, H., & Tambunan, T. (2019). Buku ajar bedah anak: Prinsip dasar dan praktik klinis. Jakarta: Badan Penerbit FKUI.
- Ball, J. W., Bindler, R. C., & Cowen, K. J. (2021). Child health nursing: Partnering with children and families (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Berman, A., Snyder, S., & Frandsen, G. (2020). Fundamentals of nursing: Concepts, process, and practice (11th ed.). Boston: Pearson.
- Burns, C. E., Dunn, A. M., Brady, M. A., Starr, N. B., & Blosser, C. G. (2017). Pediatric primary care (6th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.
- Hockenberry, M. J., Wilson, D., & Rodgers, C. C. (2021). Wong's nursing care of infants and children (12th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.

- Potts, N. L., & Mandleco, B. L. (2018). *Pediatric nursing: Caring for children and their families* (4th ed.). Clifton Park, NY: Delmar Cengage Learning.
- Ricci, S. S., Kyle, T., & Carman, S. (2021). *Maternity and pediatric nursing* (4th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer.
- Sastroasmoro, S., & Ismael, S. (2021). *Dasar-dasar metodologi penelitian klinis* (5th ed.). Jakarta: Sagung Seto.
- Suryanto, E., & Hartati, Y. S. (2019). *Asuhan keperawatan anak dengan gangguan sistem gastrointestinal dan sistem perkemihan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wong, D. L., Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2019). *Wong's essentials of pediatric nursing* (11th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.

BAB 6

PROSEDUR SCREENING TUMBUH KEMBANG PADA ANAK

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa mampu memberikan pelayanan keperawatan anak secara profesional dengan menerapkan konsep tumbuh kembang, deteksi dini gangguan tumbuh kembang, dan melakukan prosedur screening yang tepat sesuai usia dan standar keperawatan anak.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prosedur screening tumbuh kembang pada anak, serta mampu melakukan pemeriksaan screening secara sistematis menggunakan instrumen yang tepat untuk mendeteksi dini adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dasar tumbuh kembang anak dan pentingnya deteksi dini.
- Mengidentifikasi instrumen atau alat ukur yang digunakan dalam prosedur screening tumbuh kembang anak.
- Menjelaskan langkah-langkah prosedur screening tumbuh kembang secara sistematis.
- Melakukan interpretasi hasil pemeriksaan screening tumbuh kembang secara tepat.
- Merumuskan tindakan lanjutan berdasarkan hasil screening tumbuh kembang anak.

Pendahuluan

Tumbuh kembang merupakan aspek fundamental dalam kehidupan anak yang menentukan kualitas hidupnya di masa depan. Tumbuh kembang anak mencakup aspek fisik, psikologis, emosional, sosial, dan kognitif. Setiap anak memiliki pola tumbuh kembang yang unik namun mengikuti pola umum yang terstandarisasi sesuai usia. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan, terutama perawat anak, untuk melakukan screening secara berkala guna mendeteksi dini adanya gangguan atau penyimpangan pada tumbuh kembang anak. Deteksi dini ini memungkinkan intervensi dini yang optimal sehingga anak dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal sesuai potensinya.

Screening tumbuh kembang adalah suatu prosedur penilaian secara sistematis menggunakan instrumen atau alat ukur yang telah divalidasi secara ilmiah untuk menilai apakah perkembangan anak sesuai dengan tahapan usianya atau mengalami keterlambatan yang membutuhkan intervensi lebih lanjut. Prosedur ini melibatkan observasi, wawancara dengan orang tua atau pengasuh, serta pemeriksaan langsung terhadap anak.

A. Konsep Dasar Screening Tumbuh Kembang Anak

Konsep dasar screening tumbuh kembang anak merupakan suatu pendekatan penting yang digunakan dalam pelayanan kesehatan anak untuk memantau dan mengevaluasi apakah pertumbuhan fisik, motorik, kognitif, bahasa, serta perkembangan sosio-emosional anak berlangsung secara optimal dan sesuai dengan standar usia anak tersebut. Dalam praktiknya, screening tumbuh kembang bukan hanya sekadar proses pengukuran dan pencatatan data, tetapi lebih merupakan suatu mekanisme terintegrasi yang berfungsi untuk mengidentifikasi secara dini kemungkinan adanya gangguan atau hambatan yang berpotensi mempengaruhi kualitas hidup anak di masa depan.

Pertumbuhan fisik menjadi salah satu indikator utama dalam screening tumbuh kembang, yang mencakup berbagai aspek seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan indeks massa tubuh. Pertumbuhan fisik ini secara langsung mencerminkan status kesehatan umum seorang anak dan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi nutrisi serta potensi adanya masalah medis tertentu seperti gangguan gizi, kelainan hormonal, atau penyakit kronis lainnya.

Selain pertumbuhan fisik, kemampuan motorik juga merupakan aspek penting yang dinilai dalam screening ini. Motorik terbagi atas dua jenis yaitu motorik kasar dan motorik halus. Kemampuan motorik kasar melibatkan gerakan besar yang menggunakan kelompok otot besar, seperti berjalan, berlari, melompat, atau naik turun tangga, sedangkan motorik halus mencakup keterampilan yang lebih halus seperti memegang alat tulis, menumpuk balok, atau mengancingkan baju. Evaluasi terhadap kedua jenis motorik ini sangat penting untuk mendeteksi gangguan neurologis, kelemahan otot, ataupun keterlambatan koordinasi yang bila tidak segera ditangani bisa berdampak pada aktivitas kehidupan sehari-hari anak.

Selanjutnya, perkembangan kognitif anak juga dipantau secara rutin dalam proses screening. Perkembangan kognitif mencakup berbagai aspek seperti kemampuan berpikir, memecahkan masalah, mengingat, mengenali objek, dan memahami konsep-konsep sederhana sesuai usia. Pentingnya memantau perkembangan kognitif ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak memiliki potensi akademik yang optimal dan mampu mengikuti berbagai tahapan pendidikan formal di kemudian hari.

Kemampuan bahasa merupakan aspek lain yang tidak kalah penting dalam screening tumbuh kembang. Kemampuan bahasa mencakup ekspresi verbal maupun non-verbal, pemahaman terhadap perintah atau instruksi, serta

kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain di sekitarnya. Hambatan dalam aspek ini bisa mengindikasikan adanya gangguan seperti gangguan pendengaran, keterlambatan bicara, atau kondisi seperti autisme yang harus diidentifikasi sejak dini agar intervensi terapi wicara atau pendengaran dapat segera diberikan.

Terakhir, aspek perkembangan sosio-emosional anak juga diperhatikan secara mendalam dalam screening tumbuh kembang. Perkembangan sosio-emosional melibatkan kemampuan anak untuk bersosialisasi, mengekspresikan emosi dengan tepat, berinteraksi positif dengan lingkungan sekitarnya, serta membangun hubungan yang sehat dengan teman sebaya dan orang dewasa. Anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan sosio-emosional berisiko mengalami gangguan perilaku, kesulitan adaptasi, serta tantangan psikososial lainnya yang bisa berdampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis anak.

Tujuan utama dari pelaksanaan screening tumbuh kembang anak ini adalah untuk secara dini mendeteksi adanya potensi masalah atau hambatan pada salah satu atau beberapa aspek tersebut. Dengan deteksi dini, intervensi yang tepat dan efektif dapat segera dilakukan, sehingga mencegah atau setidaknya meminimalkan dampak negatif jangka panjang yang mungkin terjadi akibat keterlambatan atau gangguan tumbuh kembang tersebut. Melalui pelaksanaan screening yang sistematis, berkelanjutan, dan terstandarisasi, tenaga kesehatan dapat memberikan rekomendasi intervensi yang sesuai, merujuk anak ke spesialis yang tepat, serta melakukan pendampingan kepada keluarga untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan demikian, screening tumbuh kembang menjadi suatu prosedur yang esensial untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan terbaik dalam mencapai potensi maksimalnya di masa depan.

B. Instrumen atau Alat Ukur yang Digunakan

Instrumen atau alat ukur dalam screening tumbuh kembang anak merupakan alat bantu terstandarisasi yang memiliki peran penting untuk menentukan apakah seorang anak berkembang secara optimal atau mengalami keterlambatan atau gangguan pada berbagai aspek tumbuh kembangnya. Beberapa instrumen yang umum digunakan antara lain Kartu Menuju Sehat (KMS), Denver Developmental Screening Test (DDST), Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT), serta Ages and Stages Questionnaire (ASQ).

Beberapa instrumen yang umum digunakan dalam screening tumbuh kembang anak antara lain:

1. Kartu Menuju Sehat (KMS)

Kartu Menuju Sehat (KMS) merupakan instrumen pemantauan kesehatan yang paling dikenal secara luas di Indonesia. KMS terutama digunakan untuk mengamati dan mencatat pertumbuhan fisik anak secara berkala melalui indikator seperti berat badan dan tinggi badan yang disesuaikan dengan usia anak. Penggunaan KMS sangat sederhana, yakni dengan mencatat berat badan dan tinggi badan anak secara periodik lalu hasil pengukuran tersebut dimasukkan ke dalam grafik yang tersedia dalam kartu tersebut.

Grafik pada KMS memiliki beberapa zona atau batasan yang menunjukkan apakah pertumbuhan anak masih dalam batas normal, di atas normal (kelebihan berat badan atau obesitas), atau justru di bawah normal (kurang gizi atau stunting). Dengan demikian, KMS berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap masalah gizi atau gangguan pertumbuhan, yang memungkinkan tenaga kesehatan dan orang tua segera mengambil langkah intervensi atau konsultasi ke tenaga medis lebih lanjut jika ditemukan adanya pertumbuhan yang tidak optimal.

2. Denver Developmental Screening Test (DDST)

Denver Developmental Screening Test (DDST) merupakan instrumen screening yang sangat populer dalam menilai berbagai aspek perkembangan anak dari usia 0 hingga 6 tahun. DDST ini secara spesifik dirancang untuk mengevaluasi empat aspek penting, yakni personal-sosial, motorik halus, bahasa, dan motorik kasar.

- a. Aspek personal-sosial: aspek ini mengevaluasi kemampuan anak dalam berinteraksi secara sosial dan emosional, seperti tersenyum secara spontan, meniru perilaku sosial, serta bermain bersama teman sebaya.
- b. Motorik halus: aspek ini menilai keterampilan anak dalam melakukan gerakan-gerakan kecil dan presisi seperti mengambil benda kecil, menulis, menggambar, atau membangun menara dengan balok.
- c. Bahasa: aspek ini berfokus pada kemampuan anak dalam memahami instruksi, mengucapkan kata-kata atau kalimat, serta komunikasi secara verbal maupun nonverbal.
- d. Motorik kasar: aspek ini mengevaluasi kemampuan anak melakukan gerakan-gerakan yang melibatkan otot besar seperti berjalan, berlari, melompat, berdiri dengan satu kaki, atau naik turun tangga secara mandiri.

Penggunaan DDST dilakukan dengan observasi langsung oleh tenaga kesehatan terhadap aktivitas anak, dan hasilnya dibandingkan dengan standar perkembangan normal sesuai usia anak tersebut. Jika ditemukan keterlambatan

dalam satu atau lebih aspek tersebut, maka anak perlu segera dirujuk untuk mendapatkan intervensi yang sesuai.

3. Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT)

Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) adalah instrumen yang secara spesifik dirancang untuk mendeteksi secara dini kemungkinan gangguan spektrum autisme pada anak-anak usia balita, biasanya dalam rentang usia 16 hingga 30 bulan. Alat ini berupa serangkaian pertanyaan yang secara spesifik mengarah pada perilaku yang khas ditunjukkan oleh anak yang berpotensi mengalami autisme, seperti minimnya interaksi sosial, kurangnya kontak mata, pola perilaku yang repetitif, serta respons yang tidak lazim terhadap rangsangan sensorik.

Pertanyaan pada M-CHAT biasanya diisi oleh orang tua atau pengasuh anak yang paling mengenal perilaku keseharian anak. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan dihitung dan diklasifikasikan untuk menentukan apakah anak termasuk dalam kategori risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi terhadap autisme. Jika hasilnya menunjukkan risiko sedang atau tinggi, anak tersebut harus segera menjalani pemeriksaan lanjutan oleh spesialis tumbuh kembang anak atau psikolog untuk evaluasi lebih mendalam serta intervensi dini.

4. Ages and Stages Questionnaire (ASQ)

Ages and Stages Questionnaire (ASQ) merupakan instrumen skrining yang berbentuk kuesioner khusus yang dirancang untuk diisi oleh orang tua atau pengasuh anak. ASQ mengevaluasi perkembangan anak dalam berbagai domain utama seperti komunikasi, kemampuan motorik kasar dan halus, pemecahan masalah, serta perkembangan sosio-emosional.

- a. Komunikasi: menilai kemampuan anak dalam berbicara, mendengar, serta memahami bahasa.
- b. Motorik kasar: mengukur kemampuan anak dalam melakukan gerakan besar seperti berjalan, berlari, dan melompat.
- c. Motorik halus: mengevaluasi kemampuan anak dalam melakukan aktivitas yang membutuhkan koordinasi halus, seperti menggambar, mengambil benda kecil, atau memasukkan benda ke lubang.
- d. Pemecahan masalah (kognitif): menilai kemampuan berpikir dan menyelesaikan masalah, seperti mengenali bentuk, warna, dan konsep dasar lainnya.
- e. Sosio-emosional: mengukur kemampuan anak dalam berinteraksi secara sosial, mengelola emosi, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Kelebihan utama dari ASQ adalah melibatkan peran aktif orang tua dalam mengobservasi dan mengisi jawaban mengenai perilaku sehari-hari anak mereka, sehingga hasilnya lebih mencerminkan kondisi nyata perkembangan anak di lingkungan rumah. ASQ memberikan skala nilai yang jelas untuk menentukan apakah anak berada dalam batas perkembangan normal atau menunjukkan potensi keterlambatan yang perlu segera mendapat perhatian lebih lanjut dari tenaga kesehatan profesional.

C. Langkah-langkah Prosedur Screening Tumbuh Kembang

Langkah-langkah prosedur screening tumbuh kembang anak merupakan tahapan yang sistematis dan terorganisir untuk mengevaluasi serta memastikan bahwa tumbuh kembang anak berjalan optimal. Prosedur ini bertujuan mendeteksi sedini mungkin adanya gangguan atau hambatan perkembangan sehingga dapat segera dilakukan intervensi yang tepat.

1. Persiapan

Persiapan merupakan tahap awal yang penting untuk menjamin kelancaran proses screening.

- a. Menyiapkan alat ukur yang sesuai dengan usia anak.

Pada tahap ini, tenaga kesehatan perlu memastikan bahwa semua instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan screening telah tersedia dan sesuai dengan kelompok usia anak. Alat ukur ini meliputi timbangan, meteran untuk tinggi badan, pita ukur lingkaran kepala, serta alat-alat khusus seperti kartu KMS, DDST kit, lembar M-CHAT, atau kuesioner ASQ yang sesuai dengan usia anak.

- b. Memastikan lingkungan nyaman untuk anak dan orang tua.

Kenyamanan lingkungan sangat penting agar anak merasa aman dan tidak cemas selama proses screening berlangsung. Lingkungan yang nyaman mencakup ruangan yang tenang, bersih, aman, serta dilengkapi mainan atau alat bantu visual untuk memudahkan anak merasa rileks. Selain itu, tenaga kesehatan juga harus menciptakan suasana yang ramah dan penuh empati kepada orang tua atau pengasuh agar komunikasi berjalan lancar.

2. Pengumpulan Data

Setelah persiapan matang dilakukan, langkah selanjutnya adalah pengumpulan data yang menjadi dasar proses screening.

- a. Wawancara mendalam dengan orang tua atau pengasuh terkait riwayat perkembangan anak.

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi detail mengenai riwayat kesehatan, pola perkembangan anak dari waktu ke waktu, pola makan, riwayat imunisasi, riwayat penyakit yang pernah diderita, serta perilaku dan interaksi

sosial anak sehari-hari. Data ini membantu tenaga kesehatan dalam memahami konteks tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

b. Observasi langsung terhadap aktivitas dan interaksi anak.

Observasi langsung bertujuan melihat secara objektif bagaimana perilaku anak dalam situasi nyata. Aktivitas yang diamati antara lain interaksi anak dengan lingkungan sekitar, kemampuan bermain anak, keterampilan sosial anak seperti kontak mata, respon terhadap instruksi sederhana, serta aktivitas motorik yang dapat mencerminkan kondisi perkembangan anak secara nyata.

3. Pelaksanaan Screening

Pada tahap ini, tenaga kesehatan secara aktif melakukan pengukuran dan evaluasi menggunakan instrumen khusus.

a. Melakukan pemeriksaan fisik (berat badan, tinggi badan, lingkar kepala).

Pemeriksaan fisik merupakan dasar penting dalam screening. Berat badan diukur menggunakan timbangan yang sudah dikalibrasi, tinggi badan diukur dengan meteran atau alat ukur khusus, serta lingkar kepala yang sangat penting dalam menentukan perkembangan otak dan neurologis anak. Data ini selanjutnya dicatat dalam grafik KMS atau grafik pertumbuhan lain yang sesuai.

b. Melakukan penilaian menggunakan instrumen seperti DDST, M-CHAT, atau ASQ.

Penilaian dilakukan dengan memilih instrumen yang tepat berdasarkan usia anak dan aspek perkembangan yang ingin dipantau. Misalnya, DDST untuk mengevaluasi berbagai aspek umum seperti motorik kasar dan halus, bahasa, serta personal-sosial; M-CHAT untuk deteksi dini autisme; atau ASQ untuk evaluasi menyeluruh perkembangan berdasarkan laporan orang tua. Setiap instrumen memiliki prosedur pelaksanaan yang spesifik yang harus diikuti dengan cermat untuk mendapatkan hasil yang akurat.

4. Interpretasi Hasil

Setelah tahap screening selesai, langkah berikutnya adalah interpretasi hasil untuk menentukan kondisi perkembangan anak.

a. Menginterpretasi hasil berdasarkan standar normal yang sesuai dengan usia anak.

Interpretasi hasil dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran atau penilaian terhadap grafik atau skala perkembangan normal sesuai standar internasional atau nasional. Dalam interpretasi ini, tenaga kesehatan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang standar perkembangan normal sehingga bisa secara akurat menentukan posisi anak dalam kurva perkembangan.

- b. Menentukan apakah perkembangan anak normal, meragukan, atau mengalami keterlambatan.

Berdasarkan hasil interpretasi, tenaga kesehatan kemudian mengkategorikan perkembangan anak menjadi tiga kelompok: normal (anak berkembang sesuai dengan usia), meragukan (anak menunjukkan tanda-tanda keterlambatan ringan atau borderline yang perlu pemantauan lebih lanjut), atau mengalami keterlambatan (memerlukan intervensi segera atau rujukan spesialis).

5. Tindak Lanjut

Tahap terakhir ini memastikan hasil screening memberikan manfaat nyata melalui tindakan nyata yang efektif bagi anak dan keluarga.

- a. Memberikan edukasi dan konseling kepada keluarga.

Edukasi yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman orang tua tentang tumbuh kembang anak, memberikan tips praktis untuk mendukung perkembangan anak sehari-hari, serta membangun motivasi orang tua untuk rutin melakukan pemeriksaan lanjutan. Konseling ini juga termasuk bagaimana mengatasi perasaan atau kecemasan yang mungkin dialami orang tua terkait hasil screening.

- b. Merujuk ke layanan kesehatan atau spesialis terkait jika ditemukan masalah perkembangan yang serius.

Jika hasil screening menunjukkan tanda-tanda gangguan serius atau keterlambatan signifikan, tenaga kesehatan segera merujuk anak tersebut ke dokter spesialis tumbuh kembang anak, psikolog anak, dokter spesialis anak, ahli terapi okupasi, atau terapis wicara. Rujukan ini bertujuan agar anak mendapatkan evaluasi yang lebih mendalam dan intervensi yang tepat dan spesifik sesuai dengan kebutuhannya, sehingga dampak jangka panjang dari masalah perkembangan tersebut dapat diminimalkan.

D. Interpretasi Hasil dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Interpretasi hasil screening tumbuh kembang anak adalah proses penting yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, terutama perawat, untuk menilai dan mengidentifikasi kondisi perkembangan anak setelah dilakukan proses screening yang terstandarisasi menggunakan berbagai instrumen. Pada tahap ini, kemampuan klinis dan pemahaman perawat terhadap perkembangan anak secara normal sangat dibutuhkan untuk menentukan apakah anak tersebut mengalami perkembangan yang normal, perkembangan yang meragukan, atau justru menunjukkan tanda-tanda keterlambatan yang memerlukan perhatian khusus serta intervensi segera.

Dalam proses interpretasi ini, terdapat tiga kemungkinan kategori yang dapat diidentifikasi dari hasil screening, yaitu perkembangan normal, meragukan, dan membutuhkan perhatian khusus.

1. Perkembangan Normal

Anak dikatakan memiliki perkembangan normal jika hasil screening menunjukkan bahwa semua indikator tumbuh kembangnya berada pada rentang atau standar yang sesuai dengan usia anak tersebut. Dalam situasi ini, anak menunjukkan perkembangan fisik yang sesuai dengan grafik pertumbuhan standar, memiliki kemampuan motorik kasar dan halus yang optimal, komunikasi dan bahasa berkembang dengan baik, serta memiliki keterampilan sosial dan emosional yang sesuai dengan usianya. Jika hasil screening menunjukkan kondisi ini, maka perawat atau tenaga kesehatan memberikan edukasi kepada keluarga tentang bagaimana menjaga dan meningkatkan tumbuh kembang anak tetap optimal melalui stimulasi rutin di rumah, pola asuh yang positif, serta pemeriksaan berkala.

2. Perkembangan Meragukan (Borderline)

Anak dengan perkembangan meragukan atau borderline adalah mereka yang menunjukkan beberapa tanda keterlambatan ringan atau belum sepenuhnya memenuhi indikator perkembangan yang diharapkan untuk usianya. Anak mungkin berada sedikit di bawah rentang normal dalam satu atau beberapa aspek tertentu, namun masih memerlukan observasi lebih lanjut sebelum dapat ditegakkan diagnosis pasti. Dalam kondisi ini, perawat perlu memberikan perhatian khusus dengan merekomendasikan observasi lanjutan secara teratur, misalnya dalam waktu 1-3 bulan ke depan. Orang tua harus diberikan edukasi khusus tentang stimulasi tambahan, yakni kegiatan yang spesifik dan terarah guna membantu anak mengejar ketertinggalan dalam aspek-aspek yang masih meragukan tersebut, seperti latihan motorik halus, stimulasi bahasa, atau aktivitas yang memperkuat interaksi sosial.

3. Perkembangan Memerlukan Perhatian Khusus (Keterlambatan Jelas)

Kategori ini merujuk pada kondisi anak yang hasil screeningnya menunjukkan jelas adanya keterlambatan yang signifikan dalam satu atau beberapa aspek tumbuh kembangnya. Dalam kasus ini, perawat harus bertindak proaktif dan segera merencanakan intervensi yang tepat dan terkoordinasi. Perawat perlu menjelaskan dengan jelas kepada keluarga mengenai kondisi tersebut, dampaknya jika tidak segera ditangani, serta langkah-langkah intervensi yang dibutuhkan.

Intervensi yang dimaksud bisa berupa:

- a. Stimulasi Tambahan Intensif

Perawat memberikan panduan kepada keluarga tentang aktivitas spesifik yang harus rutin dilakukan di rumah, seperti latihan bicara untuk gangguan bahasa, latihan motorik kasar atau halus yang terstruktur, atau intervensi sosialisasi khusus jika ditemukan keterlambatan dalam aspek sosial.

b. **Konseling Keluarga**

Pada kondisi ini, konseling sangat penting untuk membantu orang tua memahami situasi anak mereka, mengelola perasaan seperti kecemasan atau rasa bersalah yang mungkin dialami, serta memberikan motivasi agar orang tua dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Konseling juga penting untuk membangun kesiapan keluarga dalam menjalankan program intervensi jangka panjang.

c. **Rujukan ke Dokter Spesialis atau Psikolog Anak**

Jika keterlambatan yang ditemukan bersifat kompleks atau serius, seperti kecurigaan gangguan neurologis, autisme, gangguan sensorik, atau keterlambatan signifikan dalam aspek motorik dan bahasa, maka anak harus segera dirujuk ke spesialis terkait. Dokter spesialis anak, ahli tumbuh kembang anak, psikolog anak, ahli terapi wicara, fisioterapis, atau terapis okupasi dapat melakukan evaluasi mendalam serta merancang intervensi spesifik yang terencana dengan baik dan berbasis bukti ilmiah.

Dalam pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut ini, koordinasi dan komunikasi intensif antara perawat, tenaga kesehatan lainnya, keluarga, serta spesialis terkait sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi benar-benar berjalan efektif. Perawat juga bertanggung jawab dalam memastikan adanya evaluasi berkala untuk memantau kemajuan perkembangan anak setelah dilakukan intervensi, serta menyesuaikan strategi intervensi bila diperlukan berdasarkan respons perkembangan anak.

E. Latihan Soal

Soal 1

Seorang anak perempuan usia 2 tahun dibawa oleh ibunya ke posyandu. Hasil pemeriksaan menunjukkan berat badan anak berada jauh di bawah garis merah pada Kartu Menuju Sehat (KMS). Saat dilakukan wawancara, ibu menyatakan anak sulit makan sejak 3 bulan terakhir. Sebagai perawat, tindakan awal apakah yang paling tepat?

- A. Merujuk segera ke dokter spesialis anak
- B. Menyarankan ibu memberikan vitamin
- C. Melakukan konseling pola makan bergizi seimbang

- D. Melakukan stimulasi motorik halus secara rutin
- E. Melakukan evaluasi perkembangan kognitif anak

Kunci jawaban: A

Rasional:

Kondisi anak dengan berat badan jauh di bawah garis merah pada KMS menunjukkan tanda gangguan gizi serius yang membutuhkan penanganan medis segera oleh dokter spesialis anak untuk evaluasi mendalam dan penanganan khusus terkait penyebab dasar serta intervensi nutrisi yang tepat.

Soal 2

Seorang anak laki-laki usia 3 tahun mengalami kesulitan dalam berbicara. Saat pemeriksaan dengan DDST, didapatkan hasil bahwa kemampuan bahasa anak termasuk kategori "gagal". Tindakan yang paling tepat dilakukan perawat adalah?

- A. Memberikan stimulasi bahasa sederhana di rumah saja
- B. Melakukan observasi ulang dalam 6 bulan
- C. Merujuk anak ke terapis wicara
- D. Memberikan multivitamin untuk meningkatkan daya ingat
- E. Melatih anak untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar

Kunci jawaban: C

Rasional:

Anak yang gagal dalam aspek bahasa pada DDST menunjukkan tanda keterlambatan bicara yang signifikan. Intervensi spesifik oleh terapis wicara diperlukan untuk mendukung perkembangan bahasa secara optimal sejak dini.

Soal 3

Seorang anak perempuan usia 18 bulan dibawa ke puskesmas oleh orang tuanya dengan keluhan anak jarang tersenyum, tidak merespons ketika dipanggil namanya, dan cenderung suka melakukan gerakan yang berulang-ulang. Perawat menggunakan instrumen screening M-CHAT dan hasilnya menunjukkan risiko tinggi autisme. Langkah selanjutnya yang paling tepat adalah?

- A. Menyarankan stimulasi umum di rumah terlebih dahulu
- B. Memberikan konseling keluarga saja
- C. Melakukan evaluasi lanjutan dalam 3 bulan
- D. Merujuk anak ke psikolog atau dokter spesialis tumbuh kembang
- E. Mengobservasi interaksi sosial anak di lingkungan bermain

Kunci jawaban: D

Rasional:

Hasil M-CHAT dengan risiko tinggi autisme mengharuskan anak segera mendapat pemeriksaan lanjutan oleh psikolog atau dokter spesialis tumbuh kembang anak agar dapat dilakukan evaluasi mendalam dan intervensi spesifik sedini mungkin.

Soal 4

Seorang anak laki-laki usia 5 tahun mengalami kesulitan ketika diminta menggambar dan memegang pensil dengan benar. Saat dilakukan pemeriksaan dengan DDST, anak menunjukkan keterlambatan signifikan pada aspek motorik halus. Sebagai perawat, tindakan prioritas yang harus dilakukan adalah?

- A. Memberikan edukasi nutrisi seimbang
- B. Melatih kemampuan bahasa anak secara intensif
- C. Memberikan stimulasi motorik halus secara terstruktur
- D. Melakukan observasi rutin tanpa intervensi tambahan
- E. Mengobservasi interaksi sosial anak lebih lanjut

Kunci jawaban: C

Rasional:

Keterlambatan signifikan pada aspek motorik halus memerlukan intervensi stimulasi spesifik yang terstruktur secara rutin untuk membantu anak mengejar ketertinggalan dalam keterampilan motoriknya.

Soal 5

Seorang anak perempuan usia 4 tahun dibawa oleh ibunya ke klinik dengan keluhan sulit berinteraksi dengan teman sebaya, tidak suka berbagi mainan, dan sering tantrum. Berdasarkan hasil ASQ, perkembangan sosio-emosional anak ini berada dalam kategori borderline (meragukan). Tindakan paling tepat yang harus dilakukan perawat adalah?

- A. Memberikan konseling kepada orang tua mengenai stimulasi interaksi sosial
- B. Merujuk langsung ke dokter spesialis anak
- C. Memberikan terapi wicara secara intensif
- D. Melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh kembali
- E. Memberikan multivitamin rutin untuk menenangkan anak

Kunci jawaban: A

Rasional:

Kategori borderline pada perkembangan sosio-emosional mengindikasikan anak membutuhkan stimulasi tambahan dari keluarga di rumah. Oleh karena itu, konseling keluarga untuk memberikan stimulasi interaksi sosial yang tepat adalah langkah prioritas sebelum intervensi spesialis diperlukan.

F. Rangkuman Materi

Screening tumbuh kembang anak merupakan suatu pendekatan sistematis dan terstruktur yang digunakan dalam pelayanan kesehatan untuk memantau berbagai aspek penting dalam perkembangan anak, meliputi pertumbuhan fisik, motorik kasar dan halus, kemampuan kognitif, perkembangan bahasa, serta kemampuan sosio-emosional. Prosedur ini tidak sebatas pengukuran atau pencatatan data semata, tetapi merupakan mekanisme yang terintegrasi untuk mengidentifikasi secara dini kemungkinan adanya gangguan atau hambatan perkembangan yang dapat berdampak pada kualitas hidup anak di masa depan.

Penggunaan instrumen terstandarisasi seperti Kartu Menuju Sehat (KMS), Denver Developmental Screening Test (DDST), Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT), dan Ages and Stages Questionnaire (ASQ) merupakan komponen penting dalam proses screening. Masing-masing instrumen ini memiliki fokus khusus, mulai dari pemantauan pertumbuhan fisik hingga evaluasi spesifik terhadap aspek personal-sosial, motorik, bahasa, serta gejala awal autisme. Pemilihan dan penerapan instrumen yang tepat sesuai usia dan kondisi anak sangat menentukan akurasi hasil screening.

Proses screening yang komprehensif ini meliputi persiapan alat dan lingkungan, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung terhadap anak, pelaksanaan pemeriksaan fisik serta penilaian dengan instrumen khusus, hingga interpretasi hasil yang tepat sesuai dengan standar perkembangan normal. Berdasarkan interpretasi ini, perkembangan anak dikategorikan menjadi normal, meragukan (borderline), atau mengalami keterlambatan yang jelas. Setiap kategori hasil memerlukan tindakan atau intervensi yang berbeda, mulai dari edukasi dan stimulasi tambahan di rumah hingga rujukan segera ke spesialis.

Dalam hal tindak lanjut, peran perawat sangat penting untuk memberikan edukasi kepada keluarga, konseling dalam mengelola kecemasan atau kebingungan keluarga terkait hasil screening, serta memastikan rujukan ke layanan spesialis dilakukan secara tepat waktu. Koordinasi antar tenaga kesehatan, keluarga, dan spesialis terkait merupakan kunci keberhasilan intervensi yang efektif untuk membantu anak mencapai potensi maksimalnya.

Dengan demikian, screening tumbuh kembang anak menjadi prosedur esensial dalam praktik keperawatan anak untuk memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mendapatkan kesempatan terbaik dalam kehidupan masa depannya.

G. Glosarium

Ages and Stages Questionnaire (ASQ)

Kuesioner skrining yang diisi oleh orang tua untuk mengevaluasi perkembangan anak dalam berbagai aspek seperti komunikasi, motorik kasar dan halus, kemampuan pemecahan masalah, serta perkembangan sosio-emosional.

Borderline

Kondisi atau kategori hasil screening yang menunjukkan perkembangan anak sedikit di bawah batas normal, sehingga memerlukan pemantauan lebih lanjut sebelum menetapkan diagnosis pasti.

Denver Developmental Screening Test (DDST)

Alat ukur perkembangan anak usia 0 hingga 6 tahun yang secara khusus mengevaluasi aspek personal-sosial, motorik halus, bahasa, dan motorik kasar melalui observasi langsung terhadap aktivitas anak.

Gangguan Spektrum Autisme

Kondisi gangguan perkembangan yang ditandai dengan kesulitan interaksi sosial, keterbatasan komunikasi verbal maupun non-verbal, serta adanya pola perilaku yang repetitif dan respons tidak lazim terhadap rangsangan sensorik.

Grafik Pertumbuhan

Alat visual berupa grafik yang digunakan untuk memantau berat badan, tinggi badan, dan lingkaran kepala anak sesuai dengan usia, biasanya terdapat dalam Kartu Menuju Sehat (KMS).

Indeks Massa Tubuh (IMT)

Pengukuran untuk menilai status nutrisi dan proporsi berat badan terhadap tinggi badan anak yang dapat menunjukkan kondisi gizi normal, kelebihan berat badan, atau kekurangan gizi.

Instrumen Screening

Alat bantu yang digunakan dalam proses screening tumbuh kembang anak, bertujuan untuk mengevaluasi apakah anak berkembang secara optimal atau mengalami keterlambatan.

Kartu Menuju Sehat (KMS)

Instrumen sederhana yang umum digunakan di Indonesia untuk memantau pertumbuhan fisik anak, mencatat berat dan tinggi badan anak secara berkala, serta sebagai alat deteksi dini gangguan gizi atau pertumbuhan.

Kemampuan Bahasa

Kemampuan anak untuk berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal, termasuk kemampuan memahami instruksi dan mengekspresikan keinginan atau kebutuhan kepada orang lain.

Kemampuan Kognitif

Kemampuan berpikir anak yang meliputi pemecahan masalah, mengingat, memahami konsep, dan mengenali objek yang penting untuk keberhasilan akademik di masa depan.

Kemampuan Motorik Halus

Keterampilan anak yang melibatkan gerakan otot kecil secara presisi, seperti menggambar, memegang pensil, mengancingkan baju, atau mengambil benda kecil.

Kemampuan Motorik Kasar

Kemampuan yang melibatkan gerakan otot besar seperti berjalan, berlari, melompat, berdiri dengan satu kaki, atau naik turun tangga.

Konseling Keluarga

Intervensi berupa pemberian dukungan emosional dan edukasi kepada keluarga untuk memahami situasi anak serta membantu mereka mengelola kecemasan atau perasaan lain terkait kondisi tumbuh kembang anak.

Lingkar Kepala

Pengukuran lingkaran kepala anak untuk mengevaluasi pertumbuhan otak dan perkembangan neurologis yang normal atau mengidentifikasi adanya gangguan tertentu.

Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT)

Alat ukur spesifik berbentuk kuesioner yang digunakan untuk mendeteksi dini risiko gangguan spektrum autisme pada anak usia balita melalui pertanyaan tentang perilaku sehari-hari.

Observasi Langsung

Proses mengamati secara objektif aktivitas dan interaksi anak dengan lingkungan sekitar selama proses screening untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kondisi perkembangan anak.

Perkembangan Sosio-emosional

Aspek perkembangan yang mencakup kemampuan anak dalam bersosialisasi, mengelola emosi, membangun hubungan sehat dengan orang lain, serta beradaptasi dengan lingkungan.

Pertumbuhan Fisik

Aspek perkembangan yang berhubungan dengan perubahan ukuran tubuh anak, seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan indeks massa tubuh yang mencerminkan kondisi kesehatan secara umum.

Rujukan

Proses mengarahkan atau mengirim anak ke dokter spesialis, psikolog, terapis wicara, fisioterapis, atau terapis okupasi untuk evaluasi lebih mendalam dan intervensi khusus jika hasil screening menunjukkan masalah serius.

Screening Tumbuh Kembang

Proses evaluasi sistematis untuk memantau pertumbuhan fisik, motorik, kognitif, bahasa, serta sosio-emosional anak yang bertujuan mendeteksi secara dini gangguan atau keterlambatan untuk segera dilakukan intervensi.

H. Daftar Pustaka

- American Academy of Pediatrics. (2020). *Bright futures: Guidelines for health supervision of infants, children, and adolescents* (4th ed.). Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics.
- Dewi, R. (2019). *Buku ajar keperawatan anak: Teori dan aplikasi praktik klinik* (2nd ed.). Yogyakarta: Nuha Medika.
- Frankenburg, W. K., Dodds, J. B., Archer, P., Bresnick, B., Maschka, P., Edelman, N., & Shapiro, H. (1992). *Denver II: Training manual*. Denver, CO: Denver Developmental Materials, Inc.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: Direktorat Kesehatan Keluarga, Kemenkes RI.
- Robins, D. L., Fein, D., & Barton, M. L. (2009). Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised, with Follow-Up (M-CHAT-R/F). *Pediatrics*, 133(1), 37–45. <https://doi.org/10.1542/peds.2013-1813>
- Soetjiningsih. (2017). *Tumbuh Kembang Anak* (2nd ed.). Jakarta: EGC.
- Squires, J., & Bricker, D. (2009). *Ages & Stages Questionnaires®, Third Edition (ASQ®-3): A parent-completed child monitoring system*. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing.
- World Health Organization (WHO). (2006). *WHO child growth standards: Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height, and body mass index-for-age: Methods and development*. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization (WHO). (2012). *Developmental Difficulties in Early Childhood: Prevention, Early Identification, Assessment and Intervention in Low- and Middle-Income Countries: A Review*. Geneva: WHO Press.

BAB 7

KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN GANGGUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN AKTIVITAS PATOLOGIS DARI SISTEM PERSYARAFAN DAN MUSKULOSKELETAL

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, lulusan mampu memberikan asuhan keperawatan anak yang profesional, berbasis bukti, dan holistik pada kondisi gangguan sistem persyarafan dan muskuloskeletal dengan pendekatan yang humanistik dan empatik sesuai dengan standar kompetensi keperawatan anak.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi asuhan keperawatan secara komprehensif dan berbasis bukti pada anak dengan gangguan aktivitas patologis akibat kelainan sistem persyarafan dan muskuloskeletal.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan anatomi, fisiologi, dan patofisiologi dasar sistem persyarafan dan muskuloskeletal pada anak.
- Mengidentifikasi tanda dan gejala umum serta spesifik pada anak dengan gangguan sistem persyarafan dan muskuloskeletal.
- Melakukan pengkajian secara sistematis terhadap anak dengan gangguan persyarafan dan muskuloskeletal dengan menggunakan instrumen yang tepat.
- Menyusun diagnosis keperawatan prioritas berdasarkan data hasil pengkajian yang relevan dengan gangguan aktivitas patologis anak.
- Merencanakan intervensi keperawatan yang spesifik, terstruktur, dan berbasis bukti untuk memenuhi kebutuhan aktivitas pada anak dengan gangguan persyarafan dan muskuloskeletal.
- Melaksanakan asuhan keperawatan dengan pendekatan kolaboratif bersama tenaga kesehatan lain serta melibatkan keluarga dalam perawatan anak.

- Mengevaluasi respons anak terhadap intervensi keperawatan yang telah diberikan serta mendokumentasikan hasil evaluasi secara profesional dan akurat.
- Memberikan edukasi dan konseling kepada keluarga mengenai pengelolaan gangguan aktivitas patologis anak secara efektif dan berkelanjutan.

Pendahuluan

Gangguan pada sistem persyarafan dan muskuloskeletal merupakan kondisi yang sering ditemukan pada anak, yang dapat menyebabkan hambatan signifikan dalam aktivitas sehari-hari, pertumbuhan, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Kondisi patologis yang melibatkan sistem saraf dan otot-tulang ini memerlukan perhatian dan intervensi keperawatan yang komprehensif dan terintegrasi untuk meminimalkan dampak negatif jangka panjang. Gangguan seperti cerebral palsy, spina bifida, distrofi otot, patah tulang, serta gangguan neuromuskular lainnya tidak hanya mempengaruhi kemampuan fisik anak, namun juga berdampak pada aspek psikologis, sosial, dan akademik. Pemahaman yang mendalam tentang patofisiologi, tanda-gejala, serta pendekatan manajemen keperawatan menjadi penting bagi perawat untuk mampu memberikan asuhan keperawatan yang optimal pada anak dengan kondisi ini.

A. Anatomi dan Fisiologi Dasar Sistem Persyarafan dan Muskuloskeletal

Anatomi dan fisiologi dasar dari sistem persyarafan dan muskuloskeletal merupakan fondasi yang penting untuk memahami berbagai aspek kesehatan dan perkembangan anak. Kedua sistem ini bekerja secara harmonis untuk memastikan tubuh dapat melakukan fungsi-fungsi vital, seperti bergerak, bereaksi terhadap lingkungan, dan mempertahankan postur tubuh yang baik. Pada anak, pemahaman yang menyeluruh mengenai kedua sistem ini sangat penting karena berbagai gangguan atau patologi yang timbul dapat berimplikasi pada tumbuh kembang anak secara keseluruhan.

Sistem persyarafan manusia terdiri dari dua komponen utama, yaitu sistem saraf pusat (SSP) dan sistem saraf perifer (SSPfr). Sistem saraf pusat mencakup otak dan sumsum tulang belakang. Otak, sebagai pusat pengendali tubuh, bertanggung jawab untuk mengatur berbagai aktivitas tubuh mulai dari yang sangat sederhana hingga kompleks. Struktur otak terdiri dari beberapa bagian utama, seperti serebrum, serebelum, batang otak, dan diensefalon yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Serebrum bertanggung jawab untuk proses kognitif seperti berpikir, belajar, dan mengingat, serta mengatur gerakan sadar tubuh. Serebelum berfungsi dalam koordinasi gerakan tubuh, keseimbangan, dan postur. Batang otak mengontrol fungsi vital seperti pernapasan, denyut jantung, tekanan darah, dan refleks dasar. Diensefalon, yang mencakup hipotalamus dan talamus, memainkan peran kunci dalam regulasi fungsi autonom seperti suhu tubuh, rasa lapar, dan siklus tidur.

Sumsum tulang belakang sebagai bagian dari SSP juga memiliki peran sentral dalam menyampaikan impuls antara otak dan bagian tubuh lainnya. Struktur ini terdiri atas serabut saraf yang tersusun dalam segmen-segmen yang terhubung langsung dengan sistem saraf perifer. Impuls saraf berupa informasi sensorik dari lingkungan dikirimkan ke otak melalui jalur sensorik di sumsum tulang belakang, sementara impuls motorik dari otak untuk menghasilkan respons atau gerakan dikirim melalui jalur motorik.

Sistem saraf perifer terdiri atas jaringan saraf yang menyebar luas ke seluruh tubuh. Komponen ini terdiri atas serabut saraf sensorik dan motorik. Saraf sensorik bertugas mengirimkan informasi dari reseptor sensorik seperti kulit, otot, dan sendi menuju sistem saraf pusat. Sementara itu, serabut motorik berfungsi menghantarkan instruksi dari sistem saraf pusat menuju otot dan organ tubuh lainnya untuk menghasilkan gerakan atau respons tertentu. Komunikasi antara sistem saraf pusat dan perifer ini terjadi melalui proses transmisi impuls listrik yang terjadi dalam milidetik, memungkinkan tubuh anak bereaksi secara cepat terhadap rangsangan dari lingkungannya.

Di sisi lain, sistem muskuloskeletal merupakan sistem penopang dan penggerak tubuh manusia yang terdiri dari tulang, sendi, otot, ligamen, dan tendon. Tulang berfungsi sebagai kerangka tubuh yang memberikan struktur, perlindungan organ dalam, dan penyimpanan mineral seperti kalsium dan fosfor. Pada anak, tulang masih mengalami proses pertumbuhan yang signifikan, terutama pada area pelat epifisis atau pelat pertumbuhan. Pertumbuhan tulang ini penting dipantau secara teratur karena gangguan di masa tumbuh dapat menyebabkan deformitas atau gangguan permanen dalam struktur tubuh anak.

Sendi merupakan tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang, yang memungkinkan gerakan tubuh seperti membengkokkan lengan atau kaki. Sendi pada anak cenderung lebih fleksibel karena adanya jaringan kartilago yang masih lunak dan elastis, memungkinkan rentang gerak yang lebih luas dibandingkan dewasa. Namun, kondisi ini juga meningkatkan risiko cedera jika tidak dilindungi dengan baik. Ligamen adalah jaringan ikat kuat yang menghubungkan tulang ke tulang di sendi, sementara tendon menghubungkan otot ke tulang, yang keduanya mendukung stabilitas dan fleksibilitas gerakan sendi.

Otot berperan sebagai penggerak utama dalam tubuh, memungkinkan aktivitas fisik seperti berjalan, berlari, hingga gerakan-gerakan halus seperti menulis. Otot anak-anak mengalami perkembangan yang pesat selama masa pertumbuhan. Struktur otot terdiri atas serat-serat otot yang mampu berkontraksi dan berelaksasi untuk menghasilkan gerakan tubuh yang koordinatif dan efektif. Interaksi antara otot, tulang, dan sistem persyarafan memastikan gerakan tubuh berlangsung lancar dan terkoordinasi dengan baik.

Gangguan pada kedua sistem ini, baik persyarafan maupun muskuloskeletal, dapat berdampak signifikan terhadap fungsi dan kualitas hidup anak. Misalnya, gangguan neurologis seperti cerebral palsy atau kelumpuhan serebral dapat menyebabkan ketidakmampuan motorik yang signifikan, mempengaruhi kemampuan berjalan, keseimbangan, koordinasi, serta kemampuan kognitif dan komunikasi anak. Sementara gangguan muskuloskeletal seperti fraktur tulang, skoliosis, atau dislokasi sendi juga dapat menyebabkan masalah jangka panjang jika tidak ditangani dengan tepat dan tepat waktu, seperti deformitas, keterbatasan mobilitas, hingga gangguan tumbuh kembang secara umum.

B. Patofisiologi dan Manifestasi Klinis Gangguan Sistem Persyarafan dan Muskuloskeletal pada Anak

Pemahaman mengenai patofisiologi dari berbagai gangguan pada sistem persyarafan dan muskuloskeletal serta manifestasi klinis yang muncul adalah hal mendasar bagi tenaga kesehatan untuk dapat melakukan penatalaksanaan yang tepat. Secara khusus pada anak-anak, gangguan tersebut memiliki dampak yang

signifikan karena sangat berhubungan dengan aspek tumbuh kembang serta kualitas hidup di masa depan.

Gangguan sistem persyarafan pada anak yang paling sering dijumpai antara lain cerebral palsy (kelumpuhan serebral) dan spina bifida. Cerebral palsy merupakan suatu kondisi neurologis kronis yang disebabkan oleh cedera atau gangguan pada otak yang sedang berkembang, umumnya terjadi sebelum, selama, atau segera setelah kelahiran. Kerusakan ini mengganggu komunikasi normal antara otak dan otot sehingga mengakibatkan gangguan pada tonus otot (kekuatan tegangan otot), koordinasi gerakan, serta refleks tubuh. Anak dengan cerebral palsy sering menunjukkan tonus otot yang abnormal, baik dalam bentuk hipertonus (peningkatan tegangan otot yang menyebabkan kekakuan otot) maupun hipotonus (penurunan tegangan otot yang menyebabkan kelemahan dan kelenturan yang abnormal). Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam mengendalikan gerakan, koordinasi buruk, tremor, hingga ketidakmampuan menjaga keseimbangan tubuh secara optimal.

Selain cerebral palsy, spina bifida adalah kelainan kongenital yang disebabkan oleh kegagalan penutupan tulang belakang pada masa perkembangan embrio. Pada spina bifida, terjadi cacat struktural pada kolumna vertebralis yang mengakibatkan paparan sebagian sumsum tulang belakang atau akar saraf. Kondisi ini menyebabkan gangguan neurologis yang signifikan karena kerusakan atau tekanan pada saraf spinal. Manifestasi klinis dari spina bifida dapat berupa gangguan motorik seperti kelemahan atau kelumpuhan anggota gerak bawah, gangguan sensorik yang menyebabkan hilangnya rasa atau sensasi nyeri, serta gangguan pada fungsi kandung kemih dan usus, yang sering menyebabkan inkontinensia urin dan feses.

Di sisi lain, gangguan pada sistem muskuloskeletal pada anak, seperti distrofi otot dan patah tulang (fraktur), memiliki patofisiologi yang berbeda namun tetap berpengaruh besar terhadap fungsi tubuh anak. Distrofi otot, contohnya distrofi otot Duchenne, adalah kelainan genetik progresif yang menyebabkan degenerasi serabut otot secara perlahan karena kurangnya protein distrofina. Kekurangan protein ini menyebabkan otot menjadi lemah secara progresif, akhirnya mengalami atrofi atau penyusutan, sehingga anak akan mengalami kesulitan dalam mobilitas seperti berjalan, berlari, atau bahkan berdiri. Distrofi otot juga sering kali menyebabkan deformitas fisik, seperti skoliosis, lordosis, dan kontraktur sendi, karena otot tidak lagi mampu mempertahankan posisi normal tubuh.

Patah tulang atau fraktur pada anak memiliki patofisiologi berbeda, yakni berupa kerusakan atau diskontinuitas jaringan tulang akibat trauma atau tekanan mekanik yang melampaui daya tahan tulang. Pada anak-anak, fraktur memiliki karakteristik unik karena tulang masih dalam masa pertumbuhan. Fraktur yang melibatkan pelat pertumbuhan (epifisis) dapat menyebabkan gangguan serius pada

pertumbuhan tulang, menyebabkan deformitas permanen apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Manifestasi klinis utama patah tulang adalah nyeri yang signifikan, pembengkakan di area cedera, deformitas atau perubahan bentuk tulang, dan ketidakmampuan menggerakkan bagian tubuh yang terkena.

Secara umum, manifestasi klinis dari gangguan sistem persyarafan dan muskuloskeletal pada anak sangat beragam namun memiliki beberapa karakteristik utama yang sering muncul. Keterbatasan gerak merupakan salah satu manifestasi utama yang dapat terjadi akibat kelemahan otot, kelumpuhan, atau deformitas fisik seperti skoliosis. Anak-anak juga sering mengalami gangguan keseimbangan yang signifikan, ditandai dengan sulitnya anak untuk berdiri tegak, mudah terjatuh, atau kesulitan dalam mempertahankan posisi tubuh saat berjalan atau melakukan aktivitas sehari-hari.

Kelemahan otot adalah manifestasi lain yang umum dijumpai pada anak dengan gangguan ini. Kelemahan ini dapat berupa penurunan kekuatan yang generalisata atau terlokalisasi pada bagian tubuh tertentu, yang sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Nyeri kronis juga dapat menyertai kondisi tersebut, terutama pada kasus distrofi otot atau fraktur, yang dapat menghambat partisipasi anak dalam aktivitas bermain maupun belajar.

Deformitas struktur tubuh, baik karena kelainan neurologis atau muskuloskeletal, menjadi manifestasi klinis yang jelas terlihat. Kelainan struktur ini, seperti kontraktur sendi, skoliosis, atau deformitas ekstremitas bawah, dapat menimbulkan hambatan fungsional yang serius, mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak secara umum. Gangguan fungsi motorik kasar maupun halus merupakan manifestasi klinis lain yang sering terjadi, yang mengganggu kemampuan anak untuk beraktivitas sehari-hari seperti berjalan, berlari, menggenggam, menulis, dan melakukan berbagai tugas sederhana lainnya.

C. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian keperawatan merupakan tahapan esensial dalam proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara komprehensif tentang status kesehatan anak, khususnya pada gangguan sistem persyarafan dan muskuloskeletal. Pengkajian ini dilakukan secara sistematis melalui berbagai pendekatan, meliputi observasi langsung, wawancara riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik menyeluruh, dan penggunaan alat atau instrumen pengukuran khusus yang telah terstandardisasi. Informasi yang terkumpul dari proses ini akan menjadi dasar dalam merumuskan diagnosis keperawatan yang tepat serta menentukan rencana intervensi keperawatan yang efektif.

Dalam proses pengkajian awal, observasi langsung terhadap tanda-tanda klinis yang ditunjukkan anak sangat penting. Pada anak dengan gangguan persyarafan seperti cerebral palsy, perawat perlu memperhatikan pola gerakan abnormal seperti

kekakuan (spastisitas), gerakan involunter, tremor, atau kelemahan otot yang mencolok. Pengamatan juga mencakup kemampuan anak dalam mempertahankan keseimbangan saat berdiri atau berjalan, ketepatan koordinasi gerakan, dan respon refleks yang abnormal seperti refleks primitif yang menetap pada usia ketika seharusnya telah hilang.

Dalam hal gangguan muskuloskeletal, perawat harus mencatat adanya deformitas atau perubahan struktur tubuh, seperti skoliosis, lordosis, atau deformitas anggota gerak akibat patah tulang yang tidak sembuh sempurna. Pengamatan dilakukan terhadap posisi tubuh anak baik saat berdiri, duduk maupun berbaring, serta pola berjalan yang mungkin terganggu akibat kelemahan otot atau nyeri.

Selain observasi, wawancara untuk mendapatkan riwayat penyakit secara detail juga sangat penting. Pengkajian ini meliputi pertanyaan kepada orang tua atau pengasuh mengenai riwayat kelahiran anak (apakah ada komplikasi atau cedera saat lahir), riwayat tumbuh kembang anak (kapan anak mulai merangkak, berjalan, berbicara, serta apakah terdapat keterlambatan pencapaian milestone), riwayat penyakit sebelumnya yang pernah dialami anak, serta riwayat kesehatan keluarga khususnya penyakit yang bersifat genetik atau keturunan seperti distrofi otot.

Riwayat keluhan utama anak juga harus dicatat secara jelas, meliputi gejala-gejala yang dialami seperti nyeri, kesulitan bergerak, frekuensi jatuh, kelelahan, hingga masalah sensorik seperti mati rasa atau kesemutan. Dalam wawancara ini juga penting menanyakan bagaimana keluhan tersebut memengaruhi aktivitas sehari-hari anak, termasuk dampaknya terhadap kegiatan bermain, bersekolah, dan interaksi sosialnya.

Pemeriksaan fisik adalah komponen sentral dalam pengkajian keperawatan. Pemeriksaan ini mencakup evaluasi sistematis dari sistem persyarafan dan muskuloskeletal. Pada pemeriksaan neurologis, dilakukan pengukuran fungsi motorik, sensorik, dan refleks. Fungsi motorik dinilai dengan mengamati kekuatan otot, tonus otot, koordinasi, serta kemampuan anak dalam menjalankan gerakan yang terarah dan tepat. Pemeriksaan sensorik melibatkan pengujian sensitivitas terhadap sentuhan, suhu, dan nyeri. Refleks tubuh juga diperiksa, baik refleks dalam seperti refleks tendon maupun refleks permukaan seperti refleks plantar dan Babinski.

Pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal melibatkan pengamatan struktur dan bentuk tubuh, palpasi terhadap tulang dan sendi untuk menemukan adanya nyeri, deformitas, atau pembengkakan, serta evaluasi rentang gerak sendi (range of motion). Kekuatan otot anak dinilai melalui pemeriksaan langsung dengan meminta anak melakukan gerakan tertentu seperti mengangkat anggota tubuh melawan gravitasi atau tahanan ringan.

Dalam pengkajian ini, penggunaan instrumen khusus sangat dianjurkan untuk memastikan data objektif yang terstandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, skala nyeri yang disesuaikan dengan usia anak (seperti skala wajah Wong-Baker atau FLACC scale untuk anak yang belum bisa berkomunikasi dengan baik) sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi tingkat nyeri secara akurat. Skala kekuatan otot, seperti skala Medical Research Council (MRC), digunakan untuk menentukan derajat kelemahan otot yang dialami anak dengan gangguan muskuloskeletal.

Instrumen lain seperti skala modifikasi Ashworth digunakan untuk mengukur derajat spastisitas atau kekakuan otot pada kasus cerebral palsy. Selain itu, alat bantu seperti Denver Developmental Screening Test (DDST) bisa diterapkan untuk mengevaluasi keterlambatan perkembangan motorik kasar dan halus secara objektif, memberikan data tambahan yang penting dalam menentukan intervensi yang diperlukan.

Setelah seluruh data dari observasi, wawancara, pemeriksaan fisik, dan instrumen khusus terkumpul, perawat kemudian mengintegrasikan informasi tersebut untuk merumuskan diagnosis keperawatan yang tepat. Diagnosis keperawatan ini merupakan landasan penting dalam menentukan prioritas masalah kesehatan, menyusun intervensi yang tepat, serta mengevaluasi efektivitas dari intervensi tersebut di kemudian hari.

D. Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan merupakan pernyataan klinis yang menunjukkan respons aktual atau potensial anak terhadap masalah kesehatan tertentu. Diagnosis ini didasarkan pada hasil pengkajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap kondisi anak, baik dari aspek fisik, emosional, maupun sosial. Pada anak yang mengalami gangguan persyarafan dan muskuloskeletal, terdapat beberapa diagnosis keperawatan yang sering muncul sebagai prioritas dalam pemberian asuhan keperawatan. Diagnosis keperawatan yang umum muncul pada anak dengan gangguan persyarafan dan muskuloskeletal antara lain:

1. Gangguan mobilitas fisik

Gangguan mobilitas fisik merupakan diagnosis yang sering muncul pada anak dengan gangguan sistem persyarafan dan muskuloskeletal. Diagnosis ini merujuk pada keterbatasan dalam melakukan gerakan secara mandiri, aman, dan efektif.

Anak dengan cerebral palsy, spina bifida, atau distrofi otot sering mengalami kesulitan dalam bergerak akibat kelemahan otot, kekakuan, nyeri, deformitas, atau gangguan keseimbangan. Manifestasi klinisnya antara lain kesulitan berjalan atau berpindah tempat, keterbatasan dalam menggunakan

anggota tubuh, serta ketidakmampuan untuk mempertahankan posisi tubuh secara normal.

Gangguan mobilitas ini berdampak luas, menyebabkan anak mengalami isolasi sosial karena kesulitan berpartisipasi dalam aktivitas bermain dengan teman sebaya. Selain itu, keterbatasan mobilitas juga meningkatkan risiko gangguan lain, seperti kontraktur sendi akibat jarangya gerakan atau latihan fisik. Oleh karena itu, intervensi keperawatan untuk diagnosis ini difokuskan pada optimalisasi kemampuan gerak, latihan fisik, penggunaan alat bantu mobilitas, serta edukasi keluarga tentang pentingnya aktivitas fisik yang sesuai.

2. Risiko cedera

Risiko cedera pada anak dengan gangguan sistem persyarafan dan muskuloskeletal meningkat signifikan karena adanya gangguan koordinasi, gangguan keseimbangan, dan kelemahan otot yang menyebabkan anak rentan terjatuh atau mengalami trauma lainnya.

Anak dengan gangguan koordinasi motorik akibat cerebral palsy atau spina bifida, misalnya, memiliki risiko lebih tinggi mengalami cedera akibat jatuh atau benturan. Selain itu, anak dengan distrofi otot rentan mengalami cedera akibat kelemahan otot progresif yang menyebabkan ketidakstabilan tubuh saat melakukan gerakan sehari-hari.

Untuk diagnosis ini, fokus intervensi keperawatan diarahkan pada pencegahan cedera melalui pemantauan ketat lingkungan, penyesuaian lingkungan rumah atau ruang bermain yang aman, edukasi orang tua mengenai pentingnya supervisi, serta mengajarkan teknik pencegahan cedera seperti penggunaan alat bantu jalan atau kursi roda yang tepat.

3. Nyeri akut atau kronis

Nyeri merupakan diagnosis keperawatan yang sangat umum dijumpai pada anak dengan gangguan persyarafan dan muskuloskeletal, baik dalam bentuk nyeri akut (nyeri tiba-tiba, durasi singkat) maupun nyeri kronis (nyeri persisten yang berlangsung lama).

Nyeri akut dapat terjadi akibat trauma atau cedera, seperti pada kasus patah tulang. Nyeri kronis lebih sering ditemukan pada anak dengan kondisi seperti cerebral palsy, spina bifida, atau distrofi otot, yang sering mengalami kontraktur sendi, kejang otot, dan deformitas tubuh.

Manifestasi nyeri pada anak sering sulit diungkapkan secara jelas, terutama pada anak kecil. Oleh sebab itu, perawat perlu menggunakan instrumen pengkajian nyeri khusus seperti skala wajah (Wong-Baker FACES), FLACC scale, serta observasi terhadap tanda-tanda nyeri non-verbal seperti menangis, rewel, postur tubuh abnormal, atau perubahan perilaku.

Penanganan nyeri ini meliputi intervensi farmakologis dan non-farmakologis. Intervensi farmakologis mencakup pemberian analgesik sesuai

kebutuhan. Sedangkan intervensi non-farmakologis mencakup terapi fisik, pijat, terapi relaksasi, distraksi, serta edukasi keluarga dalam menangani nyeri anak secara efektif.

4. Gangguan tumbuh kembang

Gangguan tumbuh kembang adalah diagnosis keperawatan penting yang sering muncul pada anak-anak dengan gangguan sistem persyarafan dan muskuloskeletal. Diagnosis ini merujuk pada risiko atau kondisi aktual di mana anak gagal mencapai tahapan perkembangan fisik, motorik, sosial, atau kognitif sesuai usianya.

Pada kondisi seperti cerebral palsy atau spina bifida, gangguan perkembangan motorik kasar (seperti terlambat berjalan atau duduk) dan motorik halus (seperti sulit memegang pensil atau mainan kecil) sangat umum dijumpai. Begitu pula dengan anak yang mengalami distrofi otot, yang seiring waktu mengalami penurunan kemampuan fisik yang drastis sehingga mengganggu perkembangan fisik dan sosialnya secara keseluruhan.

Penanganan untuk diagnosis ini meliputi pemberian stimulasi perkembangan secara intensif, terapi okupasi, terapi fisik, dan dukungan edukasi kepada keluarga untuk membantu anak mencapai potensi perkembangannya semaksimal mungkin. Evaluasi perkembangan secara berkala menggunakan alat skrining seperti Denver Developmental Screening Test (DDST) penting untuk dilakukan.

5. Defisit perawatan diri

Defisit perawatan diri adalah diagnosis keperawatan yang muncul ketika anak mengalami ketidakmampuan atau keterbatasan dalam melakukan aktivitas perawatan diri secara mandiri seperti makan, mandi, berpakaian, dan penggunaan toilet akibat gangguan persyarafan atau muskuloskeletal yang dialaminya.

Misalnya, anak dengan cerebral palsy berat mungkin mengalami kesulitan besar dalam aktivitas dasar sehari-hari, seperti makan dan berpakaian, karena kekakuan atau kelemahan otot. Begitu juga dengan anak dengan spina bifida, yang bisa mengalami masalah dalam pengendalian kandung kemih dan usus, menyebabkan ketergantungan pada orang lain untuk perawatan diri.

Untuk diagnosis ini, perawat perlu menilai secara detail sejauh mana keterbatasan anak dalam aktivitas sehari-hari, memberikan pelatihan keterampilan mandiri sesuai kemampuan anak, serta mendukung keluarga dalam membantu anak mencapai tingkat kemandirian yang optimal. Edukasi penggunaan alat bantu seperti kursi khusus atau perangkat adaptif untuk makan dan berpakaian juga menjadi bagian penting dari intervensi keperawatan.

E. Perencanaan dan Implementasi Intervensi Keperawatan

Perencanaan dan implementasi intervensi keperawatan merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam memberikan asuhan kepada anak dengan gangguan persyarafan dan muskuloskeletal. Intervensi ini dirancang berdasarkan diagnosis keperawatan yang telah ditetapkan melalui pengkajian yang mendalam, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan fungsional anak, mengurangi risiko komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup anak dan keluarga secara keseluruhan.

Dalam perencanaan intervensi, perawat harus mengembangkan strategi yang bersifat individual, holistik, serta berorientasi pada kebutuhan anak dan keluarganya. Intervensi ini mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan mobilitas, mengelola nyeri, mencegah komplikasi seperti luka dekubitus dan kontraktur sendi, serta memberikan edukasi komprehensif kepada keluarga mengenai teknik perawatan yang tepat di rumah.

1. Intervensi untuk Meningkatkan Mobilitas

Anak dengan gangguan sistem persyarafan dan muskuloskeletal sering mengalami keterbatasan mobilitas yang signifikan, baik karena kelemahan otot, deformitas struktur tubuh, atau nyeri. Oleh karena itu, perencanaan intervensi mobilitas mencakup aktivitas seperti latihan rentang gerak aktif maupun pasif, latihan kekuatan otot, serta latihan keseimbangan dan koordinasi.

Dalam implementasinya, perawat berkolaborasi erat dengan fisioterapis untuk menyusun jadwal terapi yang terstruktur, meliputi aktivitas fisik yang sesuai kemampuan anak, seperti terapi berjalan, latihan posisi berdiri, latihan motorik kasar dan halus, serta stimulasi gerakan menggunakan alat bantu seperti kursi roda, walker, atau splint khusus.

Selain intervensi langsung, perawat juga berperan memberikan edukasi kepada keluarga tentang pentingnya mobilisasi secara rutin di rumah, teknik latihan sederhana, serta penggunaan alat bantu mobilitas yang tepat agar anak tetap aktif secara fisik sesuai dengan kemampuannya.

2. Intervensi untuk Mengelola Nyeri

Manajemen nyeri merupakan prioritas penting dalam perencanaan keperawatan bagi anak dengan gangguan persyarafan dan muskuloskeletal. Intervensi pengelolaan nyeri ini mencakup pendekatan farmakologis dan non-farmakologis.

Secara farmakologis, perawat berkolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk memberikan obat analgesik sesuai indikasi klinis dan dosis yang tepat. Pemantauan efek samping dan efektivitas terapi analgesik secara berkala merupakan tanggung jawab perawat.

Pendekatan non-farmakologis meliputi teknik relaksasi seperti pijat ringan, terapi distraksi seperti bermain atau mendengarkan musik, serta penggunaan

terapi fisik seperti kompres hangat atau dingin, latihan peregangan otot, dan perubahan posisi secara berkala untuk mengurangi nyeri akibat tekanan atau posisi tubuh yang tidak nyaman.

Perawat juga wajib memberikan edukasi kepada keluarga mengenai cara-cara mengenali tanda nyeri pada anak, teknik meredakan nyeri sederhana, serta pentingnya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak untuk mengurangi rasa sakit secara psikologis maupun fisik.

3. Intervensi Pencegahan Komplikasi (Dekubitus dan Kontraktur)

Anak yang mengalami keterbatasan gerak dalam waktu lama sangat rentan terhadap komplikasi seperti luka dekubitus (pressure ulcer) dan kontraktur sendi. Oleh karena itu, perawat harus merencanakan intervensi secara preventif.

Pencegahan dekubitus meliputi reposisi tubuh anak secara teratur (setiap 2 jam), penggunaan kasur khusus (pressure-relief mattress), menjaga kebersihan kulit, dan pemeriksaan kulit secara berkala untuk mendeteksi adanya tanda awal luka tekan.

Pencegahan kontraktur sendi dilakukan melalui latihan rentang gerak (ROM) secara teratur, baik aktif maupun pasif, penggunaan splint atau alat ortopedi khusus sesuai kebutuhan, serta memastikan bahwa anak berada dalam posisi tubuh yang fisiologis untuk mencegah deformitas permanen pada sendi.

Implementasi intervensi ini memerlukan kerjasama tim yang baik antara perawat, fisioterapis, dan keluarga agar komplikasi yang mungkin terjadi dapat diminimalisir secara optimal.

4. Edukasi Keluarga mengenai Teknik Perawatan di Rumah

Edukasi keluarga merupakan salah satu komponen vital dalam perencanaan intervensi keperawatan. Edukasi ini bertujuan agar keluarga mampu melakukan perawatan anak secara mandiri di rumah, memahami kondisi anak secara mendalam, serta mendukung perkembangan anak secara optimal.

Materi edukasi yang diberikan meliputi teknik-teknik dasar perawatan seperti cara mobilisasi yang aman, teknik pemberian obat sesuai instruksi dokter, cara mencegah cedera atau komplikasi, serta pengenalan tanda-tanda bahaya yang memerlukan konsultasi medis segera.

Perawat juga perlu memberikan edukasi mengenai cara merawat alat bantu khusus seperti kursi roda, splint, atau perangkat ortopedi lainnya, serta pentingnya melakukan kontrol rutin ke fasilitas kesehatan untuk evaluasi perkembangan kondisi anak.

Implementasi Kolaboratif

Dalam melaksanakan intervensi keperawatan tersebut, kolaborasi multidisiplin menjadi hal yang sangat penting. Implementasi intervensi memerlukan koordinasi yang erat antara perawat dengan berbagai disiplin ilmu lainnya, antara lain:

1. Fisioterapis: Memberikan latihan fisik intensif untuk meningkatkan kekuatan otot, keseimbangan, koordinasi, dan mencegah kontraktur.
2. Dokter Spesialis Anak: Bertanggung jawab dalam aspek medis seperti penanganan farmakologis, pemeriksaan rutin kondisi kesehatan, dan evaluasi kemajuan klinis.
3. Terapis Okupasi: Membantu anak meningkatkan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari melalui latihan keterampilan hidup seperti makan, mandi, berpakaian, serta penggunaan alat bantu adaptif.
4. Psikolog atau Konselor: Memberikan dukungan emosional bagi anak dan keluarga, membantu mengatasi stres atau masalah psikologis yang timbul akibat kondisi kronis tersebut.
5. Ahli Gizi: Memastikan anak mendapatkan asupan nutrisi yang optimal untuk mendukung pertumbuhan fisik dan kesehatan otot serta tulang.

F. Latihan Soal

Kasus 1

Seorang anak laki-laki usia 7 tahun dibawa ke klinik dengan keluhan sering terjatuh saat berjalan dan kesulitan menaiki tangga. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kelemahan otot ekstremitas bawah yang progresif, berjalan dengan gaya "goyang bebek," dan adanya hipertrofi otot betis yang tampak besar namun teraba lunak. Hasil anamnesis menunjukkan riwayat keluarga dengan gangguan otot serupa. Diagnosis yang paling mungkin adalah?

- A. Cerebral palsy
- B. Spina bifida
- C. Distrofi otot Duchenne
- D. Fraktur femur
- E. Skoliosis idiopatik

Kunci Jawaban:

C. Distrofi otot Duchenne

Rasional

Distrofi otot Duchenne memiliki ciri khas kelemahan otot progresif, hipertrofi otot betis yang dikenal sebagai pseudohipertrofi, dan riwayat keluarga karena bersifat genetik.

Kasus 2

Seorang anak perempuan usia 4 tahun datang ke RS dengan keluhan kesulitan berdiri tegak dan sering berjalan terjatuh. Pemeriksaan fisik ditemukan kelemahan otot ekstremitas bawah, tonus otot sangat lemah (hipotonus), serta adanya inkontinensia urin dan feses yang tidak disadari anak. Pemeriksaan tulang belakang

menunjukkan adanya tonjolan kecil di daerah lumbal. Diagnosis keperawatan utama yang tepat pada anak ini adalah?

- A. Gangguan tumbuh kembang
- B. Nyeri akut
- C. Risiko cedera
- D. Gangguan mobilitas fisik
- E. Defisit perawatan diri

Kunci Jawaban

D. Gangguan mobilitas fisik

Rasional:

Anak dengan spina bifida sering menunjukkan kelemahan otot ekstremitas bawah yang signifikan, gangguan mobilitas menjadi diagnosis utama, walaupun ada defisit perawatan diri namun keterbatasan gerak sangat dominan di kasus ini.

Kasus 3

Seorang anak laki-laki usia 6 tahun dirawat akibat jatuh dari sepeda dengan keluhan nyeri hebat pada lengan kanan bawah. Pemeriksaan fisik menunjukkan deformitas tulang yang jelas, pembengkakan signifikan, nyeri tekan hebat, dan anak menangis terus-menerus. Berdasarkan kondisi tersebut, diagnosis keperawatan prioritas adalah?

- A. Risiko cedera
- B. Nyeri akut
- C. Defisit perawatan diri
- D. Gangguan tumbuh kembang
- E. Gangguan mobilitas fisik

Kunci Jawaban:

B. Nyeri akut

Rasional:

Manifestasi utama pada kasus patah tulang akut adalah nyeri hebat yang perlu segera diatasi. Meskipun risiko cedera adalah faktor awal, nyeri akut merupakan masalah utama yang mendesak.

Kasus 4

Seorang anak perempuan usia 3 tahun didiagnosis cerebral palsy tipe spastik dibawa ke puskesmas oleh ibunya untuk kontrol rutin. Perawat menemukan adanya kekakuan otot (hipertonus) yang menyebabkan sulitnya pergerakan, terutama pada anggota gerak bawah. Tujuan intervensi keperawatan yang paling tepat untuk kondisi ini adalah?

- A. Mengatasi inkontinensia urin
- B. Mengurangi nyeri akut
- C. Mencegah kontraktur sendi

- D. Mengatasi defisit nutrisi
- E. Mengatasi defisit komunikasi verbal

Kunci Jawaban:

C. Mencegah kontraktur sendi

Rasional:

Pada cerebral palsy tipe spastik, tonus otot yang tinggi menyebabkan risiko kontraktur sendi meningkat. Pencegahan kontraktur merupakan prioritas utama.

Kasus 5

Seorang anak laki-laki usia 8 tahun dengan cerebral palsy dirawat di bangsal anak dengan diagnosis gangguan mobilitas fisik. Anak ini mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas dasar seperti makan, mandi, dan berpakaian. Intervensi keperawatan prioritas yang perlu dilakukan adalah?

- A. Melakukan latihan relaksasi
- B. Pemberian analgetik rutin
- C. Latihan keterampilan perawatan diri
- D. Memberikan edukasi pengobatan antibiotik
- E. Memberikan nutrisi tinggi protein

Kunci Jawaban:

C. Latihan keterampilan perawatan diri

Rasional:

Pada anak cerebral palsy yang memiliki gangguan mobilitas dan perawatan diri, intervensi utama adalah melatih keterampilan perawatan diri agar anak mampu mencapai tingkat kemandirian optimal.

G. Rangkuman Materi

Pemahaman mengenai anatomi dan fisiologi dasar sistem persyarafan dan muskuloskeletal sangat penting dalam asuhan keperawatan anak, karena kedua sistem ini memiliki peran vital dalam menunjang tumbuh kembang serta kualitas hidup anak secara keseluruhan. Gangguan yang terjadi pada kedua sistem tersebut, seperti cerebral palsy, spina bifida, distrofi otot, dan fraktur tulang, dapat menimbulkan berbagai manifestasi klinis yang mencakup keterbatasan gerak, gangguan keseimbangan, kelemahan otot, nyeri kronis, deformitas fisik, serta defisit dalam perawatan diri.

Proses pengkajian keperawatan secara komprehensif melalui observasi, wawancara mendalam, pemeriksaan fisik, serta penggunaan instrumen khusus seperti skala nyeri, skala kekuatan otot, dan skrining perkembangan, merupakan langkah awal yang penting untuk mengidentifikasi diagnosis keperawatan secara akurat. Diagnosis keperawatan utama yang sering muncul antara lain gangguan

mobilitas fisik, risiko cedera, nyeri akut atau kronis, gangguan tumbuh kembang, serta defisit perawatan diri.

Berdasarkan diagnosis tersebut, perencanaan intervensi keperawatan dirancang untuk meningkatkan mobilitas anak, mengelola nyeri, mencegah komplikasi seperti dekubitus dan kontraktur sendi, serta mengedukasi keluarga mengenai perawatan anak di rumah secara mandiri. Implementasi intervensi melibatkan kolaborasi multidisiplin dengan fisioterapis, dokter spesialis anak, terapis okupasi, psikolog atau konselor, dan ahli gizi, agar pendekatan yang diberikan bersifat holistik dan komprehensif. Dengan demikian, asuhan keperawatan yang terstruktur dan kolaboratif ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup anak secara optimal serta mendukung tumbuh kembangnya secara maksimal.

H. Glosarium

Anatomi: Ilmu yang mempelajari struktur tubuh makhluk hidup, termasuk bentuk dan susunan organ serta jaringan tubuh.

Fisiologi: Ilmu yang mempelajari fungsi-fungsi normal organ dan sistem dalam tubuh manusia.

Sistem Persyarafan: Sistem tubuh yang terdiri dari jaringan saraf yang berfungsi dalam menerima, mengolah, dan mengirimkan informasi melalui impuls listrik ke seluruh tubuh.

Sistem Saraf Pusat (SSP): Bagian sistem saraf yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang yang berfungsi sebagai pusat pengendali utama aktivitas tubuh.

Sistem Saraf Perifer (SSPfr): Bagian sistem saraf yang terdiri dari jaringan saraf di luar sistem saraf pusat, yang menghubungkan SSP dengan anggota tubuh lainnya.

Serebrum: Bagian terbesar otak yang bertanggung jawab atas fungsi kognitif tinggi seperti berpikir, belajar, mengingat, dan gerakan sadar.

Serebelum: Bagian otak yang berfungsi dalam mengatur koordinasi gerakan, keseimbangan, dan postur tubuh.

Batang Otak: Struktur yang menghubungkan otak besar dengan sumsum tulang belakang dan mengontrol fungsi vital tubuh seperti pernapasan, detak jantung, dan refleks dasar.

Diensefalon: Bagian otak yang terdiri dari hipotalamus dan talamus, bertanggung jawab atas regulasi fungsi otonom tubuh seperti suhu tubuh, rasa lapar, dan siklus tidur.

Sumsum Tulang Belakang: Struktur jaringan saraf dalam tulang belakang yang berfungsi menghantarkan impuls antara otak dan seluruh tubuh.

Impuls Saraf: Sinyal elektrik yang dihantarkan melalui serabut saraf dari dan menuju sistem saraf pusat dan perifer.

Sensorik: Berkaitan dengan penginderaan atau penerimaan rangsangan dari lingkungan.

Motorik: Berkaitan dengan gerakan tubuh atau aktivitas fisik.

Sistem Muskuloskeletal: Sistem tubuh yang terdiri dari otot, tulang, sendi, ligamen, dan tendon, berfungsi dalam mendukung struktur tubuh, melindungi organ, dan memungkinkan gerakan.

Tulang: Jaringan keras yang membentuk kerangka tubuh, melindungi organ vital, dan menyimpan mineral penting seperti kalsium.

Pelat Epifisis: Area pertumbuhan tulang yang terdapat pada ujung tulang panjang pada anak-anak, yang memungkinkan tulang bertumbuh dan berkembang.

Sendi: Tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang yang memungkinkan gerakan tubuh.

Ligamen: Jaringan ikat kuat yang menghubungkan tulang satu dengan tulang lainnya di daerah sendi, menjaga stabilitas sendi.

Tendon: Jaringan ikat kuat yang menghubungkan otot dengan tulang, memungkinkan transfer gaya untuk menghasilkan gerakan.

Otot: Jaringan tubuh yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan berelaksasi, menghasilkan gerakan tubuh.

Gangguan Neurologis: Gangguan atau penyakit yang mempengaruhi sistem saraf, seperti cerebral palsy dan spina bifida.

Cerebral Palsy: Gangguan neurologis kronis akibat cedera otak pada masa perkembangan dini, yang menyebabkan gangguan tonus otot, koordinasi gerakan, keseimbangan, dan refleks.

Spina Bifida: Kelainan kongenital akibat kegagalan penutupan tulang belakang, menyebabkan gangguan fungsi saraf spinal dan berbagai gangguan neurologis.

Distrofi Otot Duchenne: Penyakit genetik progresif yang menyebabkan degenerasi serabut otot, menyebabkan kelemahan otot dan gangguan mobilitas.

Fraktur: Kondisi patah atau retaknya tulang akibat trauma atau tekanan mekanik berlebihan.

Deformitas: Perubahan atau penyimpangan bentuk normal dari suatu struktur tubuh, seperti tulang atau sendi.

Kelemahan Otot: Kondisi berkurangnya kekuatan otot, menyebabkan kesulitan dalam melakukan gerakan tubuh.

Kontraktur Sendi: Kondisi kaku atau keterbatasan gerak sendi akibat tidak aktif atau imobilisasi dalam waktu lama.

Nyeri Kronis: Nyeri yang berlangsung lama atau berulang, biasanya terkait dengan kondisi yang bersifat progresif atau kronis.

Pengkajian Keperawatan: Proses sistematis yang dilakukan perawat untuk mengumpulkan data kesehatan pasien secara komprehensif sebagai dasar penentuan diagnosis keperawatan.

Diagnosis Keperawatan: Pernyataan klinis yang menggambarkan respons aktual atau potensial pasien terhadap masalah kesehatan tertentu.

Gangguan Mobilitas Fisik: Kondisi keterbatasan atau ketidakmampuan pasien dalam melakukan gerakan tubuh secara efektif dan mandiri.

Risiko Cedera: Kondisi di mana pasien memiliki potensi lebih tinggi mengalami cedera akibat keterbatasan fisik atau gangguan koordinasi tubuh.

Defisit Perawatan Diri: Ketidakmampuan pasien untuk secara mandiri melakukan aktivitas perawatan diri seperti makan, mandi, berpakaian, atau penggunaan toilet.

Intervensi Keperawatan: Aktivitas atau tindakan yang dirancang oleh perawat berdasarkan diagnosis keperawatan untuk mencapai tujuan spesifik dalam mengatasi masalah kesehatan pasien.

Dekubitus (Pressure Ulcer): Luka tekan yang terjadi akibat tekanan lama pada kulit akibat imobilisasi atau posisi tubuh yang tidak berubah dalam waktu lama.

Kolaborasi Multidisiplin: Kerjasama antara berbagai tenaga kesehatan dari berbagai bidang keilmuan untuk mencapai tujuan terapi yang optimal.

Fisioterapi: Profesional kesehatan yang memberikan terapi fisik untuk meningkatkan mobilitas, kekuatan otot, dan keseimbangan tubuh.

Terapis Okupasi: Profesional kesehatan yang membantu pasien untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri.

Psikolog atau Konselor: Profesional yang memberikan dukungan emosional dan psikologis bagi pasien dan keluarganya untuk mengatasi tekanan atau stres akibat kondisi kronis.

Ahli Gizi: Profesional yang memastikan kebutuhan nutrisi pasien terpenuhi secara optimal untuk menunjang kesehatan tubuh secara keseluruhan.

I. Daftar Pustaka

- Damayanti, R. (2018). *Anatomi dan Fisiologi untuk Keperawatan* (Edisi ke-4). Salemba Medika.
- Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2021). *Textbook of Medical Physiology* (14th ed.). Elsevier.
- Hidayat, A. A. A. (2017). *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan* (Edisi ke-2). Salemba Medika.
- James, S. R., Nelson, K. A., & Ashwill, J. W. (2019). *Nursing Care of Children: Principles and Practice* (5th ed.). Elsevier.
- Kozier, B., Erb, G., Berman, A., Snyder, S., Frandsen, G., & Buck, M. (2021). *Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice* (11th ed.). Pearson Education.
- McCance, K. L., & Huether, S. E. (2019). *Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults and Children* (8th ed.). Elsevier.
- Muttaqin, A., & Sari, K. U. (2016). *Buku Ajar Asuhan Keperawatan Klien dengan Gangguan Sistem Muskuloskeletal*. Salemba Medika.

- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. (2020). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Purnomo, H. (2019). *Ilmu Penyakit Saraf Dasar* (Edisi ke-3). Sagung Seto.
- Sherwood, L. (2017). *Human Physiology: From Cells to Systems* (9th ed.). Cengage Learning.
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2018). *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing* (14th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Soetjiningsih. (2018). *Tumbuh Kembang Anak* (Edisi ke-2). EGC.
- Wong, D. L., Hockenberry, M. J., Wilson, D., Rodgers, C. C., & Rodgers, C. (2019). *Wong's Essentials of Pediatric Nursing* (11th ed.). Elsevier.

BAB 8

KONSEP ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Menunjukkan sikap empati, peduli, dan profesional dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus.
- Mengaplikasikan konsep teoritis keperawatan dalam merancang intervensi yang tepat untuk anak dengan kebutuhan khusus.
- Bekerja sama secara efektif dalam tim multidisiplin untuk memenuhi kebutuhan khusus anak dan keluarganya secara holistik.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dasar asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus secara komprehensif.
- Mengidentifikasi berbagai jenis gangguan dan kebutuhan khusus pada anak secara akurat.
- Menyusun rencana asuhan keperawatan yang efektif dan individual untuk anak dengan kebutuhan khusus.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan definisi dan karakteristik anak dengan kebutuhan khusus.
- Menguraikan jenis-jenis kebutuhan khusus pada anak (fisik, intelektual, emosional, sosial).
- Melakukan pengkajian keperawatan secara sistematis terhadap anak dengan kebutuhan khusus.
- Menyusun diagnosis keperawatan berdasarkan hasil pengkajian.
- Merancang dan mengimplementasikan intervensi keperawatan secara efektif.
- Mengevaluasi hasil intervensi keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus secara periodik.
- Berkolaborasi dengan keluarga dan tim kesehatan lainnya untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak dengan kebutuhan khusus.

Pendahuluan

Anak dengan kebutuhan khusus merupakan individu yang memiliki berbagai keterbatasan fisik, intelektual, emosional, atau sosial yang membutuhkan perhatian dan asuhan kesehatan secara khusus dibandingkan anak pada umumnya. Anak-anak ini menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta dalam mencapai tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Sebagai tenaga kesehatan profesional, perawat memiliki peran penting dalam memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif dan individual yang mampu mendukung tumbuh kembang serta meningkatkan kualitas hidup anak dengan kebutuhan khusus. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai konsep dasar dan prinsip asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus menjadi sangat penting bagi perawat anak.

A. Definisi dan Karakteristik Anak dengan Kebutuhan Khusus

Anak dengan kebutuhan khusus adalah individu yang memiliki kondisi atau gangguan tertentu yang secara signifikan memengaruhi kemampuan mereka dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari dibandingkan anak-anak lain seusianya. Kondisi ini bisa berupa kelainan fisik, keterbatasan mental, tantangan sensorik, hambatan dalam pembelajaran, atau gangguan kesehatan kronis yang menyebabkan anak memerlukan pendekatan dan dukungan khusus agar mereka dapat mencapai tumbuh kembang secara optimal. Secara lebih mendalam, definisi ini menekankan pada kebutuhan akan intervensi spesifik yang berbeda dari anak pada umumnya karena kondisi yang mereka alami tidak memungkinkan mereka berpartisipasi secara penuh dan mandiri dalam berbagai aktivitas rutin tanpa adanya bantuan tambahan.

Anak dengan kebutuhan khusus biasanya memperlihatkan beberapa karakteristik umum yang menjadi ciri khas dari kondisi mereka. Karakteristik ini meliputi adanya keterlambatan dalam berbagai aspek perkembangan, seperti perkembangan motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional. Anak tersebut mungkin mengalami kesulitan dalam mencapai tahapan perkembangan yang seharusnya dicapai oleh anak lain dalam rentang usia yang sama. Sebagai contoh, seorang anak dengan kebutuhan khusus mungkin terlambat dalam berbicara atau berjalan dibandingkan teman-temannya.

Selain itu, anak-anak ini juga sering mengalami tantangan dalam komunikasi yang efektif. Mereka mungkin memiliki kesulitan mengekspresikan perasaan, kebutuhan, atau keinginan secara verbal maupun nonverbal. Kesulitan komunikasi ini dapat bervariasi, mulai dari anak yang hanya mengalami keterlambatan bicara ringan hingga anak dengan kondisi yang lebih serius seperti gangguan spektrum autisme, yang sering kali mengalami hambatan signifikan dalam interaksi sosial dan komunikasi dua arah.

Anak dengan kebutuhan khusus juga sering menghadapi tantangan emosional dan sosial yang signifikan. Mereka mungkin lebih rentan terhadap stres, kecemasan, depresi, atau kesulitan dalam mengatur emosi mereka sendiri. Karena perbedaan ini, mereka bisa merasa terisolasi dari teman-temannya dan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan pertemanan. Hal ini dapat diperparah oleh stigma atau ketidakpahaman lingkungan terhadap kondisi mereka, sehingga menyebabkan mereka semakin menjauh atau menarik diri dari interaksi sosial.

Lebih jauh lagi, anak-anak dengan kebutuhan khusus biasanya memiliki kebutuhan perawatan medis yang berkelanjutan. Kondisi ini mengharuskan mereka rutin mendapatkan pemantauan kesehatan, terapi khusus, atau bahkan perawatan medis yang intensif. Misalnya, anak dengan penyakit kronis seperti epilepsi atau

diabetes memerlukan pengelolaan yang ketat dan terencana dengan baik, agar kondisi kesehatannya tetap stabil dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari serta proses belajarnya.

Dengan demikian, memahami karakteristik anak dengan kebutuhan khusus secara menyeluruh merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memberikan intervensi yang tepat dan efektif. Melalui pemahaman ini, tenaga kesehatan, pendidik, dan keluarga dapat lebih baik dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik masing-masing anak, serta menyediakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka secara maksimal. Dukungan ini akan membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk tumbuh menjadi individu yang mandiri dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat, meskipun mereka menghadapi berbagai keterbatasan atau tantangan yang unik.

B. Jenis-jenis Kebutuhan Khusus pada Anak

1. Gangguan fisik

Gangguan fisik merupakan kondisi yang menyebabkan keterbatasan atau hambatan dalam fungsi fisik dan motorik anak. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh masalah neurologis atau otot-tulang yang berdampak langsung terhadap kemampuan anak dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, duduk, berdiri, atau bahkan bergerak secara mandiri.

- a. Cerebral palsy (CP): Merupakan kondisi neurologis yang terjadi akibat kerusakan otak yang berlangsung sebelum, selama, atau sesaat setelah kelahiran. Cerebral palsy ditandai dengan gangguan motorik yang menyebabkan keterbatasan gerakan tubuh, gangguan koordinasi otot, kekakuan, atau bahkan gerakan-gerakan yang tidak terkendali. Anak dengan cerebral palsy biasanya memerlukan terapi fisik secara teratur untuk membantu meningkatkan mobilitas dan fungsi motoriknya.
- b. Distrofi otot: Adalah penyakit genetik progresif yang ditandai dengan melemahnya jaringan otot secara bertahap, yang menyebabkan anak semakin sulit melakukan gerakan dan aktivitas sehari-hari. Seiring waktu, kondisi ini menyebabkan anak kehilangan kekuatannya secara signifikan, sehingga membutuhkan bantuan alat bantu khusus seperti kursi roda atau alat bantu mobilitas lainnya untuk aktivitas harian.
- c. Spina bifida: Merupakan kelainan kongenital pada tabung saraf, yang ditandai oleh terbentuknya celah atau lubang pada tulang belakang akibat perkembangan yang tidak sempurna saat masa kehamilan. Anak yang mengalami spina bifida umumnya memiliki gangguan mobilitas ekstremitas bawah, masalah kontrol kandung kemih dan usus, serta risiko infeksi dan

komplikasi lainnya. Mereka seringkali memerlukan intervensi bedah dan rehabilitasi yang intensif untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

2. Gangguan intelektual dan perkembangan

Gangguan intelektual dan perkembangan mengacu pada kondisi yang menyebabkan anak mengalami hambatan signifikan dalam kemampuan kognitif, bahasa, dan adaptasi terhadap lingkungan sosialnya. Anak-anak dengan gangguan ini biasanya memerlukan dukungan khusus dalam proses belajar dan interaksi sosial.

- a. Sindrom Down: Kondisi ini disebabkan oleh kelainan kromosom, di mana anak memiliki kelebihan kromosom 21 (trisomi 21). Sindrom Down menyebabkan keterlambatan dalam perkembangan fisik, intelektual, dan bahasa. Ciri khasnya mencakup bentuk wajah yang khas, kelainan jantung bawaan, serta gangguan perkembangan intelektual yang ringan hingga sedang. Anak dengan sindrom Down membutuhkan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan belajarnya.
- b. Autisme: Merupakan gangguan perkembangan yang mempengaruhi interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku anak secara signifikan. Anak autisme umumnya mengalami kesulitan dalam menjalin interaksi dua arah dengan orang lain, sulit memahami bahasa tubuh atau ekspresi emosi, serta memiliki pola perilaku yang repetitif dan terbatas minatnya. Intervensi seperti terapi perilaku dan terapi okupasi diperlukan untuk membantu mereka beradaptasi lebih baik dengan lingkungan sekitar.
- c. Retardasi mental (disabilitas intelektual): Kondisi ini ditandai dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata yang secara nyata mengganggu kemampuan adaptasi anak dalam kehidupan sehari-hari. Anak dengan retardasi mental mengalami kesulitan dalam memahami instruksi, mengambil keputusan sederhana, dan menguasai keterampilan hidup sehari-hari. Mereka memerlukan pendekatan pendidikan khusus, pendampingan intensif, serta pelatihan keterampilan hidup untuk mendukung kemandiriannya.

3. Gangguan emosional dan perilaku

Gangguan emosional dan perilaku meliputi kondisi yang mempengaruhi kemampuan anak dalam mengatur emosi dan tingkah lakunya dalam situasi sehari-hari. Anak-anak dengan gangguan ini memerlukan intervensi khusus untuk membantu mereka mengontrol perilaku serta mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang sehat.

- a. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder): Merupakan gangguan perkembangan yang ditandai dengan kesulitan anak dalam mempertahankan perhatian, hiperaktif (tidak bisa diam), dan impulsivitas yang tinggi. Anak dengan ADHD sering mengalami kesulitan mengikuti instruksi, mudah teralihkan, dan memiliki tantangan dalam menyelesaikan tugas sehari-hari baik

di sekolah maupun rumah. Penanganan berupa terapi perilaku dan pemberian obat-obatan khusus biasanya dibutuhkan.

- b. Gangguan kecemasan: Kondisi ini ditandai oleh rasa cemas yang berlebihan, ketakutan yang tidak rasional, atau kecemasan yang terus-menerus yang mengganggu aktivitas normal anak. Anak dengan gangguan kecemasan seringkali mengalami gejala fisik seperti sakit perut atau sakit kepala serta menghindari situasi sosial tertentu. Dukungan psikologis berupa konseling atau terapi perilaku kognitif menjadi metode yang penting untuk membantu mereka mengelola kecemasannya.
- c. Gangguan mood (seperti depresi atau gangguan bipolar): Gangguan ini menyebabkan perubahan suasana hati yang ekstrem, dari sangat sedih dan murung (depresi) hingga energi berlebihan dan impulsif (mania). Anak-anak ini memerlukan intervensi medis dan psikologis seperti terapi atau pengobatan untuk membantu menstabilkan suasana hati mereka serta mengelola emosi secara lebih efektif.

4. Gangguan sosial

Gangguan sosial ditandai oleh ketidakmampuan anak dalam berinteraksi secara efektif dengan orang lain atau lingkungan sekitarnya, yang secara signifikan menghambat kemampuan beradaptasi di lingkungan sosial.

Anak-anak dengan gangguan sosial memiliki kesulitan besar dalam memahami norma-norma sosial, membaca ekspresi wajah, bahasa tubuh, serta menjaga hubungan interpersonal. Kondisi ini bisa berdiri sendiri atau menyertai gangguan lain seperti autisme. Mereka sering kali menarik diri dari pergaulan, menunjukkan sikap yang tampak canggung atau tidak sesuai dalam interaksi sosial, dan merasa terisolasi dari teman-teman sebayanya.

Intervensi yang penting dalam gangguan sosial adalah melatih keterampilan sosial melalui terapi kelompok atau terapi individu dengan pendekatan khusus yang terstruktur, membantu anak belajar cara berkomunikasi dengan lebih efektif dan memahami bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.

C. Pengkajian Keperawatan pada Anak dengan Kebutuhan Khusus

Pengkajian keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus merupakan suatu langkah penting dan strategis dalam proses asuhan keperawatan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi secara jelas kondisi dan kebutuhan spesifik dari masing-masing anak. Pengkajian ini harus dilakukan secara komprehensif agar perawat dapat menyusun intervensi yang efektif dan tepat sasaran guna mendukung tumbuh kembang serta meningkatkan kualitas hidup anak tersebut secara optimal.

Proses pengkajian dimulai dengan pengumpulan riwayat kesehatan yang menyeluruh. Pada tahap ini, perawat perlu menggali informasi detail mengenai

riwayat prenatal, perinatal, serta riwayat penyakit masa lalu yang mungkin relevan dengan kondisi anak saat ini. Perawat juga harus mengeksplorasi riwayat keluarga, termasuk adanya kondisi genetik atau penyakit turunan, serta riwayat penggunaan obat-obatan atau intervensi medis sebelumnya. Informasi ini sangat berguna untuk memahami faktor-faktor risiko dan predisposisi yang berhubungan dengan kondisi kesehatan anak, serta menentukan intervensi keperawatan yang paling tepat.

Selanjutnya, perawat melakukan observasi langsung terhadap perilaku dan fisik anak. Observasi perilaku meliputi pengamatan terhadap respons emosional anak, pola interaksi sosial dengan teman sebaya atau keluarga, tingkat aktivitas fisik, serta kemampuan anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam observasi ini, perawat memperhatikan perilaku yang tampak khas atau tidak biasa, seperti perilaku repetitif, hiperaktivitas, impulsivitas, gangguan perhatian, atau tanda-tanda kecemasan maupun gangguan mood.

Observasi fisik mencakup pengkajian menyeluruh terhadap kondisi fisik anak, termasuk pemeriksaan status gizi, pemeriksaan tanda-tanda vital, evaluasi terhadap keterampilan motorik kasar dan halus, serta identifikasi adanya gangguan fisik tertentu seperti spastisitas otot, kelemahan otot, deformitas, atau gangguan koordinasi gerak. Pemeriksaan ini harus dilakukan dengan teliti dan mendetail agar perawat mendapatkan gambaran yang akurat mengenai keterbatasan fisik yang dialami anak serta kebutuhan perawatan khusus yang dibutuhkan.

Tahap berikutnya dalam pengkajian adalah melakukan pemeriksaan perkembangan anak. Perawat harus mengevaluasi secara cermat berbagai aspek perkembangan yang meliputi kemampuan motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional anak dibandingkan dengan standar perkembangan normal sesuai usia kronologisnya. Pada tahap ini, perawat harus memperhatikan secara seksama bila ada keterlambatan atau gangguan yang signifikan dalam pencapaian milestone perkembangan tertentu. Sebagai contoh, anak dengan gangguan perkembangan mungkin mengalami keterlambatan bicara atau kemampuan motorik halus seperti memegang pensil atau menyusun puzzle.

Dalam rangka meningkatkan akurasi pengkajian perkembangan, perawat dapat menggunakan berbagai instrumen atau alat pengkajian khusus yang telah tervalidasi, misalnya Denver Developmental Screening Test (DDST), M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers), atau instrumen lainnya yang sesuai dengan kondisi spesifik anak. Instrumen-instrumen ini memberikan data objektif tentang tingkat perkembangan anak sekaligus membantu perawat mengidentifikasi secara dini kemungkinan adanya gangguan perkembangan atau kebutuhan khusus lainnya.

Selain melakukan pengkajian secara langsung pada anak, perawat juga harus melakukan wawancara mendalam dengan orang tua atau pengasuh utama anak. Informasi yang didapatkan dari wawancara ini sangat berharga karena memberikan

gambaran lebih lengkap mengenai keseharian anak, perilaku anak di rumah, kebiasaan tidur dan makan, serta respons anak terhadap intervensi atau penanganan sebelumnya. Orang tua dan pengasuh juga merupakan sumber informasi penting terkait riwayat intervensi medis, terapi yang sudah atau sedang dijalani, serta harapan dan tantangan yang mereka alami dalam merawat anak dengan kebutuhan khusus tersebut.

Wawancara mendalam juga membantu perawat dalam menilai tingkat dukungan yang dimiliki keluarga, tingkat pengetahuan keluarga mengenai kondisi anak, serta kemampuan keluarga dalam mengelola kondisi tersebut secara mandiri. Dengan demikian, perawat tidak hanya mendapatkan informasi klinis, tetapi juga informasi psikososial yang esensial untuk menyusun rencana intervensi yang berpusat pada keluarga.

D. Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus merupakan bagian penting dari proses asuhan keperawatan yang bertujuan mengidentifikasi masalah atau kondisi spesifik yang dialami oleh anak, baik secara aktual maupun potensial. Diagnosis ini berfungsi sebagai dasar untuk menentukan prioritas intervensi, sehingga perawat dapat memberikan pelayanan yang tepat, efektif, serta sesuai dengan kondisi spesifik anak tersebut. Diagnosis umum meliputi:

1. Gangguan komunikasi verbal

Gangguan komunikasi verbal merupakan kondisi yang ditandai oleh ketidakmampuan atau hambatan anak dalam mengungkapkan kebutuhan, pikiran, perasaan, atau ide-idenya secara verbal, baik karena hambatan kognitif, gangguan neurologis, atau gangguan sensorik. Kondisi ini sering dijumpai pada anak dengan autisme, retardasi mental, atau gangguan perkembangan bicara dan bahasa. Anak yang mengalami gangguan ini biasanya menunjukkan tanda-tanda seperti kesulitan berbicara, ketidakjelasan dalam pengucapan kata-kata, sering salah mengartikan atau kesulitan memahami instruksi verbal, serta penggunaan bahasa tubuh yang tidak tepat. Kondisi ini menyebabkan anak frustrasi, mudah marah, atau menarik diri dari interaksi sosial, sehingga memerlukan intervensi komunikasi khusus seperti terapi wicara atau penggunaan komunikasi alternatif (misalnya bahasa isyarat atau kartu komunikasi visual).

2. Defisit perawatan diri

Defisit perawatan diri adalah diagnosis keperawatan yang menunjukkan bahwa anak mengalami hambatan atau ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri, seperti makan, berpakaian, mandi, atau buang air. Kondisi ini sering terjadi pada anak dengan gangguan fisik seperti cerebral palsy atau distrofi otot, serta pada anak dengan retardasi mental. Anak dengan diagnosis ini biasanya memperlihatkan kesulitan atau ketidakmampuan

untuk menjaga kebersihan diri, mengalami kesulitan dalam aktivitas makan dan minum, serta memerlukan bantuan atau pendampingan khusus dari orang tua atau pengasuh dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Penanganan kondisi ini melibatkan intervensi keperawatan berupa latihan keterampilan mandiri, adaptasi lingkungan, serta edukasi kepada orang tua atau pengasuh untuk membantu anak menjadi lebih mandiri secara bertahap.

3. Gangguan mobilitas fisik

Gangguan mobilitas fisik adalah kondisi di mana anak mengalami keterbatasan dalam melakukan gerakan tubuh secara bebas dan mandiri akibat gangguan neurologis, muskuloskeletal, atau gangguan koordinasi. Diagnosis ini umum dijumpai pada anak dengan cerebral palsy, spina bifida, atau distrofi otot. Anak yang mengalami gangguan mobilitas fisik biasanya mengalami hambatan dalam berjalan, duduk, berdiri, atau bahkan berpindah tempat secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan anak membutuhkan alat bantu mobilitas seperti kursi roda, walker, atau brace (alat bantu ortopedi). Perawat perlu memberikan intervensi berupa latihan fisik dan terapi rehabilitasi untuk meningkatkan kekuatan otot, koordinasi gerak, dan mobilitas anak secara optimal, serta edukasi bagi keluarga mengenai penggunaan alat bantu secara aman.

4. Gangguan interaksi sosial

Gangguan interaksi sosial merupakan diagnosis yang mencerminkan kesulitan anak dalam menjalin hubungan sosial atau beradaptasi secara efektif dengan lingkungan sosialnya. Kondisi ini sering ditemukan pada anak dengan autisme, ADHD, gangguan kecemasan, atau gangguan emosional lainnya. Anak dengan gangguan ini cenderung menunjukkan perilaku seperti menghindari kontak mata, tidak mampu memahami atau merespons isyarat sosial secara tepat, sulit berteman, atau bahkan menarik diri dari pergaulan. Kondisi ini sering kali menyebabkan anak merasa terisolasi dan kurang percaya diri dalam situasi sosial. Perawat perlu melakukan intervensi yang berfokus pada pelatihan keterampilan sosial, terapi kelompok, serta memberikan dukungan emosional kepada anak agar mampu menjalin hubungan yang positif dengan orang lain di sekitarnya.

5. Risiko cedera

Risiko cedera merupakan diagnosis keperawatan potensial yang mengindikasikan adanya kemungkinan anak mengalami kecelakaan atau cedera akibat gangguan motorik, gangguan sensorik, gangguan persepsi, atau ketidakmampuan memahami bahaya di sekitarnya. Kondisi ini sering muncul pada anak dengan keterbatasan fisik seperti cerebral palsy, keterlambatan perkembangan motorik, gangguan sensorik, atau anak dengan ADHD yang memiliki perilaku impulsif. Anak dengan risiko cedera biasanya kurang waspada terhadap lingkungan, kesulitan mengenali bahaya, atau tidak mampu melakukan tindakan perlindungan diri secara mandiri. Intervensi keperawatan yang penting

dilakukan meliputi edukasi keselamatan kepada orang tua atau pengasuh, modifikasi lingkungan untuk mengurangi risiko cedera, serta pengawasan ketat saat anak melakukan aktivitas sehari-hari.

E. Perencanaan dan Implementasi Intervensi Keperawatan

Perencanaan dan implementasi intervensi keperawatan merupakan langkah yang esensial dalam asuhan keperawatan anak dengan kebutuhan khusus. Tahap ini dilakukan setelah proses pengkajian dan penetapan diagnosis keperawatan selesai dilaksanakan. Tujuan utama perencanaan dan implementasi ini adalah memastikan anak dengan kebutuhan khusus mendapatkan asuhan yang tepat, spesifik, dan efektif, sehingga tumbuh kembang optimal dan kualitas hidup yang lebih baik dapat tercapai.

Tahap perencanaan dimulai dengan menyusun tujuan asuhan berdasarkan diagnosis keperawatan yang telah diidentifikasi. Tujuan ini harus spesifik, terukur, realistis, dapat dicapai dalam rentang waktu tertentu, dan sesuai dengan kondisi anak secara individual. Sebagai contoh, pada diagnosis gangguan komunikasi verbal, tujuan asuhan yang dirumuskan dapat berupa peningkatan kemampuan anak dalam mengungkapkan kebutuhannya melalui metode komunikasi alternatif, misalnya menggunakan gambar atau isyarat khusus dalam waktu tertentu. Penetapan tujuan yang jelas akan menjadi panduan bagi perawat dalam memilih dan mengimplementasikan intervensi yang paling tepat.

Setelah tujuan asuhan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memilih intervensi yang sesuai. Intervensi ini harus dipilih secara cermat berdasarkan prioritas masalah, kondisi spesifik anak, serta kemampuan keluarga dalam menjalankan intervensi tersebut. Penting untuk memastikan bahwa intervensi yang dipilih relevan dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Misalnya, jika diagnosis yang ditegakkan adalah gangguan mobilitas fisik, maka intervensi yang dipilih dapat mencakup latihan fisik yang dirancang khusus oleh tim terapi rehabilitasi atau fisioterapis, disesuaikan dengan tingkat kemampuan motorik anak serta tujuan mobilitas yang diharapkan.

Pada tahap perencanaan ini, perawat juga wajib melibatkan keluarga secara aktif. Peran serta keluarga sangat penting karena mereka merupakan sumber dukungan utama dalam pelaksanaan intervensi sehari-hari. Perawat harus memastikan keluarga memahami kondisi anak, intervensi yang akan dilakukan, serta manfaat dari intervensi tersebut. Edukasi kepada keluarga harus mencakup teknik-teknik spesifik yang dapat diterapkan sehari-hari di rumah, bagaimana memberikan motivasi kepada anak, serta bagaimana mengevaluasi kemajuan anak secara berkala. Partisipasi aktif keluarga ini akan meningkatkan keberhasilan intervensi secara signifikan, karena anak mendapatkan dukungan konsisten dari lingkungan terdekatnya.

Setelah tahap perencanaan disusun secara rinci, maka tahap selanjutnya adalah implementasi intervensi. Implementasi meliputi berbagai aktivitas yang harus dilakukan secara teratur, konsisten, dan terukur, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Salah satu implementasi utama yang sering dilakukan adalah latihan fisik. Latihan fisik berperan dalam meningkatkan kemampuan motorik anak, meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas, dan koordinasi gerakan. Latihan ini harus dilakukan secara rutin dan bertahap sesuai kemampuan anak. Misalnya, anak dengan cerebral palsy mungkin memerlukan latihan fisik intensif yang berfokus pada peningkatan kontrol otot dan koordinasi, sehingga mampu melakukan aktivitas dasar seperti duduk, berdiri, atau berjalan secara mandiri dengan bantuan alat bantu jika diperlukan.

Selain latihan fisik, stimulasi perkembangan juga menjadi implementasi penting dalam asuhan keperawatan anak dengan kebutuhan khusus. Stimulasi perkembangan bertujuan merangsang perkembangan kognitif, sosial, bahasa, dan motorik anak secara optimal. Intervensi ini bisa berupa permainan edukatif, stimulasi sensorik, latihan kognitif sederhana, serta aktivitas interaksi sosial yang terstruktur. Misalnya, pada anak dengan autisme, stimulasi sosial yang rutin melalui permainan kelompok kecil dapat membantu meningkatkan kemampuan interaksi sosial dan komunikasi anak secara bertahap.

Implementasi selanjutnya adalah manajemen perilaku. Manajemen perilaku bertujuan membantu anak mengelola perilaku yang maladaptif atau tidak sesuai, seperti perilaku agresif, tantrum, hiperaktivitas, atau perilaku repetitif. Strategi manajemen perilaku mencakup intervensi seperti penguatan positif, teknik time-out, pembiasaan rutinitas yang konsisten, serta pendekatan terapeutik yang terstruktur. Perawat bekerja sama dengan keluarga dalam menerapkan strategi ini agar anak dapat belajar mengontrol emosinya secara lebih efektif serta memperbaiki pola perilakunya.

Selanjutnya, terapi komunikasi juga menjadi komponen penting dalam implementasi intervensi keperawatan. Terapi komunikasi ditujukan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. Anak dengan gangguan komunikasi verbal, seperti autisme atau retardasi mental, dapat memanfaatkan intervensi ini secara efektif. Metode yang digunakan dapat berupa terapi wicara, penggunaan alat bantu komunikasi seperti gambar atau kartu visual, bahasa isyarat, atau perangkat komunikasi alternatif berbasis teknologi yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Terakhir, edukasi kepada keluarga merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari implementasi intervensi keperawatan. Edukasi ini bertujuan agar keluarga memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang tepat dalam merawat anak sehari-hari. Dalam proses edukasi, perawat memberikan penjelasan

terperinci mengenai kondisi anak, pentingnya intervensi, teknik-teknik spesifik dalam menjalankan intervensi di rumah, serta cara melakukan pemantauan kemajuan anak secara berkala. Edukasi yang baik akan memberdayakan keluarga agar mampu memberikan dukungan optimal bagi anak, meningkatkan kepercayaan diri keluarga dalam menjalani perannya, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak.

F. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana intervensi yang telah diberikan mampu memberikan dampak positif, serta mengukur pencapaian tujuan perawatan yang telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi ini sangat penting dilakukan secara berkala agar perawat dapat menentukan apakah intervensi tersebut efektif atau perlu dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan spesifik anak, serta memastikan bahwa asuhan keperawatan tetap relevan dan optimal seiring perkembangan kondisi anak.

Tahap evaluasi diawali dengan pengamatan atau observasi langsung terhadap anak selama dan setelah intervensi diberikan. Observasi langsung ini mencakup penilaian terhadap perubahan perilaku, kemampuan fisik, keterampilan komunikasi, interaksi sosial, dan kemampuan perawatan diri anak. Misalnya, pada anak yang mengalami gangguan mobilitas fisik, perawat akan mengamati apakah terdapat peningkatan dalam kemampuan bergerak atau melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, duduk, atau menggunakan alat bantu mobilitas secara lebih mandiri. Demikian pula pada anak dengan gangguan komunikasi verbal, perawat akan mengamati secara langsung kemampuan anak dalam menggunakan komunikasi alternatif, seperti isyarat atau gambar, untuk menyampaikan kebutuhannya secara lebih efektif.

Selain observasi langsung terhadap anak, perawat juga harus secara aktif mengumpulkan laporan atau umpan balik dari keluarga atau pengasuh utama. Informasi dari keluarga sangat berharga karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dan paling sering berinteraksi dengan anak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses ini, keluarga akan diminta menjelaskan perubahan yang mereka amati pada anak, termasuk respons anak terhadap intervensi yang telah dilakukan di rumah, hambatan yang mereka hadapi dalam menjalankan intervensi, serta sejauh mana keluarga merasa terbantu oleh asuhan keperawatan yang diberikan. Informasi ini memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat mengenai efektivitas intervensi di lingkungan rumah, serta membantu perawat memahami secara lebih dalam faktor-faktor pendukung atau hambatan yang mungkin mempengaruhi hasil intervensi.

Evaluasi keperawatan juga melibatkan penggunaan instrumen atau alat ukur khusus yang telah tervalidasi untuk menilai secara objektif kemajuan anak dalam berbagai aspek perkembangan. Instrumen-instrumen tersebut bisa berupa skala perkembangan motorik seperti Gross Motor Function Measure (GMFM), skala komunikasi seperti Childhood Autism Rating Scale (CARS), atau alat evaluasi perkembangan secara umum seperti Denver Developmental Screening Test (DDST). Penggunaan instrumen ini memungkinkan perawat mengukur secara objektif kemajuan anak dari waktu ke waktu, sehingga hasil evaluasi tidak hanya berdasarkan persepsi atau pengamatan subjektif semata, tetapi didukung data empiris yang dapat dipercaya.

Dalam pelaksanaan evaluasi, hasil yang didapatkan harus dibandingkan dengan tujuan perawatan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan sebelumnya. Hal ini penting untuk menentukan apakah tujuan tersebut sudah tercapai, tercapai sebagian, atau belum tercapai sama sekali. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa tujuan perawatan telah tercapai, maka perawat dapat melanjutkan atau mempertahankan intervensi tersebut sambil menetapkan tujuan baru yang lebih tinggi atau kompleks sesuai perkembangan anak. Namun, jika evaluasi menunjukkan tujuan belum sepenuhnya tercapai, perawat perlu menganalisis lebih lanjut penyebabnya, apakah karena intervensi yang kurang tepat, implementasi yang tidak konsisten, atau adanya hambatan lain seperti kurangnya dukungan keluarga. Setelah mengidentifikasi penyebab tersebut, perawat harus segera melakukan penyesuaian atau modifikasi intervensi agar lebih sesuai dengan kondisi aktual anak.

Evaluasi keperawatan harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, dengan interval waktu yang teratur—misalnya setiap bulan atau setiap tiga bulan, tergantung kondisi dan kebutuhan anak. Evaluasi yang teratur akan membantu perawat dalam melakukan monitoring kemajuan anak secara konsisten, memastikan setiap perubahan kecil maupun besar dapat segera teridentifikasi, dan memungkinkan perawat untuk secara dinamis melakukan penyesuaian intervensi seiring berkembangnya kebutuhan anak.

G. Kolaborasi Multidisiplin

Kolaborasi multidisiplin merupakan suatu pendekatan yang melibatkan berbagai tenaga profesional dari berbagai bidang keahlian untuk bekerja sama dalam memberikan asuhan yang komprehensif, holistik, dan terintegrasi kepada anak dengan kebutuhan khusus. Anak dengan kebutuhan khusus memiliki kondisi yang kompleks dan multifaset, sehingga tidak mungkin hanya ditangani oleh satu disiplin ilmu saja. Oleh karena itu, kolaborasi antarprofesional ini sangat diperlukan guna memastikan bahwa seluruh aspek kebutuhan anak dapat terpenuhi secara

optimal, serta mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial.

Salah satu tenaga profesional yang memiliki peran penting dalam tim kolaborasi multidisiplin adalah dokter spesialis anak. Dokter spesialis anak bertanggung jawab atas diagnosis medis, menentukan pengobatan atau terapi yang tepat, serta melakukan pemantauan kondisi fisik dan medis anak secara berkelanjutan. Dalam konteks anak dengan kebutuhan khusus, dokter spesialis anak biasanya berperan sebagai koordinator dalam pengelolaan medis dan klinis anak, serta memastikan bahwa intervensi medis yang dilakukan dapat bersinergi dengan intervensi lain yang diberikan oleh anggota tim multidisiplin lainnya.

Selanjutnya, peran terapis okupasi juga sangat penting dalam tim multidisiplin ini. Terapis okupasi bertanggung jawab untuk membantu anak dalam mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makan, berpakaian, mandi, hingga keterampilan bermain dan belajar secara mandiri. Terapis okupasi memberikan intervensi yang bertujuan meningkatkan kemampuan motorik halus, koordinasi tangan-mata, persepsi sensorik, serta kemandirian anak dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Mereka juga mendukung anak dalam mengembangkan adaptasi terhadap lingkungan melalui berbagai aktivitas terapeutik yang disesuaikan dengan kebutuhan individu anak.

Fisioterapis memiliki peran penting dalam membantu anak meningkatkan kemampuan motorik kasar, kekuatan otot, keseimbangan, koordinasi gerak, serta mobilitas secara umum. Melalui latihan fisik terstruktur dan terencana, fisioterapis membantu anak untuk dapat bergerak dengan lebih efektif dan aman, baik secara mandiri maupun dengan bantuan alat bantu mobilitas. Misalnya, pada anak dengan cerebral palsy atau distrofi otot, fisioterapis berperan dalam menyusun program latihan rutin yang bertujuan meningkatkan fungsi fisik anak dan mencegah komplikasi lebih lanjut akibat imobilitas.

Psikolog merupakan tenaga profesional yang memiliki peran krusial dalam mengevaluasi aspek emosional, perilaku, sosial, serta perkembangan kognitif anak. Psikolog membantu anak dengan kebutuhan khusus dalam mengatasi tantangan emosional seperti kecemasan, depresi, stres, maupun masalah perilaku seperti agresivitas atau impulsivitas. Intervensi yang diberikan oleh psikolog bisa berupa terapi perilaku, terapi kognitif, konseling keluarga, hingga dukungan psikososial secara luas. Psikolog juga memberikan edukasi kepada keluarga untuk membantu mereka memahami kondisi psikologis anak serta meningkatkan dukungan emosional di lingkungan rumah.

Selain psikolog, konselor juga berperan penting dalam memberikan dukungan psikososial, baik kepada anak maupun keluarga. Konselor membantu keluarga memahami kondisi anak secara mendalam, memberikan motivasi, serta membantu mereka menemukan solusi praktis dalam menghadapi berbagai tantangan dalam

merawat anak dengan kebutuhan khusus sehari-hari. Konselor juga mendampingi keluarga dalam mengatasi stres atau tekanan emosional yang sering muncul akibat kondisi anak, sehingga keluarga dapat tetap sehat secara emosional, harmonis, serta mampu memberikan dukungan terbaik bagi anak.

Ahli gizi merupakan bagian penting dari tim kolaborasi multidisiplin yang bertugas mengatur kebutuhan nutrisi anak secara optimal sesuai kondisi kesehatannya. Anak dengan kebutuhan khusus seringkali mengalami masalah nutrisi seperti kesulitan makan, gangguan metabolisme, atau kebutuhan diet khusus yang berkaitan dengan kondisi medis tertentu. Ahli gizi bertugas menyusun pola makan dan diet yang spesifik, memonitor status gizi anak, serta memberikan edukasi kepada keluarga mengenai cara menyiapkan makanan yang sesuai dengan kebutuhan khusus anak. Nutrisi yang optimal sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak secara maksimal.

Selain para profesional tersebut, tim pendukung lain yang juga berperan penting dalam kolaborasi multidisiplin meliputi terapis wicara yang membantu anak dalam meningkatkan kemampuan komunikasi verbal atau nonverbal, pekerja sosial yang membantu dalam hal integrasi sosial, serta guru pendidikan khusus yang bertanggung jawab dalam membantu anak mencapai tujuan akademik dan kemampuan belajar sesuai dengan potensinya. Peran masing-masing anggota tim ini harus saling melengkapi dan terkoordinasi dengan baik agar tercipta sinergi yang optimal.

Komunikasi dan koordinasi yang teratur antaranggota tim menjadi kunci sukses dalam pendekatan multidisiplin ini. Seluruh anggota tim harus rutin melakukan pertemuan untuk mengevaluasi kemajuan anak, mendiskusikan hambatan yang dihadapi, serta menyusun strategi bersama untuk intervensi selanjutnya. Dalam pertemuan tim multidisiplin ini, setiap anggota tim dapat memberikan masukan, berdiskusi secara terbuka, serta menyelaraskan langkah agar asuhan yang diberikan bersifat koheren, efektif, dan sesuai kebutuhan spesifik anak.

H. Latihan Soal

Kasus 1

Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun dibawa ibunya ke klinik dengan keluhan sulit berkomunikasi secara verbal. Menurut ibu, anak belum bisa mengucapkan kata-kata yang jelas, hanya menggumam atau menunjuk jika menginginkan sesuatu. Anak sering marah dan menangis karena frustrasi saat tidak dipahami keinginannya.

Diagnosis keperawatan apakah yang paling tepat pada kasus ini?

- A. Defisit perawatan diri
- B. Gangguan komunikasi verbal
- C. Risiko cedera
- D. Gangguan interaksi sosial

E. Gangguan mobilitas fisik

Kunci Jawaban: B. Gangguan komunikasi verbal

Rasional:

Jawaban B benar karena keluhan utama pada kasus ini adalah kesulitan anak dalam berkomunikasi secara verbal, terbukti dari ketidakmampuannya mengungkapkan keinginan dan emosi melalui kata-kata. Pilihan A kurang tepat karena tidak ada informasi yang menunjukkan kesulitan dalam perawatan diri. Pilihan C kurang tepat karena tidak ada perilaku berisiko cedera yang menonjol. Pilihan D kurang tepat karena tidak dijelaskan secara spesifik mengenai gangguan dalam interaksi sosial anak. Pilihan E kurang tepat karena tidak ada gangguan fisik atau mobilitas yang dialami anak.

Kasus 2

Seorang anak perempuan berusia 10 tahun didiagnosis cerebral palsy sejak lahir. Ia datang ke klinik didampingi ibunya yang mengeluhkan anaknya sulit berpindah tempat secara mandiri, tidak bisa berdiri tanpa bantuan, serta mengalami kekakuan otot yang menyebabkan kesulitan dalam aktivitas sehari-hari.

Diagnosis keperawatan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut?

- A. Gangguan interaksi sosial
- B. Gangguan komunikasi verbal
- C. Gangguan mobilitas fisik
- D. Defisit perawatan diri
- E. Risiko cedera

Kunci Jawaban: C. Gangguan mobilitas fisik

Rasional:

Jawaban C benar karena masalah utama pada kasus ini adalah hambatan dalam mobilitas fisik akibat kekakuan otot yang khas pada cerebral palsy. Pilihan A tidak tepat karena tidak ada keluhan utama mengenai interaksi sosial. Pilihan B tidak tepat karena tidak ada gangguan komunikasi verbal yang dilaporkan. Pilihan D memang mungkin muncul tetapi masalah utama adalah keterbatasan mobilitas. Pilihan E ada risiko cedera namun bukan diagnosis utama.

Kasus 3

Seorang anak perempuan berusia 8 tahun didiagnosis sindrom Down. Orang tuanya melaporkan bahwa anak kesulitan mandi, makan sendiri, dan berpakaian. Anak membutuhkan bantuan penuh dari orang tua untuk kegiatan sehari-hari.

Diagnosis keperawatan yang paling tepat pada kasus tersebut adalah:

- A. Gangguan komunikasi verbal
- B. Defisit perawatan diri
- C. Risiko cedera

D. Gangguan interaksi sosial

E. Gangguan mobilitas fisik

Kunci Jawaban: B. Defisit perawatan diri

Rasional:

Jawaban B benar karena jelas bahwa anak mengalami hambatan dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri akibat hambatan intelektual dari sindrom Down. Pilihan A tidak tepat karena tidak disebutkan hambatan spesifik komunikasi. Pilihan C, meski mungkin ada, bukan menjadi prioritas utama saat ini. Pilihan D tidak tepat karena tidak ada keluhan utama terkait interaksi sosial. Pilihan E tidak tepat karena tidak ada hambatan mobilitas yang spesifik disebutkan.

Kasus 4

Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun datang ke klinik ditemani ibunya. Anak sering tampak gelisah, sulit berkonsentrasi, sering berjalan-jalan tanpa tujuan, tidak bisa duduk diam di kelas, serta sulit menyelesaikan tugas sekolah yang sederhana. Orang tua merasa kesulitan mengontrol perilaku anak sehari-hari.

Diagnosis keperawatan utama apakah yang paling tepat pada kasus ini?

A. Gangguan mobilitas fisik

B. Gangguan interaksi sosial

C. Gangguan emosional dan perilaku (ADHD)

D. Gangguan komunikasi verbal

E. Risiko cedera

Kunci Jawaban: C. Gangguan emosional dan perilaku (ADHD)

Rasional:

Jawaban C benar karena gejala-gejala utama yang ditampilkan anak ini mencerminkan gejala klasik ADHD berupa hiperaktivitas, impulsivitas, dan kesulitan konsentrasi. Pilihan A tidak tepat karena tidak ada gangguan fisik atau mobilitas. Pilihan B kurang tepat karena fokus utama adalah perilaku hiperaktif dan impulsif bukan interaksi sosialnya. Pilihan D kurang tepat karena tidak disebutkan gangguan verbal spesifik. Pilihan E bisa ada namun diagnosis utama tetap ADHD.

Kasus 5

Seorang anak perempuan berusia 9 tahun dibawa ibunya ke klinik karena sering menghindari bermain bersama teman-temannya, tampak tidak nyaman dalam interaksi sosial, menghindari kontak mata, serta sulit memahami ekspresi wajah dan isyarat sosial dari orang lain.

Diagnosis keperawatan apakah yang paling tepat untuk anak tersebut?

A. Gangguan mobilitas fisik

B. Gangguan komunikasi verbal

C. Risiko cedera

D. Gangguan interaksi sosial

E. Defisit perawatan diri

Kunci Jawaban: D. Gangguan interaksi sosial

Rasional:

Jawaban D benar karena keluhan utama adalah kesulitan signifikan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Ia menghindari kontak mata, tidak mampu membaca ekspresi wajah, dan menarik diri dari pergaulan. Pilihan A tidak tepat karena tidak ada hambatan fisik atau mobilitas. Pilihan B kurang tepat karena tidak disebutkan kesulitan komunikasi verbal secara khusus. Pilihan C tidak relevan karena tidak ada risiko cedera yang khusus. Pilihan E tidak tepat karena anak tidak mengalami hambatan dalam perawatan diri yang dilaporkan.

I. Rangkuman Materi

Anak dengan kebutuhan khusus adalah individu yang memiliki gangguan fisik, intelektual, emosional, perilaku, atau sosial yang secara signifikan memengaruhi kemampuannya dalam aktivitas sehari-hari dan tumbuh kembangnya dibandingkan anak-anak seusianya. Karakteristik umum anak dengan kebutuhan khusus meliputi keterlambatan perkembangan, hambatan komunikasi, kesulitan interaksi sosial, gangguan emosi, serta kebutuhan perawatan medis dan dukungan khusus secara berkelanjutan.

Jenis kebutuhan khusus yang sering ditemukan meliputi gangguan fisik seperti cerebral palsy, distrofi otot, dan spina bifida; gangguan intelektual seperti sindrom Down, autisme, dan retardasi mental; gangguan emosional dan perilaku seperti ADHD, kecemasan, dan gangguan mood; serta gangguan sosial yang menyebabkan anak kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Untuk memberikan asuhan keperawatan yang tepat, perawat perlu melakukan pengkajian yang komprehensif meliputi riwayat kesehatan anak, observasi langsung terhadap kondisi fisik dan perilaku, evaluasi perkembangan menggunakan instrumen khusus, serta wawancara mendalam dengan keluarga atau pengasuh utama. Diagnosis keperawatan utama yang sering diidentifikasi adalah gangguan komunikasi verbal, defisit perawatan diri, gangguan mobilitas fisik, gangguan interaksi sosial, dan risiko cedera.

Perencanaan dan implementasi intervensi keperawatan mencakup tujuan yang jelas berdasarkan diagnosis keperawatan yang ditegakkan, serta melibatkan keluarga secara aktif. Implementasi ini terdiri dari latihan fisik, stimulasi perkembangan, manajemen perilaku, terapi komunikasi, serta edukasi kepada keluarga untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam merawat anak sehari-hari.

Evaluasi keperawatan dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas intervensi dan pencapaian tujuan yang telah direncanakan, dengan metode observasi langsung, laporan keluarga, serta instrumen evaluasi khusus yang objektif.

Kolaborasi multidisiplin yang melibatkan dokter spesialis anak, terapis okupasi, fisioterapis, psikolog, konselor, ahli gizi, terapis wicara, pekerja sosial, dan guru pendidikan khusus sangat penting untuk memberikan pelayanan yang holistik, terintegrasi, serta maksimal dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dan meningkatkan kualitas hidup mereka serta keluarga.

J. Glosarium

Anak dengan kebutuhan khusus: Individu yang memiliki kondisi atau gangguan tertentu yang secara signifikan memengaruhi kemampuan mereka dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari, sehingga membutuhkan intervensi dan dukungan khusus agar tumbuh kembangnya optimal.

Autisme: Gangguan perkembangan yang ditandai dengan kesulitan dalam interaksi sosial, komunikasi verbal dan nonverbal, serta perilaku repetitif yang terbatas minatnya.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): Gangguan perkembangan yang menyebabkan kesulitan dalam mempertahankan perhatian, hiperaktivitas, serta impulsivitas yang tinggi.

Cerebral palsy (CP): Kondisi neurologis akibat kerusakan otak yang menyebabkan gangguan motorik, seperti kekakuan otot, gangguan koordinasi, dan gerakan-gerakan tidak terkendali.

Defisit perawatan diri: Kondisi di mana anak mengalami hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, seperti makan, mandi, berpakaian, atau buang air.

Diagnosis keperawatan: Penilaian klinis yang dilakukan perawat untuk mengidentifikasi masalah kesehatan aktual atau potensial yang menjadi dasar pemberian intervensi keperawatan.

Distrofi otot: Penyakit genetik progresif yang menyebabkan pelemahan jaringan otot secara bertahap, sehingga anak kehilangan kemampuan motorik secara signifikan.

Evaluasi keperawatan: Proses sistematis dan berkelanjutan untuk menilai efektivitas intervensi keperawatan dan pencapaian tujuan perawatan yang telah ditentukan.

Gangguan emosional dan perilaku: Kondisi yang mengganggu kemampuan anak dalam mengatur emosi dan perilaku dalam aktivitas sehari-hari, seperti ADHD, gangguan kecemasan, dan gangguan mood (depresi atau bipolar).

Gangguan interaksi sosial: Kondisi di mana anak mengalami kesulitan signifikan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, seperti sulit memahami norma sosial dan menunjukkan sikap menarik diri dari pergaulan.

Gangguan komunikasi verbal: Hambatan dalam kemampuan anak untuk menyampaikan pikiran, kebutuhan, atau perasaan secara verbal, baik karena gangguan neurologis, kognitif, atau sensorik.

Gangguan mood: Kondisi emosional yang menyebabkan perubahan suasana hati ekstrem, seperti depresi (kesedihan yang berkepanjangan) atau mania (kegembiraan berlebihan).

Gangguan kecemasan: Kondisi emosional yang ditandai oleh rasa cemas, khawatir, atau ketakutan berlebihan yang mengganggu aktivitas anak.

Hambatan pembelajaran: Kesulitan atau keterlambatan anak dalam proses belajar yang signifikan dibandingkan teman seusianya, memerlukan dukungan pendidikan khusus.

Intervensi keperawatan: Tindakan keperawatan yang direncanakan secara spesifik untuk mengatasi masalah atau diagnosis keperawatan yang dialami anak.

Kolaborasi multidisiplin: Pendekatan kerja sama antar berbagai profesional dari disiplin ilmu berbeda, seperti dokter spesialis anak, terapis okupasi, fisioterapis, psikolog, konselor, ahli gizi, terapis wicara, pekerja sosial, dan guru pendidikan khusus, untuk memberikan asuhan yang holistik dan komprehensif.

Observasi perilaku: Proses mengamati secara langsung perilaku anak untuk mengidentifikasi pola-pola atau gejala tertentu yang dapat menunjukkan kondisi atau gangguan tertentu.

Observasi fisik: Pengkajian secara langsung terhadap kondisi fisik anak, termasuk tanda-tanda vital, status gizi, dan kemampuan motorik anak.

Retardasi mental (Disabilitas intelektual): Kondisi di mana anak memiliki tingkat intelektual di bawah rata-rata yang secara signifikan memengaruhi kemampuan adaptasi dalam kehidupan sehari-hari.

Risiko cedera: Diagnosis keperawatan potensial yang menunjukkan kemungkinan anak mengalami cedera akibat gangguan sensorik, motorik, persepsi, atau kesulitan mengenali bahaya di lingkungannya.

Sindrom Down: Kelainan kromosom akibat kelebihan kromosom 21 (trisomi 21) yang menyebabkan keterlambatan dalam perkembangan fisik, intelektual, dan bahasa, serta ciri fisik yang khas.

Spina bifida: Kelainan kongenital yang ditandai oleh adanya celah atau lubang pada tulang belakang akibat tidak sempurnanya perkembangan tabung saraf, menyebabkan gangguan mobilitas ekstremitas bawah, gangguan kontrol kandung kemih dan usus, serta komplikasi medis lainnya.

Stimulasi perkembangan: Intervensi untuk merangsang dan mendukung perkembangan anak dalam aspek motorik, kognitif, sosial-emosional, dan bahasa, melalui aktivitas edukatif yang terstruktur.

Tantangan sensorik: Kesulitan anak dalam memproses dan merespons rangsangan sensorik dari lingkungan sekitar, yang menyebabkan hambatan dalam aktivitas sehari-hari.

Terapi fisik: Intervensi rehabilitasi berupa latihan fisik yang bertujuan meningkatkan kekuatan otot, keseimbangan, koordinasi, dan kemampuan mobilitas anak.

Terapi okupasi: Terapi yang berfokus membantu anak dalam mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makan, berpakaian, dan bermain, untuk mencapai kemandirian yang optimal.

Terapi komunikasi: Intervensi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi anak, baik secara verbal maupun nonverbal, seperti terapi wicara, bahasa isyarat, atau alat komunikasi alternatif.

K. Daftar Pustaka

- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). American Psychiatric Publishing.
- Batshaw, M. L., Roizen, N. J., & Lotrecchiano, G. R. (2019). Children with disabilities (8th ed.). Paul H. Brookes Publishing Co.
- Dewi, Y. I., & Azizah, L. M. (2021). Asuhan keperawatan pada anak berkebutuhan khusus. Salemba Medika.
- Hockenberry, M. J., Wilson, D., & Rodgers, C. C. (2018). Wong's essentials of pediatric nursing (10th ed.). Elsevier Mosby.
- Kozier, B., Erb, G., Berman, A., Snyder, S. J., Frandsen, G., & Buck, M. (2020). Fundamentals of nursing: Concepts, process, and practice (11th ed.). Pearson Education.
- Lerner, J. W., & Johns, B. H. (2014). Learning disabilities and related mild disabilities: Characteristics, teaching strategies, and new directions (13th ed.). Cengage Learning.
- Marlow, D. R., & Redding, B. A. (2016). Textbook of pediatric nursing (8th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Potts, N. L., & Mandleco, B. L. (2017). Pediatric nursing: Caring for children and their families (3rd ed.). Cengage Learning.
- Santrock, J. W. (2021). Child development (15th ed.). McGraw-Hill Education.
- Wong, D. L., & Whaley, L. F. (2019). Wong's nursing care of infants and children (11th ed.). Mosby Elsevier.

PROFIL PENULIS



Dorce Sisfiani Sarimin, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An. lahir di Kalawara 13 April 1975. Lulusan Magister Keperawatan dan Ners Spesialis Keperawatan Anak Universitas Indonesia Jakarta, tahun 2013. Bekerja di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado Jurusan Keperawatan. Sebagai dosen sejak tahun 2000 dan pada tahun 2014 - 2018 menjabat sebagai Kaprodi D-III Keperawatan, 2018- sampai sekarang menjabat sebagai Kaprodi Sarjana terapan Keperawatan Ners. Adapun Buku yang pernah diterbitkan adalah Dukungan keluarga pada Imunisasi Anak, Konsep Keperawatan Anak dan Buku Ajar keperawatan anak 1, Home Care, Bunga Rampai Keperawatan Anak I, Bunga Rampai Keperawatan anak 2, dan Konsep Caring pengalaman publikasi internasional dan nasional dalam area keperawatan anak baik pada jurnal bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi sinta. Pengalaman organisasi sebagai anggota perinasia sejak tahun 2012, organisasi IPANI : sebagai bendahara Tahun 2014 - 2017, Sebagai Koordinator pendidikan dan pelatihan 2017-2022 dan 2023 sampai sekarang sebagai Wakil Ketua bidang organisasi, Hukum dan Sistem Informasi. Pengurus AIPNI regional 8 bidang pendayagunaan lulusan dan Uji Kompetensi tahun 2022 sampai sekarang



Devi Harmita, S.Tr., Ners., M.Kep Lahir di Ujung Pandang, 01 Januari 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada program studi Keperawatan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan Ners pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Padjadjaran Bandung dan lulus pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2020 sebagai Perawat Pelaksana di ruang operasi di Rumah Sakit EMC Tangerang. Saat ini penulis bekerja di Universitas Tanjungpura Pontianak mengampu mata kuliah Keperawatan Anak, Keperawatan Maternitas, dan Keperawatan Medikal Bedah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi artikel, serta kegiatan pengabdian masyarakat bidang kesehatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: deviharmita@ners.untan.ac.id

PROFIL PENULIS



Prof. Dr. M. Hasinuddin, S.Kep. Ns. M.Kep Lahir di Sampang, 23 Mei 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S2 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Airlangga tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S3 pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006 di AKBID Ngudia Husada Madura, tahun 2009 menjadi dosen di STIKES

Ngudia Husada Madura dan pada tahun 2024 menjadi dosen di Universitas Noor Huda Mustofa (Perubahan bentuk dari STIKES Ngudia Husada Madura). Saat ini penulis bekerja di Universitas NHM mengampu mata kuliah Keperawatan Anak. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan aktif dalam berbagai organisasi / asosiasi seperti PPNI, AIPNI, IKA Keperawatan Unair, KREKI dan beberapa organisasi lainnya mulai dari Tingkat pusat sampai regional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail hasin3333.nhm@gmail.com
Motto: "Hidup adalah Pengabdian kepada sang Pencipta"



Ns. Prima Yoselina, S.Kep, M.Kep

Seorang penulis dan dosen tetap Program Studi Departemen Keperawatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Lahir di Pariaman tanggal 7 Mei 1982 Provinsi Sumatera Barat. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Naali Arif dan Ibu Mislalita. Menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) di Universitas Andalas Padang dan program Pasca Sarjana (S2) pada prodi Magister Keperawatan peminatan Keperawatan Anak di Universitas Andalas Padang. Riwayat pekerjaan bekerja di Puskesmas Naras Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2006-2012, Puskesmas Sikapak Tahun 2013-2024 dan Departemen Keperawatan Universitas Negeri Padang sejak bulan Juni Tahun 2024-sekarang. Penulis juga bekerja di Stikes Piala Sakti Pariaman sejak Tahun 2006-sekarang sebagai dosen luar biasa. Buku yang telah ditulis dan telah terbit yaitu Kurangnya Minat Masyarakat Pada Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Bayi Post Covid -19 dan Buku Ajar Keperawatan Anak. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yoselina123@unp.ac.id
Motto: Tidak ada usaha yang sia-sia, selama kita terus berusaha."

PROFIL PENULIS



Ns. Delta Aprianti, S.Kep., M.Kep. Lahir di Tanjung Iman pada tanggal 04 April 1991. Pendidikan tinggi yang telah penulis tempuh jenjang Diploma Tiga Keperawatan Poltekkes Kemenkes Curup, jenjang S1 Keperawatan Universitas Dehasen Bengkulu, jenjang Profesi Ners Universitas Dehasen kemudian melanjutkan pendidikan Magister Keperawatan di Universitas Andalas Padang. Saat ini penulis merupakan Dosen Tetap di Prodi Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dehasen Bengkulu.

Mengampuh mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut, keperawatan anak sakit kronis dan terminal, keperawatan kegawatdaruratan anak, keperawatan psikososial dalam keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai ketua dalam penelitian Dosen dan sebagai ketua dalam pengabdian masyarakat Dosen. Penulis pernah menjadi Pengawas Lokal uji kompetensi Profesi Ners. Penulis juga aktif menjadi anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan anggota Ikatan Perawat Anak Indonesia (IPANI). Penulis aktif dalam berbagai seminar baik lokal maupun nasional. Penulis dapat dihubungi melalui email : deltaaprianti9@gmail.com.



Nanin Juliana, S.Kep, Ns.M.K.M., dilahirkan di Medan Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Juli 1985. Penulis dilahirkan oleh seorang ibu yang hebat bernama Sutini, S.Pd dan Ayah yang bijaksana bernama Drs.Abdul rahman, S.Pd . Penulis menempuh pendidikan S1 Universitas Sumatera Utara dan S2 di Institut Kesehatan Helvetia bidang Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Nanin telah menjadi dosen selama 13 tahun dan telah membantu mengajar puluhan ribu mahasiswa; dan pernah menjadi dosen di STIKes Bina Nusantara dan

Politeknik Kesehatan YRSU Dr Rusdi. Cita-citanya membantu negara dan membarakan semangat sumberdaya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia menjadi negara terkuat di dunia tahun 2045 berbasiskan Pancasila dan Cinta Tanah Air. Untuk menghubungi penulis di email: naninjulianasiregar85@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ns. Nita Theresia, S.Kep., M.Kes. Lahir di Barito Utara, 25 September 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu D3 Keperawatan AKPER Notokusumo Yogyakarta Tahun 2003, S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Lambung Mangkurat dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006 diterima sebagai Dosen Prodi DIII Keperawatan Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Palangka Raya. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palangka Raya mengampu mata kuliah Keperawatan Anak dan Maternitas. Dengan lebih dari 19 tahun pengalaman mengajar, penulis telah berkontribusi secara signifikan dalam bidang pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Hasil penelitiannya telah dipublikasikan di berbagai jurnal nasional. Semoga buku ini mampu memberikan nilai tambah, memperkaya pemikiran, dan menginspirasi tindakan yang positif. Jangan ragu untuk terus mengeksplorasi dan memperdalam pengetahuan, karena pembelajaran adalah perjalanan yang tiada henti. Terima kasih telah memilih buku ini sebagai salah satu sumber pengetahuan. Penulis berharap, apa yang telah dituangkan di sini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kita semua pembaca.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nitathere@polkesraya.ac.id

Motto: "Belajar bukan untuk menjadi yang terbaik, tapi untuk menjadi lebih baik dari kemarin."

Sinopsis

Buku Ajar Keperawatan Anak merupakan panduan lengkap yang disusun secara sistematis untuk mendukung mahasiswa maupun praktisi keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan yang optimal kepada anak. Buku ini membahas secara mendalam berbagai aspek esensial dalam keperawatan anak, dimulai dari pemahaman mendasar mengenai filosofi, prinsip, dan ruang lingkup praktik keperawatan anak hingga peran penting perawat dalam mengatasi berbagai tantangan serta isu-isu kontemporer yang dihadapi dalam praktik sehari-hari.

Materi yang tersaji mencakup konsep penting seperti Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), prosedur asuhan keperawatan berdasarkan Neonatus Esensial, serta konsep keperawatan dalam penanganan gangguan eliminasi patologis yang umum terjadi pada bayi dan anak. Selain itu, buku ini juga membahas secara rinci prosedur screening tumbuh kembang anak serta intervensi keperawatan khusus untuk gangguan aktivitas patologis pada sistem persyarafan dan muskuloskeletal, yang disertai panduan jelas mengenai diagnosis dan implementasi tindakan.

Sebagai referensi komprehensif, buku ini tidak lupa mengangkat pembahasan mengenai konsep dan praktik keperawatan anak dengan kebutuhan khusus yang mencakup pengkajian, perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga pentingnya kolaborasi multidisiplin. Penyajian materi yang dilengkapi latihan soal, rangkuman materi, glosarium, dan daftar pustaka di setiap bab akan sangat membantu pembaca dalam memahami dan mengaplikasikan ilmu secara lebih efektif dalam konteks klinis.

Buku Ajar Keperawatan Anak merupakan panduan lengkap yang disusun secara sistematis untuk mendukung mahasiswa maupun praktisi keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan yang optimal kepada anak. Buku ini membahas secara mendalam berbagai aspek esensial dalam keperawatan anak, dimulai dari pemahaman mendasar mengenai filosofi, prinsip, dan ruang lingkup praktik keperawatan anak hingga peran penting perawat dalam mengatasi berbagai tantangan serta isu-isu kontemporer yang dihadapi dalam praktik sehari-hari.

Materi yang tersaji mencakup konsep penting seperti Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), prosedur asuhan keperawatan berdasarkan Neonatus Esensial, serta konsep keperawatan dalam penanganan gangguan eliminasi patologis yang umum terjadi pada bayi dan anak. Selain itu, buku ini juga membahas secara rinci prosedur screening tumbuh kembang anak serta intervensi keperawatan khusus untuk gangguan aktivitas patologis pada sistem persyarafan dan muskuloskeletal, yang disertai panduan jelas mengenai diagnosis dan implementasi tindakan.

Sebagai referensi komprehensif, buku ini tidak lupa mengangkat pembahasan mengenai konsep dan praktik keperawatan anak dengan kebutuhan khusus yang mencakup pengkajian, perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga pentingnya kolaborasi multidisiplin.

Penyajian materi yang dilengkapi latihan soal, rangkuman materi, glosarium, dan daftar pustaka di setiap bab akan sangat membantu pembaca dalam memahami dan mengaplikasikan ilmu secara lebih efektif dalam konteks klinis.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

